

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ MEKONG



**GIÁO TRÌNH
MÔN HỌC: BỆNH HỌC Y HỌC CỔ TRUYỀN
NGÀNH: Y SỸ, Y SỸ YHCT
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP**

Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2024/QĐ-TCQTMK ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Quốc tế Mekong

**Thành phố Cần Thơ, tháng 01 năm 2024
Lưu hành nội bộ**

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình "**Bệnh học Y học cổ truyền**" được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục do Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội ban hành của ngành Y sĩ Y HỌC CỔ TRUYỀN hệ trung cấp. Giáo trình dùng cho các đối tượng học sinh trung cấp, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trung cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường trung cấp y tế.

Nội dung giáo trình bao gồm một số khái niệm cơ bản về lý luận Y học cổ truyền; Sử dụng thuốc nam, châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc để phòng và chữa một số bệnh chứng thường gặp.

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, tổ biên soạn đã cố gắng bám sát khung chương trình đào tạo, cập nhật các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu, nhằm thể hiện được kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn. Trường rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các đồng nghiệp, các độc giả để giáo trình hoàn thiện hơn trong lần ban hành sau.

Xin cảm ơn các cơ quan liên quan, các đơn vị và cá nhân đã tham gia.

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2024

Hiệu trưởng

(đã ký)

DSCKII. Nguyễn Văn Ảnh

LỜI NÓI ĐẦU

Giáo trình **Bệnh học Y học cổ truyền** được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục do Bộ Lao động – Thương Binh & Xã hội ban hành của ngành Y sĩ hệ trung cấp. Giáo trình dùng cho các đối tượng học sinh trung cấp, được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho học sinh trung cấp, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường trung cấp y tế.

Tài liệu này sẽ giúp cho học sinh tính chủ động trong học tập, đáp ứng với phương pháp dạy học tích cực ở trên lớp với những mục tiêu:

- Về kiến thức: Trình bày được một số khái niệm cơ bản về lý luận Y học cổ truyền; Sử dụng thuốc nam, châm cứu và phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc để phòng và chữa một số bệnh chứng thường gặp.

- Về kỹ năng: Nhận định một số bệnh, chứng thường gặp theo Y học cổ truyền; Xây dựng niềm tin và ý thức áp dụng Y học cổ truyền của người cán bộ y tế.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện học sinh nâng cao ý thức tỷ mỷ, cẩn thận trong khi sử dụng các phương pháp điều trị y học cổ truyền. Có thái độ thông cảm, ân cần, niềm nở, động viên tinh thần người bệnh an tâm điều trị.

Trong quá trình biên soạn giáo trình này, tổ đã cố gắng bám sát khung chương trình đào tạo, cập nhật các kiến thức từ nhiều nguồn tài liệu, nhằm thể hiện được kiến thức cơ bản, hiện đại và thực tiễn. Trong quá trình soạn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học, nhà quản lý và giáo viên giảng dạy

TM. Tổ biên soạn

(đã ký)

BSCKI. Nguyễn Trí

MỤC LỤC

BÀI 1. MỤN NHỌT	5
BÀI 1. MỤN NHỌT	5
BÀI 2. VIÊM CỖ	8
BÀI 3. BỆNH CHÀM	9
BÀI 4. SỎI TIẾT NIỆU	13
BÀI 5. BỆNH TRĨ	18
BÀI 6. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM	23
BÀI 7. BONG GÂN	29
BÀI 8. TRẬT KHỚP	33
BÀI 9. RỐI LOẠN KINH NGUYỆT	38
BÀI 10. THỔNG KINH	57
BÀI 11. THIẾU SỮA - TẮC TIA SỮA	61
BÀI 12. BỆNH VIÊM SINH DỤC NỮ	63
BÀI 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ HIỂM MUỘN	67
BÀI 14. ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM HỌC	70

BÀI 1. MỤN NHỌT

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và nguyên nhân bệnh sinh theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.
- Trình bày được biện chứng luận trị, triệu chứng lâm sàng, phương pháp điều trị của bệnh mụn nhọt

Nội dung chính

1. Định nghĩa:

Mụn nhọt (viêm nang lông) bao gồm những mụn mủ nhỏ, nhọn đầu khu trú ở nang lông do vi trùng hoặc nấm gây nên.

2. Nguyên nhân bệnh sinh:

Mụn nhọt là bệnh nhiễm khuẩn ngoài da thường gặp do vi trùng đa số là do tụ cầu vàng. Bệnh phát tập trung ở một vị trí của một cơ thể hay rải rác khắp người, dễ tái phát khỏi mụn này lại phát mụn khác bệnh thường kéo dài quanh năm những vị trí thường hay mọc: ở gáy, mông, nách. Tuổi dễ mắc bệnh là thanh niên, tráng niên (tuổi trẻ). Theo YHCT bệnh phần lớn là do cơ thể có cảm nhiễm thấp nhiệt phong tà làm cho khí huyết ứ trệ mà sinh ra những yếu tố liên quan hay điều kiện thuận lợi dễ mắc bệnh: vệ sinh da kém, ngứa gãi, da bịch kích thích bởi hóa chất, bị cọ xát, tinh thần căng thẳng, lao lực quá sức, mắc bệnh tiểu đường, mắc các bệnh suy giảm miễn dịch.

3. Triệu chứng

Mụn nhọt mọc một chỗ có thể có 5-7 mụn khỏi rồi lại dễ tái phát. Gồm các triệu chứng sau:

3.1. Sưng

Do khí huyết động trệ gây sưng đau, những tình trạng màu sắc của chỗ sưng khác nhau thể hiện tính chất của bệnh

- Sưng tản mạn bệnh thuộc hư.
- Sưng cao đột ngột bệnh thuộc hư.
- Sưng đỏ, nóng rực, cứng ngắc bệnh thuộc hỏa.
- Sưng chỗ da màu xanh tối, cứng như gỗ bệnh thuộc hàn.
- Sưng tại chỗ da thịt nặng trĩu, cố định một nơi bệnh thuộc thấp.
- Sưng nổi phòng, ngứa, hay lan nhanh bệnh thuộc phong.
- Sưng mềm nhũn, không đỏ, không nóng, màu sắc da không đổi bệnh thuộc đàm.
- Sưng sắc hồng tía hoặc xanh bầm bệnh do ứ huyết.

3.2. Đau

Do khí huyết không lưu thông gây đau. Tùy theo nguyên nhân tính chất đau cũng khác nhau

- Đau thuộc hư chịu nắn.
- Đau thuộc thực chối nắn.
- Đau thuộc hàn thì tụ lại, đau buốt.
- Đau thuộc nhiệt da mưng đỏ, đau nhức nhối làm mủ.
- Đau thuộc phong thì đau chạy khắp người rất nhanh. Kèm ngứa nhiều.

3.3. Làm mủ

Do khí huyết suy kém không đẩy được độc ra ngoài, hóa sinh ra mủ, độc khí theo mủ mà tiết ra.

4. Chẩn đoán

Theo YHCT bệnh thường gặp ở 3 thể:

- Khí hư
- Âm hư
- Nhiệt độc

* Cần phân biệt với:

- Nhọt độc: nhọt to hơn, chân rộng hơn, chóp có nhiều đầu mủ, triệu chứng toàn thân nặng hơn như: sốt, ớn lạnh.
- Nhọt mùa hè (thử tiết) thường cùng mọc với rôm sảy phát sinh vào mùa hè, thường gặp ở trẻ em và sản phụ, thời gian bệnh ngắn, có mủ là khỏi không tái phát.
- Mụn trứng cá: mọc nhiều ở mặt và lưng, bắt đầu nổi sần cứng nặn có chất mụn trắng.

5. Điều trị

5.1. Thuốc dùng trong

5.1.1. Nhiệt độc

- Da mọc những nốt tròn cứng sưng không nóng đỏ đau, mềm dần và có đầu mủ vàng, vỡ ra mủ vàng, kèm theo sốt, miệng khát, đại tiện táo, tiểu ít vàng, rêu lưỡi vàng mạch sác.
- Dùng bài thuốc thanh nhiệt giải độc “Ngũ vị tiêu độc ẩm” bao gồm Kim ngân hoa, Cúc hoa, Tử hoa địa đỉnh, Thiên quí tử, Bồ công anh.

5.1.2. Âm hư

- Nhọt mọc rải rác hoặc cố định một chỗ, mọc trước sau liên tục, ăn nhiều chóng đói, miệng khát tiểu nhiều, bứt rứt khó ngủ, lưỡi thon đỏ, mạch hoạt sác nhược.
- Dùng bài thuốc Dưỡng âm thanh nhiệt giải độc, Lục vị địa hoàng hoàn hợp Ngân kiều cam thảo thang bao gồm Sinh địa, Hoài sơn, Đơn bì, Bạch linh, Trạch tả, Sơn thù, Kim ngân hoa, Liên kiều, Cam thảo.

5.1.3. Khí hư

- Mụn nhọt mọc nhiều, sắc đỏ tối, lâu mới có mủ, sưng cứng đau, cơ thể mỏi mệt, chán ăn, hoa mắt, vàng đầu, lưỡi bệu nhạt, mạch hư hoãn.
- Dùng phương Ích khí thác độc, bài thuốc Thác lý tiêu độc tán bao gồm Nhân sâm, Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Bạch truật, Kim ngân hoa, Phục linh, Bạch chỉ, Táo giác thích, Cam thảo, Cát cánh, Hoàng kỳ

5.2. Thuốc dùng ngoài

- Giải độc tiêu sưng: Dùng bài Kim hoàng tán Ngọc lộ tán trộn đắp
- * Hoặc dùng 1-2 vị thuốc sau đây giã đắp như Bồ công anh, Lá phù dung, Lá rau sam, Lá diếp cá, Lá mướp ngọt. Ngày 2 lần.
- Khi nung mủ: Dùng bài thuốc đắp cho vỡ mủ như: Lá xoan, Muối, lượng bằng nhau giã nhỏ trộn đều đắp 2 lần.
- Dùng cao dán hút mủ và lên da có: củ ráy đại 100g, nghệ già 50g, sáp ong 30g, nhựa thông 30g, dầu vừng 500ml, cóc vàng 1 con đốt tồn tính.

+ Cách chế và dùng:

Cho dầu vừng, nghệ, ráy đun sôi đến khi nghệ và ráy teo lại, khuấy tan đều, lấy 1 giọt vào một cái đĩa không lòe ra là được, rửa sạch mụn nhọt bằng nước lá trầu không và kinh giới, phết cao vào một miếng giấy có lỗ chọc thủng ở giữa và dán lên nhọt.

6. Phòng bệnh:

Kiêng các chất cay nóng, dầu mỡ tanh.

Phòng trị bệnh tiểu đường kịp thời.

Vệ sinh da tốt, chú ý tắm nước lá khế, lá trầu không, thay quần áo sạch hàng ngày.

Giữ gìn tinh thần thanh thản, không lao động quá sức, không uống rượu.

Tránh bôi các loại thuốc mỡ.

BÀI 2. VIÊM CƠ

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và triệu chứng của bệnh viêm cơ.
- Nêu phương pháp điều trị viêm cơ theo y học hiện đại và Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Định nghĩa

Viêm cơ là tổn thương có dạng mụn nhọt, mọc ở khoảng giữa bắp thịt, giới hạn rõ.

2. Nguyên nhân

Do khí huyết bị độc tà làm tắc trở không thông gây nên.

Thiên ung thư – Linh Khu nói: “khi doanh vệ bị ngưng lại trong kinh mạch làm cho huyết bị khấp, ắt vệ khí cũng bị tắc theo mà sinh nhiệt. Nhiệt thắng thì nhục bị thối nát mà thành mủ. Tuy nhiên nơi bị bệnh không bị lõm xuống, cốt tủy không bị tiêu khô, ngũ tạng chưa bị tổn thương”.

3. Triệu chứng

Sang thương có dạng mụn nhọt, mọc ở khoảng giữa bắp thịt. Khi mới phát ở ngoài da chưa làm mủ chỉ sưng, nóng, đỏ, đau nhức, giới hạn rõ. Khi chưa làm mủ dễ tiêu. Về sau hóa mủ dễ vỡ, mủ hết dễ gom miệng lại.

Thường gặp ở cổ, móng, đùi, cẳng chân.

Kèm theo sốt cao, khát nước, táo bón, tiểu sền đỏ, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch hồng sắc hữu lực.

4. Điều trị

Chủ yếu là điều trị theo YHHĐ:

4.1. Toàn thân

- Kháng sinh, kháng nấm.
- Kháng viêm.
- Giảm đau, hạ sốt.
- Vitamin liều cao.
- Kiêng ăn ngọt, béo, bia, rượu, thuốc lá.
- Nên ăn thức ăn dễ tiêu, bổ dưỡng.

4.2. Tại chỗ

- Bôi thuốc dạng mỡ kháng sinh.
- Khi mủ đã chín: rạch tháo mủ cho hết, nhét mép hoặc dẫn lưu.
- Khi sạch mủ, vệ sinh hàng ngày, băng lại.

* Thuốc YHCT kết hợp uống phòng chống tái phát:

Bài thuốc:

Sinh địa 12g	Huyền sâm 12g
Địa cốt bì 12g	Sài đất 16g
Kim ngân hoa 12g	Bồ công anh 12g
Cam thảo dây 8g	Thỏ phục linh 12g
Ngày sắc uống 1 thang	

BÀI 3. BỆNH CHÀM

(Thấp sang)

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và triệu chứng của bệnh chàm theo Y học hiện đại .
- Phân loại chàm và phương pháp điều trị theo Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Định nghĩa:

Chàm là loại bệnh tổn thương ngoài da có căn nguyên phức tạp, bao gồm 2 yếu tố: một là do cơ địa dị ứng sẵn có trong cơ thể và hai là tác nhân bên trong hoặc bên ngoài tác động vào yếu tố cơ địa gây nên bệnh

2. Triệu chứng:

Tổn thương cơ bản trên da của chàm là mụn nước và rất ngứa.

Bệnh thường tiến triển qua 5 giai đoạn (nếu không có biến chứng) với các biểu hiện sau:

- Đỏ da.
- Nhiều mụn nước lấm tấm.
- Chảy nước vàng do mụn nước vỡ ra để lại lỗ nhỏ lõm xuống.
- Huyết tương rỉ ra đông thành vảy màu vàng rồi thâm dần, vài ngày sau bong vảy.
- Vảy bong để lại lớp da non màu đỏ, không để lại sẹo.

Nếu có biến chứng, thường gặp là:

- Bội nhiễm: Nhiễm thêm các vi khuẩn khác làm cho tổn thương lây thêm do tăng tiết, vùng tổn thương sưng đỏ, tổng trạng sốt.
- Dày da vùng tổn thương, sừng hóa và da trên tổn thương khô nám

3. Phân loại Chàm

3.1. Phân loại theo hình thể

- Chàm dạng nám: Thường khu trú ở chân, màu đỏ sẫm, trên có mụn nước lấm tấm.
- Chàm dạng viêm quầng: Thương tổn khu trú ở mặt, mí mắt.
- Chàm tổ đĩa: Thương tổn khu trú ở rìa các ngón chân, có thể ở cả lòng bàn tay và chân, mụn nước từ sâu dội lên da, rất ngứa.
- Chàm sừng: Thương tổn khu trú ở lòng bàn tay, bàn chân, vảy dày trắng nứt nẻ, sưng đau, dưới vảy có mụn nước.
- Chàm thể đồng xu: Hình tròn hoặc bầu dục, màu đỏ hồng, trên có mụn nước, vảy tiết, khởi đầu từ chính giữa, khu trú ở tay chân.

3.2. Phân loại theo nguyên nhân

3.2.1. Nguyên nhân bên ngoài

- Chàm tiếp xúc: Do tiếp xúc các yếu tố vật lý, hóa học, thực vật, sinh vật học tác động trực tiếp vào da gây phản ứng viêm da hoặc một số bệnh ngoài da gây ngứa (ghế, nám,...) do chà xát, bôi thuốc linh tinh,... có thể trở thành chàm thứ phát.
- Chàm vi khuẩn: Thường do liên cầu trùng, tổn thương cơ bản là mảng hồng ban giới hạn rõ bởi một đường viền thượng bì.
- Vị trí: ở nếp gấp sau tai, nếp dưới vú, bẹn.
- Chàm ký sinh trùng: Chấy, rận, vi nấm, đặc biệt con cái ghẻ hay gây chàm.

3.2.2. Nguyên nhân bên trong

- Chàm thể tạng: có tính cách gia đình, 70% bệnh nhân có tiền căn cá nhân hay gia đình bị dị ứng, hen suyễn, viêm mũi dị ứng hay chàm thể tạng.

Có hai dạng chính:

+ Chàm sữa: xảy ra ở trẻ em 3-6 tháng tuổi, khỏe mạnh. Khởi đầu là hồng ban, sau đó có mụn nước, rịn nước, đóng mảy và tróc vảy, dễ bị chốc hóa, ngứa. Vị trí ở mặt, 2 má, đối xứng, có thể lan ra da đầu, thân mình, tứ chi, ... nhưng chừa các lỗ thiên nhiên: mắt, mũi, miệng. Bệnh thường biến mất trước 4 tuổi, nếu tới 4 tuổi mà chưa hết có thể tiến triển thành chàm thể tạng ở người lớn. Trước một trẻ bị chàm sữa:

+ Không cho nhập viện vì môi trường bệnh viện có thể làm trẻ bị nhiễm trùng thêm.

+ Không nên chùng ngừa nhất là đậu mùa vì có thể đưa đến mụn mủ dạng thủy đậu: sốt cao, sẩn mụn mủ, bóng nước, trung tâm lõm, cuối cùng thành mụn mủ lõm ở giữa, quanh mụn mủ có viền viêm đỏ lành để lại sẹo như mặt rỗ.

+ Không nên điều trị bằng các thuốc mạnh như corticoid, kháng sinh liều cao.

- Chàm thể tạng ở người lớn: 70% trường hợp do tiến triển tiếp xúc của chàm sữa.

Đặc tính:

+ Sang thương đa dạng: hồng ban, mụn nước, vảy, mảy, vết cào xước, mảng lichen hóa.

+ Đối xứng, chủ yếu ở nếp gấp hay mặt duỗi chi.

+ Bệnh tái đi tái lại nhiều lần.

+ Ngứa nhiều, bệnh nhân gãi làm móng tay lóng bóng.

+ Thường kèm da vảy cá hai cẳng chân (10%)

+ Dày sừng nang long.

Chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào lâm sàng. Ngoài hình ảnh lâm sàng rất đặc trưng kể trên, bệnh nhân có thể có một hay nhiều triệu chứng phụ sau: khô da vảy cá, vảy phấn trắng, chàm nang lông, vết mặt xanh xao, biểu hiện mắt và quanh mắt.

3.2.3. Phân loại theo tiến triển:

- Chàm cấp: Nếu sang thương ở giai đoạn hồng ban và mụn nước, rịn nước

- Chàm bán cấp: Rịn nước vết tích của mụn nước, da bắt đầu tróc vảy

- Chàm mãn: Mảng da dày lichen hóa

4. Y Học Cổ Truyền

4.1. Thấp sang cấp tính (Chàm cấp)

- Khởi bệnh nhanh, tổn thương da đối xứng, có tính nguyên phát và tính đa hình (hồng ban, sẩn bóng nước, mụn nước, mụn mủ, rỉ dịch, đóng mảy. Có thể phát tại bất cứ chỗ nào trên cơ thể hoặc toàn thân nhưng thường phát tại đầu mặt, sau tai, tay chân, âm nang (da bìu), âm hộ, hậu môn.

- Đa số phân bố đối xứng. Bệnh biến thường là dạng mảng hoặc lan toả, ranh giới rõ ràng. Tổn thương da đa số là những mụn sẩn hoặc sẩn mụn nước bằng hạt gạo tập trung dày đặc, đáy tổn thương ửng đỏ (triệu hồng).

- Do gãi cào thì đỉnh tổn thương rỉ nước, loét, đóng mảy, ở giữa tương đối nặng, xung quanh rải rác có những sẩn mụn, hồng ban, sẩn nước, ranh giới không rõ ràng.

- Do gãi cào nhiễm trùng sẽ gây lở loét, rỉ dịch, hóa mủ, đồng thời có thể xuất hiện sưng hạch.

- Nếu không chuyển hóa thành mạn tính thì đợt 1 - 2 tháng sau bong mảy và khỏi.

- Nếu uống rượu, ăn cay nóng phát vật đều có thể làm cho bệnh nặng thêm, thể nặng có thể ảnh hưởng giấc ngủ.

4.2. Thấp sang bán cấp (Chàm bán cấp)

- Thường do thể cấp chuyển thành do không kịp thời điều trị hoặc xử lý thích đáng. Cũng có thể sơ khởi đã xuất hiện thể bán cấp rõ ràng.
- Biểu hiện chủ yếu là sẩn mụn (khâu chần), đóng mảy, vảy khô rụng. Chỉ có một ít mụn nước và lở nhẹ. Cảm giác ngứa dữ dội, ngày nhẹ đêm nặng.

4.3. Thấp sang mạn (Chàm mạn tính)

- Do hai thể trên chuyển thành. Một bộ phận người bệnh sơ khởi đã có biểu hiện chàm mạn.
- Tổn thương da đa số xuất hiện cục bộ tại một nơi nào đó như cẳng chân, tay, hõm khuỷu, hõm khoeo, âm hộ, hậu môn.
- Da nơi tổn thương thường dày thô ráp, sờ hơi cứng, màu đỏ tối hoặc tím nâu, chỉ vẩn da nổi rõ hoặc giống như đài tiên (rêu phủ). Bề mặt tổn thương thường phủ một lớp vảy trắng và sọc cào gãi, mảy máu và lắng đọng sắc tố. Một vài tổn thương có xuất hiện những sẩn bóng mụn nước mới, gãi vỡ sẽ rỉ dịch ít.

Phát sinh tại tay chân hoặc khớp sẽ xuất hiện những nếp nhăn cảm giác đau, ảnh hưởng vận động. Người bệnh cảm giác ngứa từng cơn, đêm về hoặc tinh thần căng thẳng, uống rượu, ăn cay nóng phát vật thì ngứa sẽ nặng thêm. Bệnh trình tương đối dài, hay tái phát, lúc nặng lúc nhẹ.

5. Biện chứng luận trị

Phân loại theo các thể bệnh và điều trị như sau:

5.1. Thể cấp tính

Lúc đầu da hơi đỏ và ngứa, sau một thời gian ngắn, da sẽ nổi cục, có nhiều mụn nước, rất ngứa, loét, chảy nước vàng.

Thuốc uống trong:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| - Thổ phục linh 16g | - Nhân trần 20g |
| - Khổ sâm 12g | - Kim ngân 16g |
| - Hoàng bá 12g | - Ké đầu ngựa 12g |
| - Hạ khô thảo 12g | - Hoạt thạch 8g. |

Nếu mụn nước lan ra toàn thân, ngứa nhưng chảy nước ít. Dùng bài thuốc:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| - Kinh giới 12g | - Sinh địa 16g |
| - Phòng phong 12g | - Thạch cao 20g |
| - Thuyền thoái 6g | - Tri mẫu 8g |
| - Khổ sâm 12g. | |

Thuốc rửa ngoài:

- Tô mộc 30g, Lá trầu 20g

Đun sôi với 1 lít nước và một ít muối, thấm rửa tổn thương rồi hong cho khô ngay.

- Lá khế 100g, Lá kinh giới 100g.

Đun sôi trong nước rồi tắm.

Thuốc bôi:

- Hùng hoàng 5g, Thạch cao 5g

Ngâm với giấm rồi trộn đều, bôi lên chàm.

5.2. Thể mạn tính

Da dày, thô, khô, ngứa và trên vùng tổn thương có nhiều mụn nước, hay gập ở cổ chân, cổ tay, khuỷu tay và nhượng chân.

Thuốc uống:

- | | |
|-------------------|------------------|
| - Hoàng bá 12g | Thương truật 8g |
| - Ké đầu ngựa 12g | Phù bình 12g |
| - Phòng phong 8g | Bạch tiểu bì 12g |

- Hy thiêm thảo 12g.

Thuốc rửa:

- Lá khế 100g, Lá kinh giới 100g

Đun sôi, rửa vết chàm loét.

Thuốc mỡ:

- Xuyên hoàng liên 4g, Hồng hoa 4g
- Hồng đơn 4g, Chu sa 4g.

Tán thành bột hòa với mỡ trăn, bôi vào tổn thương, sau đó rửa sạch bằng thuốc rửa trên.

6. Châm cứu

Tùy thuộc vào vị trí tổn thương, chọn huyệt tại chỗ và lân cận như:

- Ở tay: châm huyệt Khúc trì, Hợp cốc.
- Ở chân: châm huyệt Tam âm giao, Dương lăng tuyền...
- Toàn thân: châm huyệt Hợp cốc, Túc tam lý, Huyết hải.

BÀI 4. SỎI TIẾT NIỆU

(Thạch lâm)

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và nguyên nhân bệnh sinh theo YHCT của bệnh thạch lâm.
- Nêu phương pháp điều trị sỏi thận theo y học hiện đại và Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Đại cương.

- Bình thường trong nước tiểu có các chất hòa tan như canxi, phosphat, oxalat... Khi nồng độ các chất trên cao vượt quá “ngưỡng”, trong điều kiện lý hóa nhất định nếu gặp những yếu tố thuận lợi thì sẽ tạo thành sỏi niệu.

- Sỏi niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo.

1.1. Định nghĩa:

- Sỏi tiết niệu là một bệnh thường gặp và hay tái phát ở đường tiết niệu do sự kết thạch của một số thành phần trong nước tiểu ở điều kiện lý hóa nhất định.

- Sỏi gây tắc nghẽn đường tiết niệu mà hậu quả có thể dẫn đến ứ nước thận và hủy hoại tổ chức thận, gây nguy hiểm và gây đau ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mệnh của người bệnh.

1.2. Đặc điểm dịch tễ học:

- Theo GS Ngô Gia Hy:

Ở VN sỏi thận chiếm 40%, sỏi niệu quản 28,27%, sỏi bàng quang 28,3%, sỏi niệu đạo 5,4 % trong tổng số bệnh nhân sỏi nói chung.

Sỏi niệu ở nam nhiều gấp 2 lần ở nữ và thường gặp nhiều ở tuổi trên 30.

- Ở Việt Nam sỏi amino – magne phosphat chiếm tỉ lệ cao kèm theo nhiễm khuẩn.

1.3. Phân loại sỏi niệu theo YHCT:

- Sỏi niệu được mô tả trong chứng “Thạch lâm” của YHCT.

- Thạch lâm mang ý nghĩa là tiểu ra sỏi, chứng Thạch lâm là một trong năm chứng bệnh liên quan đến rối loạn tiết niệu được YHCT gọi là Ngũ Lâm.

Ngũ Lâm bao gồm: Huyết lâm, Thạch lâm, Cao lâm, Lao lâm và Lâm lậu.

- Trong nước tiểu có hiện diện những viên sỏi lớn gọi là Thạch lâm (nếu sỏi nhỏ gọi là Sa lâm).

- Biểu hiện của Thạch lâm là bụng dưới đau co cứng, một bên thắt lưng đau quặn, đau ran xuống bụng dưới và bộ phận sinh dục, tiểu tiện khó đau buốt khó đi, nước tiểu có khi vàng đục có khi ra máu, xó khi ra lẫn sỏi cát.

- Nguyên nhân do thấp nhiệt nung nấu ở hạ tiêu khiến ngưng kết trong nước tiểu và gây bệnh.

2. Nguyên nhân bệnh sinh

2.1. Theo YHCT:

- Theo YHCT Sỏi niệu được đề cập trong các bệnh chứng Thạch lâm, Huyết lâm, Nhiệt lâm; nguyên nhân bệnh sinh chính là do thấp nhiệt kết ở hạ tiêu.

- + Theo sách Nội kinh:

- Tỳ thấp làm đàm ứ lại, lâu ngày đàm hóa hỏa, hỏa sinh nhiệt hạ tiêu làm chung kết nước tiểu, do đó cặn lắng kết tụ lại mà thành thạch.

- + Theo sách Tuệ Tĩnh toàn tập:

- Sỏi niệu do thận khí hư làm hủy hỏa mất điều hòa, hỏa của tâm đi xuống hạ tiêu chung khô nước tiểu mà thành Thạch, ví như cặn kết ở đáy nồi khi đun nấu lâu ngày.

- Thận âm hư sinh nội nhiệt, nội nhiệt làm hư hao tân dịch, tiểu xển.
- Thấp nhiệt hạ tiêu: Thấp tà, nhiệt tà xâm phạm hạ tiêu (viêm đường tiết niệu), nhiệt kết bàng quang làm hư hao hủy dịch, căn lắng kết lại sinh sỏi.
- Bệnh tật nằm lâu bất động, khí huyết ứ trệ, thủy dịch kém được lưu thông căn có điều kiện kết lắng mà thành sỏi.

Như vậy có thể tóm lược các nguyên nhân bệnh sinh của chứng thạch lâm là:
Thấp nhiệt hạ tiêu, khí huyết ứ trệ và thận dư.

3. Chẩn đoán sỏi niệu theo yhct

Thường gặp trên lâm sàng gồm 3 thể:

3.1. Thể thấp nhiệt

Tương ứng với sỏi niệu có viêm nhiễm kèm theo, có các triệu chứng:

- Đau từ eo lưng lan xuống đùi và sinh dục ngoài.
- Tiểu vàng xển, đờ đục, nóng rát ống tiểu, tiểu nhiều lần, có thể tiểu ra sỏi.
- Gai sốt hoặc ớn lạnh.
- Miệng khô khát.
- Lưỡi đỏ, rêu vàng.
- Mạch sắc.

3.2. Thể khí huyết ứ trệ

Tương ứng với sỏi niệu tiểu máu, có triệu chứng:

- Tiểu đau tức và cảm thấy nặng trước âm nang, tiểu máu đỏ tươi, tiểu không hết.
- Nước tiểu vừa có máu vừa đục.
- Lưỡi có điểm ứ huyết.
- Mạch khẩn.

3.3. Thể thận hư

Tương ứng sỏi niệu có biến chứng, triệu chứng thường gặp:

- Tiểu ít, đục có mủ, bệnh âm i sốt kéo dài.
- Người mệt mỏi, bụng chướng, hoặc phù thũng. Sắc mặt trắng bệch.
- Lưỡi nhợt bệu, rêu trắng dính.
- Mạch tế sắc vô lực.

4. ĐIỀU TRỊ

4.1. Nguyên tắc chung

Giảm đau khi đã chẩn đoán cụ thể

- Kháng sinh chống viêm nhiễm khi cần thiết
- Thay đổi pH nước tiểu, uống nhiều nước (> 2 lít/ ngày) để chống hình thành sỏi ra.

- Chế độ ăn phù hợp.
- Chỉ định phẫu thuật khi viên sỏi lớn điều trị nội khoa không kết quả, sỏi có biến chứng...

Điều trị nội khoa nhằm giải quyết nguyên nhân và cơ chế tạo sỏi, có tác dụng hạn chế tái phát sỏi, giảm bớt các chỉ định ngoại khoa và tránh các biến chứng khác ngoài thận.

4.2. Theo YHCT

4.2.1. Thể thấp nhiệt

Phép trị: Thanh nhiệt bài thạch, trừ thấp lợi niệu.

Phương dược:

Bài thuốc nam kinh nghiệm dân gian:

Kim tiền thảo 40g

Xa tiền tử 20g

Uất kim 16g

Ngưu tất 10g

* Bài cổ phương:

Xích đạo tán gia vị:

Sinh địa 12g

Trúc diệp 16g

Xa tiền tử 10g

Mộc thông 16g

Cam thảo tiêu 10g

* Gia thêm:

Kim tiền thảo 20g

Kê nội kim 10g

Sắc uống ngày 1 thang.

Phân tích bài thuốc:

Vị thuốc	Dược tính – Công dụng	Vai trò
Sinh địa	Ngọt lạnh, vào can thận. Bổ dưỡng âm thanh nhiệt, dưỡng huyết	Quân
Kim tiền thảo	Mặn bình, vào thận bàng quang. Làm tan sỏi	Quân
Trúc diệp	Ngọt nhạt hàn, vào kinh tâm tiểu trường. Thanh tâm hỏa lợi niệu	Thần
Mộc thông	Đắng hàn vào thận bàng quang. Giáng hỏa lợi tiểu tiện thông huyết mạch	Thần
Cam thảo	Ngọt bình, thanh nhiệt giải độc điều hòa vị thuốc	Tá – Sứ
Xa tiền tử	Ngọt hàn thanh phế, khí thẩm, khí bàng quang	Tá
Kê nội kim	Ngọt bình vào kinh phế tỳ. Tiêu thủy cốc, lý tỳ vị, chữa tiêu máu, mun nhọt	Tá

4.2.2. Thể khí huyết ứ trệ

Phép tri: Lý khí hành trệ, thông lâm bài thạch

Phương được

* Bài thuốc nam:

Đào nhân 8g

Uất kim 8g

Ngưu tất 8g

Chỉ xác 6g

Kim tiền thảo 20g

Xa tiền tử 12g

Kê nội kim 8g

Ý dĩ 20g

Bạch mao căn 16g

Ngưu tất 8g

Bài thuốc cổ phương:

Huyết phủ trực ứ thang

Đương quy 12g

Sinh địa 8g

Đào nhân 8g

Hồng hoa 8g

Chỉ xác 6g

Xích thực 8g

Sài hồ 8g

Cam thảo 4g

Xuyên khung 8g

Người tất 8g

* Gia thêm:

Kim tiền thảo 20g

Hạ liên thảo 20g

Sắc uống ngày một thang

Phân tích bài thuốc:

Vị thuốc	Được tính – Công dụng	Vai trò
Đào nhân	Ngọt đắng bình vào kinh Can Thân Tỳ. Hoạt huyết thông lâm	Quân

Kim tiền thảo	Mặn bình, vào thận bàng quang, tán kết. Làm tan sỏi mật, sỏi niệu	Quân
Hồng hoa	Cay ấm vào kinh Can Tỳ. Tán phá ứ, hành huyết	Quân
Đương quy	Ngọt cay ấm vào Tâm Can Tỳ. Hành huyết, hoạt huyết	Thần
Xích thược	Đắng hàn vào kinh Can Tỳ Phế	Thần
Chỉ xác	Đắng bình vào kinh Phế Tỳ. Lý khí hòa trung	Tá
Xuyên khung	Cay ôn vào kinh Phế đại trường. Khu phong hoạt huyết chỉ thống	Tá
Cam thảo	Ngọt bình vào Can đởm Tỳ Vị. Kiện Tỳ Vị điều hòa các vị thuốc	Tá – Sứ
Ngưu tất	Đắng bình vào kinh vào Can Thận. Bổ Can Thận, hành khí xuống	Tá
Sài hồ	Đắng lạnh vào Can đởm tâm tam tiêu. Tả nhiệt giải độc thăng đề	Tá
Hạ liên thảo	Ngọt chua lương vào Can Thận. Bổ thận chỉ huyết ly, tiêu máu	Tá

4.2.3. Thể thận hư

Phép trị: Bổ thận lợi niệu thông lâm

Phương dược:

Bài thuốc nam kinh nghiệm dân gian:

Dây tơ hồng 30g	Thỏ phục linh 20g
Củ mài 30g	Tỳ giải 30g
Mã đề 16g	Hạt sen 30g

* Bài thuốc cổ phương:

Tế sinh thận khí hoàn gia vị (Tế sinh phương)	
Phụ tử 8g	Thục địa 16g
Hoài sơn 12g	Sơn thù 12g
Đơn bì 12g	Phục linh 12g
Trạch tả 8g	

* Gia thêm:

Kim tiền thảo 20g	Xa tiền tử 16g
Tán bột làm hoàn, ngày uống 30g	

Phân tích bài thuốc:

Vị thuốc	Dược tính – Công dụng	Vai trò
Phụ tử	Ngọt độc rất nóng. Bổ hỏa trợ dương, trục hàn thấp	Quân
Kim tiền thảo	Mặn bình, làm tan sỏi	Quân
Thục địa	Ngọt ấm vào kinh Can Thận Tỳ. Bổ thận, bổ huyết	Quân
Hoài sơn	Ngọt nhạt bình vào kinh Tỳ Vị. Bổ Tỳ Vị Phế Thận kinh tân	Thần
Sơn thù	Chua, hơi ôn, vào kinh Thận bàng quang. Bổ thận sáp tinh	Thần
Đơn bì	Đắng hàn vào Thận Can đởm. Thanh huyết nhiệt, tán huyết ứ	Tá
Phục linh	Ngọt bình vào kinh Can Thận Tỳ. Lợi thủy thẩm thấp bổ tỳ định tâm	Tá
Trạch tả	Ngọt mát vào kinh Thận bàng quang. Thanh tả thấp nhiệt bàng quang, lợi thủy	Tá – Sứ
Xa tiền tử	Ngọt hàn vào kinh Thận, Phế bàng quang. Thanh Phế thẩm khí	Tá

	bảng quang	
--	------------	--

BÀI 5. BỆNH TRĨ

(Hạ trĩ, Đại tràng thấp nhiệt)

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Nêu cách phân loại bệnh trĩ.
- Nêu chẩn đoán thể lâm sàng và điều trị hạ trĩ theo Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Đại cương.

1.1. Khái niệm chung về bệnh trĩ:

1.1.1. Bệnh trĩ đã được phát hiện từ rất sớm và cũng có rất nhiều phương pháp điều trị. Nhưng về nguyên nhân của bệnh trĩ được nhiều tác giả đề cập đến nhưng chưa có sự thống nhất:

- Theo GS. Nguyễn Xuân Huyền: trĩ không phải là một bệnh lý mà là một tổ chức sinh lý bình thường, tổ chức huyết quản ở vùng hậu môn (đám rối động, tĩnh mạch) cương tụ, giãn thành búi, gây đau, chảy máu, sa ra ngoài.

- Nhiều tác giả khác coi trĩ là bệnh lý của hệ mạch vùng hậu môn, trực tràng. Cụ thể là bệnh lý của đám rối tĩnh mạch trĩ, với hai triệu chứng điển hình thường xuyên đó là: cương tụ, sa giãn và chảy máu.

1.1.2. Theo YHCT quan niệm: phạm các lỗ các hốc lỗ tự nhiên trong cơ thể con người mọc ra một cục thịt thừa đều gọi là trĩ (Trung y học khái luận). Ví dụ: nhĩ trĩ (trĩ tai), ty trĩ (trĩ mũi), hậu môn trĩ (trĩ hậu môn),...

Theo Nội kinh: có 5 loại trĩ (mẫu trĩ – tàn trĩ – khí trĩ – tửu trĩ – huyết trĩ)

Theo sách Đại thành ngoại khoa (kỳ khôn đời Càn Long) gồm 24 thứ trĩ.

Bài viết này chỉ đề cập đến bệnh trĩ hậu môn.

1.2. Phân loại bệnh trĩ:

1.2.1. Phân loại trĩ theo hệ mạch

- Trĩ ngoại:

Được da che phủ

Hình thành từ đám rối tĩnh mạch trĩ dưới

Nằm dưới đường lược

- Trĩ nội:

Được niêm mạc che phủ

Hình thành từ đám rối tĩnh mạch trĩ trên

Nằm trên đường lược

- Trĩ hỗn hợp:

Là sự kết hợp của trĩ nội và trĩ ngoại

- Trĩ vòng:

Do nhiều búi trĩ liên kết lại với nhau giữa những khoảng phù nề vòng quanh hậu môn

1.2.2. Phân loại theo mức độ

Chỉ có trĩ nội mới được phân độ - có 4 độ:

- Độ 1: Đại tiện ra máu tươi khi nội soi hậu môn hoặc khám trong mới phát hiện được búi trĩ nhú lồi vào trong lòng trực tràng.

- Độ 2: Có thể đại tiện ra máu hoặc không.

Bó trĩ sa ra ngoài hậu môn khi đi đại tiện, đại tiện xong búi trĩ tự co lên.

- Độ 3: Đại tiện có hoặc không có máu. Bó trĩ sa ra ngoài phải dùng tay đẩy mới lên.

- Độ 4: Bó trĩ nằm ngoài hậu môn thường xuyên, đẩy lên lại sa xuống. Thê này thường dễ bị viêm nhiễm, gây tắc nghẹt.

2. Nguyên nhân bệnh sinh.

2.1. Theo YHCT:

Theo quan niệm chung của YHCT mô tả các chứng trĩ đều do nhiệt sinh ra.

Như vậy, nguyên nhân bệnh sinh của trĩ theo YHCT là do:

- Nhiệt kết đại trường

Tuệ Tĩnh cho rằng do ẩm thực nhiều chất cay nóng, uống nhiều rượu nồng thit nướng làm cho Tỳ Vị mất điều hòa, đại trường tích tụ nhiệt.

Nhiệt kết đại trường làm hư hao tân dịch, phân bón kết, đại tiện phải rặn nhiều dẫn đến huyết ứ nơi giang môn sa trệ thành Trĩ.

- Thấp nhiệt hạ tiêu

Người bệnh cảm nhiễm phải Thấp tà, nhiệt tà, sinh chứng kiết lị: đau bụng, tiêu nhiều lần, thấp nhiệt hạ tiêu biểu hiện bằng tiêu nhày máu, mót rặn, mặt khác nhiệt độc bức huyết vong hành (huyết chạy lạc đường) sinh chứng tiêu máu.

- Khí huyết hư

Ở những người lớn tuổi hoặc bệnh tật kéo dài, tiên thiên bất túc hậu thiên không đầy đủ...làm cho khí huyết suy tổn, hư nhược.

Những người lao động cực nhọc, gắng sức.

Ăn uống kham khổ Tỳ vị hư nhược.

Trĩ sinh bệnh theo cơ chế: Tỳ khí hư sinh hạ hãm + Khí hư làm huyết trệ.

2.2. Yếu tố thuận lợi

Bệnh trĩ còn gặp nhiều hơn ở những người bệnh gặp các điều kiện thuận lợi khác như Thai kỳ, Táo bón, xơ gan, nghề nghiệp đứng, ngồi nhiều, người có thói nín nhịn đi cầu, sinh hoạt thiếu điều độ trong ăn uống, thức đêm, vệ sinh kém...

3. Chẩn đoán bệnh trĩ theo yhct

Trên lâm sàng bệnh trĩ được YHCT phân chia thành 3 bệnh cảnh:

3.1. Huyết ứ

- Bó trĩ căng phồng, màu đỏ sẫm.

- Trĩ đau nhức, trĩ lâu ngày thì chai cứng.

- Hậu môn đau nhức, đau tăng khi đại tiện.

- Đại tiện bón, phân dính máu, hoặc chảy máu tươi.

- Rêu lưỡi mỏng, chất lưỡi đỏ, có điểm ứ huyết, mạch khẩn mà sáp.

3.2. Thấp nhiệt

- Cảm giác nóng, bức rức, ăn uống kém.

- Họng khô miệng khát, thích uống nước mát.

- Búi trĩ sưng, màu hồng, ướt, thường xuyên rỉ dịch màu vàng, dính.

- Hậu môn nóng rát, ngứa, mót rặn. Đại tiện nhiều lần, khi bón khi lỏng.

- Lưỡi đỏ, rêu vàng. Mạch hoạt sáp.

3.3. Khí huyết hư

- Bệnh thường gặp ở những người có bệnh kéo dài, hoặc tích tuổi, khí huyết hư nhiệt.

- Người mệt mỏi. Bì phu xanh xao.

- Tiếng nói nhỏ, đoản hơi, mệt mỏi ngại vận động.

- Trĩ sa giãn nhiều, màu trắng nhợt nhạt có thể kèm với hạ hãm.

- Chất lưỡi nhợt, rêu dày. Mạch tế sắc vô lực.

4. Điều trị

4.1. Nguyên tắc chung

Vệ sinh tại chỗ: ngâm rửa hậu môn bằng nước ấm pha muối 1-2 lần/ ngày.

4.1.1. Điều trị triệu chứng:

- Giảm đau có thể dùng thuốc tại chỗ hoặc toàn thân, tại chỗ có các loại mỡ bôi hay tọạ được.

- Chống chảy máu.
- Chống tắc nghẽn mạch.
- Nhuận trường.

4.1.2. Điều trị nguyên nhân:

- Chống táo bón bằng ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước buổi sáng.
- Xóa bỏ những thói quen không có lợi như rượu, trà, cà phê, thói quen nín nhịn đi cầu.

- Nên:

- + Tập thói quen đi cầu mỗi ngày vào 1 giờ nhất định.
- + Cải thiện công việc làm nếu phải đứng, ngồi nhiều.
- + Tập thể thao, dưỡng sinh, bơi lội,...
- Điều trị bằng phương pháp cơ học: Chích xơ, đông lạnh, băng thun,...
- Điều trị bằng phẫu thuật: có chỉ định khi xác định.
 - + Trĩ hỗn hợp, trĩ nội độ IV, trĩ ngoại.
 - + Điều trị nội khoa không kết quả.
 - + Hoặc có đường rò hậu môn trực tràng (mạch lươn).

4.2. Theo YHCT

4.2.1. Bệnh cảnh Huyết ứ

Phép trị: Hoạt huyết – khứ ứ - chỉ huyết, nhuận táo.

Phương dược: Tứ Vật Hồng Đào gia giảm

Xuyên khung 12g	Đương quy 12g
Hồng hoa 8g	Bạch thược 12g
Đào nhân 8g	Sinh địa 12g
Dấp cá 20g	Đại hoàng 6g

Nếu có chảy máu nhiều, gia Cỏ mực 20g, Trắc bá sao 20g (sao cháy đen).

Nếu có táo bón nhiều, gia Mè đen 20g, lá Muồng trâu 12g.

Vị thuốc	Dược tính – Công dụng	Vai trò
Hồng hoa	Cay, ấm, phá huyết ứ	Quân
Đào nhân	Đắng, ngọt, bình, phá huyết ứ, nhuận táo, hoạt trường	Quân
Xuyên khung	Hoạt huyết, chỉ thống, hành khí hoạt huyết	Thần
Đương quy	Cay, ôn, bổ lý, hoạt huyết, nhuận táo hoạt trường, điều huyết thông kinh	Thần
Bạch thược	Đắng, chất, chua vào can đởm, nhuận gan, dưỡng huyết, liễm âm	Tá
Dấp cá	Tán nhiệt tiêu thũng, chữa bệnh trĩ	Tá
Sinh địa	Ngọt, đắng, hàn, lương huyết, sinh tân dịch	Tá

4.2.2. Bệnh cảnh Thấp nhiệt

Phép trị: Thanh thấp nhiệt, nhuận táo chỉ thống.

Phương dược: Chỉ Thống Thang gia giảm.

Hoàng bá 12g	Hoàng liên 12g
Đương quy 8g	Đào nhân 8g

Xích thước 12g Trạch tả 8g
 Sinh địa 12g Đại hoàng 6g
 Dấp cá 12g

Vị thuốc	Dược tính – Công dụng	Vai trò
Hoàng bá	Đắng, lạnh, vào hạ tiêu, tả hỏa thanh thấp nhiệt	Quân
Hoàng liên	Đắng, lạnh, vào tỳ vị đại trường, tả âm hỏa, giải khí bản nhiệt	Thần
Đào nhân	Đắng, ngọt, bình, hành úr, phá huyết, nhuận táo, hoạt trường	Tá
Sinh địa	Ngọt, đắng, hàn, lương huyết, sinh tân dịch	Tá
Xích thước	Đắng chua lạnh hàn phá huyết	Tá
Đương quy	Cay, ôn, bổ lý, hoạt huyết, nhuận táo hoạt trường, điều huyết thông kinh	Tá
Đại hoàng	Đắng lạnh nhuận hạ	Tá
Trạch tả	Ngọt nhạt mát thanh tả thấp nhiệt	Tá
Dấp cá	Cay, ôn, bổ lý, hoạt huyết, nhuận táo hoạt trường, điều huyết thông kinh	Tá

4.2.3. Bệnh cảnh Khí huyết hư

Phép trị: Bổ khí huyết thăng đề

Phương dược: Bát Trân gia vị

Đảng sâm 12g Bạch truật 12g
 Bạch linh 12g Xuyên khung 12g
 Đương quy 16g Hoàng kỳ 16g
 Thục địa 16g Thăng ma 12g
 Bạch thước 12g Cam thảo 8g
 Dấp cá 12g

Vị thuốc	Dược tính – Công dụng	Vai trò
Đảng sâm	Ngọt, đắng vào phế tỳ vị. Bổ nguyên khí	Quân
Hoàng kỳ	Ngọt, ấm vào tỳ phế, bổ khí, thăng dương khí của tỳ, lợi thủy, chỉ hãn	Thần
Đương quy	Cay, ngọt, ôn, bổ huyết điều khí, hoạt huyết thông kinh	Quân
Thục địa	Ngọt, ẩm, vào tỳ vị can, bổ huyết	Thần
Thăng ma	Kiên tỳ hóa đàm, táo thấp thăng đề	Tá
Bạch thước	Đắng, chua, hơi hàn. Dưỡng huyết liễm âm, lợi tiểu, nhuận gan	Tá
Bạch truật	Ngọt, hơi ẩm vào tỳ vị. Kiên tỳ táo thấp	Tá
Xuyên khung	Hoạt huyết chỉ thống, hành khí khu phong	Tá
Bạch linh	Ngọt, nhạt, bình lợi thủy, thẩm thấp kiện tỳ	Tá
Cam thảo	Ngọt, bình bổ tỳ vị nhuận phế thanh nhiệt, điều hòa vị thuốc	Sứ
Dấp cá	Lạnh vào phế, tán nhiệt tiêu thũng chữa trĩ	Tá

Bài thuốc chữa trĩ:

Dấp cá 40g Cây dền gai 40g

Cây tươi rửa sạch, đun sôi kỹ với 2 lít nước pha 1 muỗng cà phê muối.

Ngâm hậu môn nước muối loãng ấm (1 lít nước + 1 muỗng cà phê muối, ngâm 20 phút) ngày 1-2 lần, trong 7 ngày.

5. Phòng bệnh

5.1. Phòng phát sinh và tái phát trĩ

Giải quyết và triệt để những nguyên nhân sinh trĩ:

- + Chống táo bón
- + Vệ sinh hậu môn

Xóa bỏ những thói quen dễ làm phát sinh bệnh như nín nhịn đi cầu, cải thiện điều kiện làm việc khi phải ngồi nhiều hay đứng nhiều quá.

Chữa trị kịp thời khi mới có triệu chứng của bệnh trĩ như tiêu ra máu, ngứa nhọt, cảm giác vướng nặng ở hậu môn,... bằng cách thường ngày ăn rau dấp cá (ăn sống hoặc nấu canh), ngâm hậu môn bằng nước muối loãng ấm có pha ít muối ngày 1 lần trước lúc ngủ tối.

5.2. Phòng biến chứng và di chứng bệnh trĩ

Giữ vệ sinh để phòng viêm nhiễm dẫn đến áp xe vùng hậu môn. Áp xe là nguyên nhân tạo nên đường rò (mạch lươn).

Chỉ định điều trị đúng, kỹ thuật thành thạo mới được thực hiện các thao tác, thủ thuật.

Nong hậu môn khi có chít hẹp hậu môn.

Khâu cầm máu.

BÀI 6. VẾT THƯƠNG PHẦN MỀM

(Sang thương)

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Phân loại vết thương phần mềm.
- Trình bày được quá trình làm liền vết thương.
- Điều trị vết thương phần mềm theo YHHĐ và YHCT.

Nội dung chính

1.Đại cương.

1.1.Định nghĩa:

Vết thương phần mềm là chỉ các tổn thương do thương tích gây rách da, đó là các tổn thương xảy ra ở mô liên kết dưới da, gân và cơ.

Vết thương phần mềm có thể chỉ là những vết thương cắt gọn, cũng có thể là các vết thương dập nát.

1.2.Phân loại:

1.2.1.Vết thương đâm chọc nhỏ: (vết thương loại 1)

Tác nhân gây ra vết thương này là các vật nhọn.

-Tổn thương:

Tổn thương giải phẫu không đáng kể. Vết rách da nhỏ nhưng tùy theo chiều dài của vật nhọn gây thương tích mà có tổn thương đi sâu vào các tổ chức mô mềm gây ra sự lan truyền nhiễm trùng từ ngoài vào các lớp mỡ, cơ khoang kín.

- Vấn đề quan tâm:

Nhiễm trùng:

Là nguy cơ chính thường xảy ra trong loại vết thương này, nhưng nó tùy thuộc vào độ sâu của tổn thương, vào cấu trúc và tính chất của dị vật, vào nơi xảy ra vết thương, vào thời điểm được xử trí đúng, nhiễm trùng nặng nếu tổn thương sâu, do súc vật cắn, vết thương đâm chọc của công nhân vệ sinh (người tiếp xúc với phân, rác,...). Các phẫu thuật viên, nhân viên y tế nếu bị thương cũng là người có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Đau nhức:

Do sự tồn tại của dị vật trong mô mềm gây nên đau nhức vùng vết thương. Nếu dị vật không được lấy ra, đau nhức càng tăng. Nó cũng chính là tác nhân gây ra nhiễm trùng.

Nhiễm trùng uốn ván:

Cũng thường xảy ra, mặc dù thời gian ủ bệnh kéo dài nhưng hậu quả vô cùng trầm trọng.

Nguy cơ bị nhiễm HIV:

Phẫu thuật viên và nhân viên y tế điều trị cho các bệnh nhân có HIV (+), nghiện ngập ma túy....vô ý để bị thương cũng có thể bị lây nhiễm HIV.

1.2.2. Các vết cắt gọn: (vết thương loại 2)

- Tác nhân gây ra là các vật sắc bén như dao, máy cắt công nghiệp, mảnh kính, tấm tole,...Vết thương có thể xảy ra ở người nội trợ, công nhân và phẫu thuật viên...

- Tổn thương giải phẫu ở mức độ đáng kể. Vết rách da có thể rộng và sâu, tổn thương mô dưới da và cơ gây ra sự chảy máu vết thương.

- Vấn đề quan tâm:

* Ngoài những nguy cơ như vết thương đâm chọc nhỏ, còn có 4 vấn đề đặt ra:

Cấp cứu: phải làm ngừng chảy máu

Chẩn đoán: phải liệt kê đầy đủ các mô bị tổn thương
Điều trị: phải phục hồi cả về giải phẫu và chức năng
Theo dõi: tránh phù nề và nhiễm trùng vết thương

1.2.3. Vết thương tróc da:

1.2.3.1. Tróc da không hoàn toàn:

- Nguyên nhân:

Là sự tróc da của một vật da do một va chạm móc vào da theo hướng tiếp tuyến với mặt da. Da bị tróc còn dính bằng một cuống có chiều rộng tùy theo vết thương. Có khi là một tróc da ngầm, vết rách da nhỏ nhưng cả một vùng da rộng rộng bị tróc bởi chấn thương đè trực tiếp và lăn xoắn trên da. Các vết thương này rất thường gặp trong tai nạn giao thông (xe cán vào chi nhưng không cán qua và bánh xe bơm không căng).

- Tổn thương:

Vùng tổn thương thường gặp là da đầu (tai nạn máy đuôi tôm ở nông thôn), lưng, tứ chi (bàn tay, đùi, cẳng chân). Thương tổn chỉ là da và mô dưới da. Nhưng cũng có khi tới cơ và màng xương.

- Vấn đề quan tâm:

Nguy cơ nhiễm trùng vết thương rất cao.

Nguy cơ hoại tử cuống da do hiện tượng thuyên tắc động mạch rải rác do sự lưu thông máu trong vật da bị giới hạn ở động mạch của cuống da và giảm xuống rất nhanh bởi sự đông tụ máu trong thành mạch.

Hoại tử các tổ chức dưới da: nếu không dùng vật che phủ kịp thời các tổ chức dưới da thì sự hoại tử các tổ chức này sẽ xảy ra.

1.2.3.2. Tróc da hoàn toàn: Là một mảng da bị tróc ra hoàn toàn khỏi cơ thể.

- Nguyên nhân:

Gặp nhiều trong tai nạn lưu thông và lao động.

- Tổn thương:

Vùng bị tổn thương thường là tróc da đầu, tróc da ở đầu cuối của các đốt ngón tay, ngón chân,...tróc da mặt trước cẳng chân...

- Vấn đề quan tâm:

Nhiễm trùng cao.

Hoại tử tổ chức dưới da.

Choáng chấn thương.

1.2.4. Vết thương giập nát: (vết thương loại 3)

- Nguyên nhân:

Thường gặp trong tai nạn lao động (nhất là lao động công nghiệp phát triển), trong tai nạn lưu thông (tốc độ càng cao tai nạn càng trầm trọng). Trong chiến tranh, vết thương do bom đạn rất trầm trọng. Theo lý thuyết về sự truyền năng lượng trong môi trường lỏng của Bush: “Các mô mềm của cơ thể gồm một tỉ lệ khá lớn các chất dịch nên thực tế có thể coi như một môi trường lỏng, năng lượng dư thừa của viên đạn sau khi xuyên thủng mô mềm chung quanh trên đường đi của viên đạn. Các phần tử đó tạo nên hàng triệu viên đạn thứ phát tiếp tục mở rộng sự phá hủy mô mềm xung quanh và gây ra rất nhiều góc ngách”. Do đó vết thương sẽ gây ra những tổn thương nhiều hơn những gì mà mắt thường nhìn thấy.

- Tổn thương:

Tổn thương giải phẫu trầm trọng. Thường kèm theo các tổn thương khác như gãy xương, mạch máu, thần kinh.

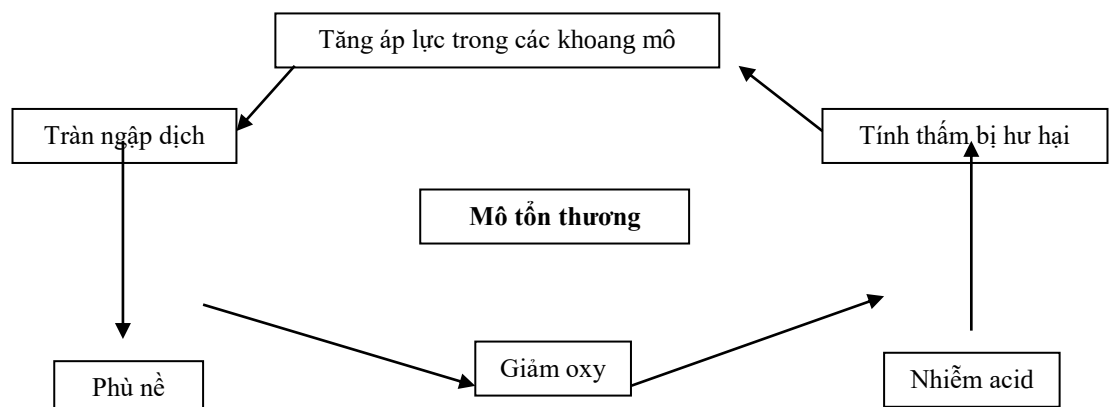
- Vấn đề quan tâm:

Choáng chấn thương.
 Nhiễm trùng nặng.
 Tắc mạch máu do mỡ.
 Nguy cơ có thể mất chi hoặc liên quan tính mạng người bệnh.

2. Sinh lý bệnh vết thương phần mềm.

2.1. Ảnh hưởng của vết thương

- Da là cửa ngõ để vi trùng xâm nhập dù vết thương lớn hay nhỏ. Trường hợp tróc da không hoàn toàn các mạch máu nuôi mảnh da có thể bị đứt do đó dễ bị hoại tử. Trường hợp tróc da hoàn toàn các tổ chức dưới da như mạch máu thần kinh, gân, xương có nguy cơ hoại tử.
- Mô liên kết sẽ ứ đọng máu khi bị tổn thương, tạo điều kiện tốt cho vi trùng phát triển.
- Gân cơ thường rách theo chiều dọc, hẹp và khép giữ lại bên trong một lượng máu tụ ngày càng tăng do tổn thương cơ và mạch máu nhỏ tạo nên hiện tượng tăng áp lực gây chèn ép khoang.
- Cơ giập nát đưa đến hoại tử là môi trường tốt cho vi trùng phát triển. Cần phải khám kỹ để đánh giá đúng mức độ tổn thương. Tiên lượng có thể xấu nếu chỉ tổn thương bị tổn thương động mạch chính.
- Vòng xoắn tăng áp lực và sự phù nề trong mô tổn thương:



2.2. Tổn thương phần mềm có thể gây ra 5 nguy cơ

- Chảy máu tạo nên máu tụ.
- Nhiễm trùng.
- Nhiễm độc.
- Giảm oxy mô tế bào.
- Hoại tử mô tạo ra khuyết mất mô.

2.3. Sinh học của vết thương và sự liền vết thương:

2.3.1. Quá trình hoại tử và phân giải

2.3.1.1. Giai đoạn tự tiêu hủy

Trong những phút đầu sau khi bị thương da rách chảy máu, tức thì có sự tác động trở lại vết thương làm giảm bớt đi lượng máu một cách tối thiểu bởi 2 cơ chế:

- Những mạch máu co lại và ổn định nội môi: Mạch máu co lại, cơ co rút bởi tác động của thromboxane (TXA_2) và tác động thứ phát của thần kinh nội tiết, đau được hình thành ở bề mặt của vết thương gây ra tăng tiết catecholamine. Cân bằng nội mô đạt được bởi tiêu cầu kết hợp với fibrin đóng cục trong thành mạch vùng vết thương do tác động của TXA_2 , adenosine diphosphate (ADP) và yếu tố thứ XII.

- Sự phân hủy fibrin: Là một quá trình sinh lý bình thường, nó ngăn cản sự đông cục lan rộng và sự hình thành huyết khối quá mức. Sự sinh ra plasmin (enzyme làm tan fibrin và sợi protein) làm suy biến đông cục fibrin, fibrin tan vỡ ra nhiều sản phẩm theo khuôn.

- Khi thấy xuất hiện độc tố phản là bắt đầu giai đoạn tự tiêu hủy.

2.3.1.2. Giai đoạn tự làm sạch vết thương

Sau co mạch là hoạt động dẫn mạch của hầu hết các mạch máu nhỏ, đây là kết quả của nhiều tác động, của điều hòa thể dịch, của sự trao đổi giữa acid arachidonic và của hệ thống Kallikrein-kinin. Từ đó sinh ra nhiều hóa ứng động khác nhau và những phân tử tá gen. Sự giảm đi của adenosin triphosphate (ATP) đưa đến sự giảm xanthin và hypoxanthin tạo ra phản ứng chuyển hóa oxygen trong giai đoạn dẫn mạch dẫn đến dạng oxygen gốc tự do O_2 và sản phẩm của Haber-weiss tác động lại OH và H_2O_2 làm tăng thêm tính thấm tế bào.

Trong giai đoạn này có đầy đủ triệu chứng cổ điển của viêm: đau, nóng, đỏ, sưng. Đau là kết quả của Prostaglandin sản sinh ra, nóng và đỏ do tốc độ máu tăng lên và sự tăng sinh mạch máu, sưng là hậu quả của sự tăng tính thấm của tế bào gây phù nề cùng với sự nhiễm khuẩn gây ra.

2.3.2. Quá trình phục hồi tạo mô mới

Điều kiện quyết định để lành hoàn toàn vết thương là có đầy đủ oxygen hóa, chức năng chuyển hóa tế bào tốt và vết thương sạch không có vi khuẩn nhiễm bệnh.

2.3.3. Quá trình lành vết thương được diễn ra dưới 3 hình thức:

- Tạo mô hạt mới:

Quá trình này hình thành bởi sự hoạt hóa và nhập cư của nguyên bào sợi, sự phân giải và hình thành collagen và fibronectin, đồng thời với sự phân giải là sự tạo lập mạch máu tăng sinh do các mao mạch nội mô bắt đầu nảy nở. Các mô hạt lành mạnh, sạch có màu đỏ tươi có kích thước bằng đầu đinh ghim đến hạt đậu xanh, còn các mô hạt viêm nhiễm có màu xanh xám. Mô hạt lấp đầy vùng khuyết mất mô đồng thời tạo hàng rào ngăn cản vi khuẩn và bao phủ bảo vệ thân kinh mạch máu gân và xương bị lộ.

- Co rút thu hẹp vết thương:

Thu nhỏ bớt diện tích vết thương khoảng 50 – 99% diện tích ban đầu tùy theo mức độ và vùng vết thương. Vết thương càng gần thẳng góc với nếp da thì sự thu hẹp càng nhiều.

- Lợp biểu mô phủ kín vết thương khi đã được lấp đầy mô hạt.

Một vết thương có mô hạt sạch phủ đầy thì mỗi ngày thu hẹp và liền lại được từ 1 – 2mm theo đường kính dài nhất, như vậy có thể ước đoán thời gian liền tự nhiên của vết thương theo công thức sau đây:

(công thức Allgower): $T = D.K$

T: thời gian liền vết thương tính (ngày)

D: đường kính vết thương (mm)

K: hằng số bằng 1 hoặc 2

Hai khái niệm trên chỉ có ý nghĩa về mặt số lượng, còn quá trình phục hồi thì cơ bản giống nhau.

2.3.4. Quá trình lành vết thương:

- Nếu hai mép vết thương được khâu áp khít vào nhau và liền dính với rất ít mô mới tạo nên thì gọi là liền vết thương kì đầu, đó là sự liền vết thương của hầu hết các vết mổ chương trình sạch. Nếu vết thương được để hở ngay từ đầu hoặc do nhiễm trùng mà bị toác lại thì sự liền vết thương sẽ trải qua giai đoạn xuất tiết và nhìn thấy rõ sẹo

mới hình thành, ta gọi là liền vết thương kì 2. Vết thương kì đầu sẽ tránh khỏi một số di chứng tại chỗ (sẹo co dúm, lâu liền, dễ loét,...). Song muốn khâu kín mà đạt được liền kì đầu phải cắt lọc đúng quy cách, vết thương khâu kín không căng da và không bị nhiễm trùng. Tất cả các trường hợp vết thương nghi ngại có nhiễm trùng hoặc không đủ điều kiện chống nhiễm trùng chắc chắn (như phải xử trí hàng loạt, tai nạn bom đạn, phương tiện khử trùng kém,...) thì sau khi cắt lọc nên để hở khi không còn nhiễm trùng sẽ khâu kì 2 sớm.

2.3.5. Những điều kiện ảnh hưởng đến sự liền vết thương:

Có một số yếu tố ảnh hưởng đến sự lành vết thương và kết quả của lành vết thương sớm:

- Bệnh nhân:

Người có tuổi (>60 tuổi)

Người có đường huyết cao

Người có urê huyết cao

Đó là những bệnh nhân rất khó lành vết thương.

- Tác nhân hóa học và phóng xạ:

Người có dùng thuốc corticoid và các chất độc hại tế bào (như thuốc trị ung thư) sẽ làm giảm khả năng miễn dịch, giảm chức năng của đại thực bào và giảm bớt sự tổng hợp collagen.

Người đang điều trị bệnh bằng tia phóng xạ, sự bức xạ tỏa ra làm cho tế bào bị hoại tử, tạo cho vết thương chậm lành.

- Tác nhân quan trọng nhất là giảm áp lực oxy trong tổ chức mô:

Nó là hậu quả của việc giảm lưu lượng máu kéo dài, do chấn thương, do chèn ép khoang, do thiếu lượng oxy hít vào hoặc những lý do khác nhau như mô bị phù nề do truyền dịch. Thiếu oxy ảnh hưởng lớn đến hoạt động của đại thực bào, vết thương khó tránh khỏi nguy cơ nhiễm trùng và lành kì 2.

3. Điều trị

3.1.Theo YHCT

3.1.1.Cầm máu nếu có chảy máu

Dùng nõn chuối tiêu, lấy cây non cao độ 60cm cắt sát gốc, bỏ bẹ ngoài cắt từng đoạn 3 – 4cm, giã nhỏ đắp vào vết thương chảy máu rồi băng lại.

Hoặc dùng Móc cau 40g sao qua, Ô long vĩ 20g, hai thứ giã nhỏ, cho vào lọ sạch, rắc vào vết thương chảy máu.

3.1.2. Rửa sạch vết thương

Sau khi cầm máu độ 2 giờ, rửa vết thương bằng nước: lá Trầu không tươi 40g, đun sôi với 2 lít nước trong 15 phút, để nguội cho Phèn phi vào, lọc rồi rửa vết thương.

3.2.3. Làm sạch vết thương, mất tổ chức hoại tử, mọc tổ chức hạt, mau liền da

- Làm sạch vết thương, mất nhiễm trùng, sạch mủ tại chỗ, mất tổ chức hoại tử, mất mùi hôi.

Lá Mỏ quạ tươi rửa sạch giã nát, đắp vết thương. Mỗi ngày thay một lần đến khi vết thương sạch, màu đỏ tươi.

- Làm đầy vết thương (Sinh cơ)

Lá Mỏ quạ tươi, Lá Bòng bong tươi

Hai thứ bằng nhau, rửa sạch, bỏ cọng, giã nát đắp lên vết thương đến khi lên tổ chức hạt che kín vết thương.

- Loại thuốc làm chống mọc tổ chức hạt, sinh cơ và chóng liền da

Là Mỏ quạ, lá Bòng bong, lá Mọc sởi thành phần bằng nhau, bỏ cọng, giã nát đắp vào vết thương, hai ba ngày thay băng một lần. Đắp cho đến khi vết thương đã kín chỉ còn rất nhỏ thì dùng bột sinh cơ.

Bột tứ sinh cơ:

Phấn cao 20g Ô long vĩ 8g

Phấn cây chè 16g Phèn phi 8g

Tán thành bột mịn, rắc lên vết thương.

3.2.4. Các bài thuốc có tác dụng toàn thân

- Chống khát do mất máu

Lá sắn dây: rửa sạch, giã nát đổ vào một bát nước sôi, để nguội, cho vài hạt muối vào uống ngày một lần.

- Chống viêm (dùng trong trường hợp viêm nhiễm sưng tấy)

Lá mặt quỷ sao vàng 40g Cánh béo cái 8g

Gừng cháy 4g Nõn dừa dại 12g

Sắc, ngày uống một thang.

- Nếu có nhiễm trùng quanh vết thương dùng:

Lá cúc tần 40g Lá xạ can 20g

Giã nhỏ, đắp lên chỗ lở loét quanh vết thương.

- Nâng cao thể trạng, chữa mất ngủ:

Lá mặt quỷ 40g Lạc tiên 90g

Gừng 4g (sắc, uống ngày một thang)

BÀI 7. BONG GÂN

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và phân loại bong gân theo tổn thương cấu trúc dây chằng.
- Nêu được tiêu chuẩn chẩn đoán bong gân.
- Trình bày được nguyên tắc chữa bong gân.

Nội dung chính

1. Đại cương.

1.1. Định nghĩa:

- Bệnh lý bong gân còn gọi là tổn thương dây chằng.
- Mỗi khớp có bao khớp che phủ khớp xương và liên kết các mặt khớp tiếp xúc nhau, giúp vận động khớp được dễ dàng, dây chằng là những cấu trúc gia tăng cho bao khớp giúp khớp xương vận động vững vàng.
- Bong gân là bệnh lý tổn thương dây chằng bị kéo giãn quá mức, xảy ra sau một động tác quá mạnh làm chấn thương các dây chằng quanh khớp.
- Kéo giãn quá mức có thể làm rách hoặc đứt dây chằng hoàn toàn nhưng không ảnh hưởng đến gân cơ, thường không có di lệch vĩnh viễn các mặt khớp.

1.2. Vị trí và tính chất thường gặp trong bong gân:

- Bong gân thường xảy ra ở các vị trí: cổ chân, khớp gối, bàn chân, cổ tay, ngón tay, ít gặp hơn trong các khớp khuỷu cánh tay, khớp vai.
- Bong gân thường gặp ở người trẻ, do các nguyên nhân chấn thương (va chạm, trượt té ngã, khiêng vác nặng) hoặc trật khớp gây nên.

1.3. Phân loại bong gân theo tổn thương cấu trúc dây chằng:

- Cấu trúc dây chằng bao gồm các bó collagen chạy song song chèn sát vào nhau, hướng theo phương của lực kéo căng – dọc theo trục dây chằng giúp cho dây chằng có sức bền chịu lực kéo lớn bảo đảm duy trì chiều dài cố định của dây.
- Khi lực kéo căng làm biến dạng chiều dài dây chằng dưới 4% thì dây chằng vẫn co lại được về dạng ban đầu khi mất đi lực kéo, đó là sức kéo căng sinh lý bình thường của dây chằng, khi sức kéo căng vượt quá 4% sẽ làm biến dạng đại phân tử nên dây chằng giãn dài không tự co lại được do một số sợi collagen bị đứt.
- Dựa theo mức độ tổn thương của cấu trúc các bó collagen dây chằng mà bệnh lý dây chằng (còn gọi là Bong gân) được phân thành 3 loại:

1.3.1. Độ 1:

- Là loại bong gân nhẹ, do sức kéo căng vượt quá 4%.
- Một số ít sợi collagen bị đứt nên có khi được coi là dây chằng chỉ bị giãn dài ra không tự co lại được.
- Tổn thương giải phẫu xem như không đáng kể.

1.3.1. Độ 2:

- Nếu sức kéo mạnh hơn từ >4% - <20%.
- Đứt nhiều sợi collagen nên có khi được coi là rách dây chằng.
- Khớp xương vẫn còn vững chắc, chưa bị chệch lệch.

1.3.1. Độ 3:

- Khi sức kéo căng vượt quá >20% mức biến dạng.
- Toàn bộ dây chằng bị đứt hoàn toàn, có thể một hoặc nhiều dây chằng của khớp.
- Khớp xương chệch vênh lỏng lẻo ở nhiều mức độ.
- Có thể kèm theo tổn thương của bao khớp và cơ xung quanh.

1.4. Phân loại bong gân dựa theo mức độ nặng nhẹ:

- Bong gân nhẹ:

Là bệnh lý bong gân mà trong đó dây chằng bị căng quá độ hoặc chỉ bị rách một phần, hoạt động khớp vẫn vững.

- Bong gân nặng:

Tình trạng bệnh lý gồm dây chằng bong ra khỏi đầu xương kéo theo màng xương (hoặc mảnh xương) hoặc dây chằng bị đứt đôi làm hoạt động khớp không vững.

2. Nguyên nhân bệnh sinh.

Dựa theo cấu trúc vi thể của dây chằng, sinh bệnh lý học của bong gân thường tiến triển qua 3 giai đoạn: viêm tấy, phục hồi và tái tạo hình.

- Giai đoạn viêm tấy: Xuất hiện trong 72 giờ sau chấn thương.

Nước hoạt dịch ngấm vào các mô dây chằng, khối máu tụ do mạch máu bị thương tổn ngấm vào mô và đông thành máu cục, có khi tràn vào khe khớp.

Các chất Histamine, Serotonine, Prostaglandine được phóng thích từ dưỡng bào và tế bào khác gây ra thoát máu ngoài mạch dẫn đến tình trạng đau nhức và phù nề.

Viêm tấy được xem như tình trạng viêm vô trùng của bao khớp.

- Giai đoạn hồi phục: Từ khoảng 72 giờ sau chấn thương đến 4 – 6 tuần.

Là giai đoạn đại thực bào tiêu hủy mô dập nát và máu tụ.

Đồng thời xuất hiện các chồi máu để tạo ra các mạch máu mới.

Nguyên sợi bào được huy động đến vùng bong gân để tạo các sợi collagen non. Ở thời kỳ này các sợi collagen chưa phát triển theo sự định hướng của sức kéo căng.

- Giai đoạn tái tạo hình: Thời gian kéo dài từ 12 – 16 tháng.

Sợi collagen trưởng thành hoàn chỉnh.

Chịu được lực kéo bình thường cơ thể. Lúc này các sợi collagen mới phát triển theo đúng của sự kéo căng.

Giai đoạn này xảy ra với loại bong gân độ 3.

3. Chẩn đoán

Chẩn đoán bong gân dựa vào triệu chứng lâm sàng kết hợp với cơ chế chấn thương.

Bong gân cần xác định:

Dây chằng nào bị tổn thương, mức độ?

Có tổn thương bao khớp ?

Khi xảy ra chấn thương vùng gân cơ mà nghe kèm tiếng “rắc” tại chỗ thì gợi ý nghĩ đến bong gân độ 3.

3.1. Triệu chứng lâm sàng

3.1.1. Đau: Là triệu chứng chính yếu.

- Đau nhói ngay khi chấn thương, đau ở chỗ bám của dây chằng hoặc trên đường đi của dây chằng.

- Cảm giác tê nặng nhức nhối tại chỗ tổn thương, dù không có vận động.

- Đau tăng khi vận động khớp hoặc sờ ấn vào vùng tổn thương.

- Khi kéo căng dây chằng, bệnh nhân đau nhói.

3.1.2. Sưng

- Bầm sưng tại chỗ tổn thương, mức độ nhẹ kín đáo hoặc sưng to bầm tím da tùy theo loại bong gân.

- Bong gân nhẹ: Đau ít, sưng quanh khớp, hạn chế cơ năng.

- Bong gân nặng: Đau nhiều, sưng nhanh và to quanh khớp, cơ năng hoạt động giảm nhiều, cử động khớp rất đau, có những động tác bất thường và khớp không vững.

3.2. Cận lâm sàng

3.2.1. X – Quang

Hình ảnh X – Quang tại vị trí bong gân: Không phải trường hợp bong gân đều có hình ảnh x – quang điển hình. X – quang chỉ giúp chẩn đoán bong gân trong các trường hợp sau đây:

- Khi bong gân làm tổn thương dây chằng nơi bám vào xương.

Hình ảnh mảnh xương mẻ.

- Bong gân độ 3: Phải chụp ở tư thế toác khe khớp bắt buộc.

Hình ảnh khe khớp toác rộng hơn bên khe khớp đối diện.

3.2.2. MRI

Xác định được cụ thể tổn thương dây chằng bao khớp.

4. Điều trị

4.1. Nguyên tắc chung

Giai đoạn đầu chống sưng đau theo nguyên tắc:

Chườm đắp lạnh tại chỗ.

Bất động khớp vùng bong gân.

Chỉnh nắn bong gân, trật khớp, trở về vị trí bình thường (chỉnh hình phục vị).

Bó đắp thuốc tại chỗ và thuốc uống theo các phương pháp: Hành khí, Hoạt huyết, Thông kinh lạc.

4.2. Thuốc dùng ngoài

4.2.1. Bài thuốc bó tại chỗ: Cao trị bong gân – Trật khớp

- Thành phần bài thuốc:

Xuyên khung 8g	Kinh bì 8g
Nhiên đồng 8g	Câm sa lặc 8g
Sanh quân 12g	Thảo ô 8g
Tục đoạn 8g	Điền thất 8g
Hồng hoa 8g	Quy vĩ 12g

- Cách chế: các vị tán mịn hòa với dầu mè và sáp nấu chảy, đánh thành cao dùng dán vào chỗ trật khớp bong gân.

- Công dụng: tiêu sưng, giảm đau nhức.

4.2.2. Bài thuốc bó bong gân

- Thành phần:

Sanh nam tinh 8g	Sanh xuyên ô 4g
Sanh mã tiền (1 nắm)	Sanh thảo ô (2 nắm)
Đinh hương (1 nắm)	Xích thược 8g
Cam thảo 8g	Cam toại 8g
Quế khâu 8g	Tế tân 8g
Nhũ hương 8g	Băng phiến 4g
Đại hoàng 8g	Long não 4g

- Công dụng: Hoạt huyết, tiêu sưng, giảm đau.

- Cách làm: Tất cả tán mịn, xao nóng với dấm hoặc rượu. Đắp thuốc vào nơi bong gân, sau 24 giờ thay thuốc.

4.2.3. Thuốc dùng trong

Bài thuốc: Tiết cốt thông mạch thang.

Đương quy 20g	Hà thủ ô 20g
Toái bô 12g	Hoàng cầm 8g
Xuyên đoạn 12g	Liên kiều 8g
Nhũ hương 8g	Mộc dược 8g

Xuyên da bì 12g

Sanh địa 12g

Cách dùng: Dạng thuốc sắc

Công dụng: Thông mạch, tiêu viêm, xơ cân lạc.

BÀI 8. TRẬT KHỚP

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và phân loại trật khớp.
- Nêu được tiêu chuẩn chẩn đoán trật khớp theo Y học hiện đại.
- Trình bày được nguyên tắc chữa trật khớp theo Y học hiện đại và Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Đại cương.

1.1. Định nghĩa:

Trật khớp là sự di lệch một phần hay hoàn toàn các mặt khớp với nhau, có thể xảy ra ở tất cả các loại khớp nhất là các khớp có biên độ hoạt động rộng và hay phải chịu lực.

Nguyên nhân thường do các chấn thương trực tiếp hay gián tiếp tác động lên khớp, do vận động sai tư thế, hoặc cũng có thể do bẩm sinh hay do bệnh lý tại khớp.

1.2. Tổn thương cơ bản của trật khớp:

Khi khớp bị trật ra khỏi vị trí ban đầu, các thành phần cấu tạo của khớp sẽ ít nhiều bị tổn thương, biểu hiện bằng:

- Rách bao khớp.
- Đứt dây chằng.
- Đứt mạch máu gây nên tụ máu nội khớp.
- Tổn thương thần kinh cảm giác gây đau.
- Gân cơ thường ít bị đứt, chính sự co cơ đã gây nên tình trạng biến dạng khớp và cử động bất thường (dấu lò xo).
- Mặt sụn khớp thường không bị tổn thương nếu được nắn sớm, nhưng nếu để lâu có thể gây hư hỏng sụn khớp.

1.3. Phân loại trật khớp:

Chuyên khoa chấn thương chỉnh hình phân loại trật khớp dựa trên 5 phương diện:

- Theo thời gian: Trật khớp cấp cứu (trước 48 giờ sau chấn thương), trật khớp đến khám sớm (trước 3 tuần) và trật khớp đến khám muộn (sau 3 tuần, trật khớp cũ).

Việc nắn chỉnh các trật khớp cũ thường khó và kém hiệu quả.

- Theo giải phẫu: Trật khớp hoàn toàn, bán trật, và trật khớp kèm theo gãy xương (gãy trật).

- Theo sự tái phát: Trật lần đầu, trật tái diễn, trật khớp thường xuyên.

- Theo biểu hiện lâm sàng: Trật khớp kín, trật khớp hở, trật khớp có biến chứng thần kinh mạch máu, trật khớp hóa (có mảnh xương nhỏ vỡ chèn vào khớp nên khó nắn).

- Theo vị trí: Trật trên xương.

Phân loại trật khớp có ý nghĩa quyết định cho chẩn đoán và điều trị, nên cần phải phân tích kỹ theo tất cả các phương diện trên.

1.4. Quan niệm của YHCT:

Trật khớp và gãy xương được YHCT gọi chung là chiết thương, để điều trị chiết thương YHCT có thương khoa (hay trật đã khoa) thuộc ngoại khoa YHCT.

Nguyên nhân chủ yếu là do chấn thương như: Té ngã, bị đánh,...tác động vào cơ thể gây nên những thương tổn nặng hay nhẹ cho quan tiết.

Ngoài ra còn có thể do khí huyết hư yếu, kém nhu dưỡng cân cốt nên quan tiết lỏng lẻo, dễ bị trật. Ví như vì há miệng to mà bị trật khớp hàm dưới là do khí hư không giữ chặt được khớp xương.

2. Chẩn đoán.

2.1. Theo YHHD

Để chẩn đoán trật khớp phải dựa vào 3 yếu tố sau:

- Bệnh sử: chú ý hỏi kỹ cơ chế chấn thương và tuổi bệnh nhân.

- Dấu chứng lâm sàng:

Đau, sưng nề, mất cơ năng. Có thể kèm tê bì lan tỏa nếu có chèn ép thần kinh.

Biến dạng khớp.

Dấu hiệu ổ khớp rỗng: sờ vào khớp không thấy chỏm xương, chỉ gặp trong trật khớp hoàn toàn.

Dấu hiệu lò xo: làm động tác thụ động ngược với chiều biến dạng, khi buông ra chi lại bật trở về vị trí biến dạng.

- Hình ảnh học:

- + X – quang khớp chụp ở 2 tư thế thẳng và nghiêng, vừa giúp chẩn đoán trật khớp vừa xem có kèm gãy xương không.

- + MRI hữu ích để đánh giá các tổn thương dây chằng, gân cơ, và mô mềm quanh khớp.

- + CT – Scan giúp xác định các trường hợp trật khớp kèm gãy xương nội khớp.

2.2. Theo YHCT

Trong bệnh cảnh chấn thương, nếu thương tổn biểu hiện ở quan tiết, bì phu, cơ nhục thì gọi là ngoại thương, còn nếu bệnh nặng hoặc nếu để lâu ngày có ảnh hưởng đến tạng phủ, khí huyết thì gọi là nội thương: “tay chân thân thể thương tổn ở ngoài thì khí huyết bị thương ở trong, vệ phận dinh phận không thông suốt với nhau tạng phủ do đó mà không hòa.” (chính thể loại yếu). Như vậy để biện chứng luận trị, YHCT cũng dựa vào tứ chẩn để khám và nhận diện triệu chứng bao gồm:

Biện chứng:

2.2.1. Khí trệ huyết ứ

2.2.2. Khí huyết hư suy

2.2.3. Can thận hư

Luận trị:

- Dùng thuốc bó tại chỗ cho mỗi trường hợp.

- Thuốc uống trong: sử dụng các phương pháp.

- + Hành khí hoạt huyết để điều trị bệnh cảnh khí trệ huyết ứ.

- + Bổ khí huyết nếu có khí huyết hư suy.

- + Bổ can thận nếu có can thận hư.

3. Điều trị

3.1. Nguyên tắc điều trị

Nguyên tắc chung để điều trị trật khớp là: Nắn sớm – Bất động – Tập vận động.

- Trước khi nắn phải đảm bảo vô cảm tốt để không gây đau đớn cho bệnh nhân, mức độ giảm đau, gây tê hay gây mê tùy thuộc vào từng vị trí khớp cần nắn chỉnh. Ví dụ: nắn trật khớp bàn ngón tay chỉ cần gây tê tại chỗ nhưng nắn khớp háng thường cần phải gây mê.

- Sau khi nắn chỉnh xong phải khám lâm sàng lại và chụp X – quang để kiểm tra.

- Thời gian bất động tùy theo từng khớp và kiểu trật khớp. Tiêu chí đánh giá dựa trên sự lành các thương tổn bao khớp và phục hồi chức năng của khớp.

- Đối với các trật khớp cũ, gãy trật, đứt dây chằng,...phải được can thiệp ngoại khoa.

3.2. Điều trị theo YHHD

3.2.1. Nắn sửa trật khớp

Tùy theo vị trí khớp trật mà có các phương pháp nắn chỉnh khác nhau. Một số trật khớp thường gặp:

- Khớp thái dương hàm dưới
- Khớp cùng đòn
- Khớp ức đòn
- Khớp vai
- Khớp khuỷu
- Khớp cổ tay
- Khớp bàn ngón tay
- Khớp háng
- Khớp gối
- Khớp cổ chân

3.2.2. Điều trị bằng thuốc

Sau khi nắn chỉnh khớp, có thể cho bệnh nhân sử dụng thuốc giảm đau thông thường hoặc giảm đau kháng viêm đường uống hoặc bôi ngoài da.

3.3. Điều trị theo YHCT

Vì bệnh có thể biểu hiện bằng ngoại thương và nội thương, nên khi điều trị thì ngoài việc sử dụng thủ thuật nắn sửa, bó nẹp, còn phải chú trọng đến cả bổ tã bên trong.

3.3.1. Nắn sửa trật khớp

Thủ thuật: tùy vị trí và kiểu trật mà có cách nắn sửa khác nhau, sẽ được trình bày trong phần một số trật khớp thường gặp. Để đảm bảo an toàn cho người bệnh cần chẩn đoán chính xác và thực hiện nắn đúng kỹ thuật. Các thầy thuốc YHCT thường vận dụng phối hợp 8 động tác sau:

- Sờ nắn (xúc chẩn): là khâu đầu tiên và thường xuyên khi nắn chỉnh, xem sự thay đổi vị trí các đầu xương.
- Chắp xương: đem các đoạn xương chắp liền lại với nhau (khi có gãy trật).
- Nắn cho khớp lại: nắn 2 đầu xương khớp lại như bình thường.
- Nâng lên: nâng đầu xương bị lõm xuống lên trên để về vị trí.
- Miết: vừa làm giãn gân cơ, vừa để làm cho đầu xương trật về vị trí cũ.
- Nắm: là kéo lại, trái với miết, thường kết hợp với miết để thông kinh lạc.
- Ấn: ấn vào huyệt vị ở vùng tổn thương để hoạt huyết tán ứ, tiêu sưng, giảm đau.
- Xoa: xoa chỗ ứ đọng cho tan ứ kết.

Dụng cụ nắn chỉnh: sách Y tông kim giám mô tả có 10 loại: băng vải (khỏa liên), gậy đề gỗ (chấn đỉnh), nẹp bằng miếng da trâu (phi kiên), dây vịn (phan sách), viên gạch để kê (diệt chuyên), gỗ lót nẹp lưng (thông mộc), đòn ép (yên trụ), mảnh tre để nẹp (trúc liên), phen nẹp bằng gỗ (sam ly), vòng tre để bó đầu gối (bảo tất). Những dụng cụ này ngày nay được thay thế bằng các loại tương tự nhưng tiện lợi và hiệu quả hơn nhiều: đai đeo, nẹp bột, dụng cụ cố định ngoài,...

3.3.2. Điều trị phối hợp bằng thuốc

Vấn đề sử dụng thuốc trong điều trị trật khớp, trị chấn thương nói chung cũng hết sức phong phú, nhất là các kinh nghiệm dân gian, bao gồm cả thuốc uống trong và thuốc dùng ngoài. Xin giới thiệu một số phương thang theo kinh nghiệm sưu tầm từ sách:

*** Thuốc dùng ngoài**

- Cồn xoa bóp (Nam y nghiệm phương): Sinh mã tiền, Sinh ô đầu, Huyết giác, Đại hồi, Long não, Mộc dược, Địa liên, Nhũ hương, Đinh hương, Nhục quế, Can khương, mỗi thứ 12g, ngâm với 1000ml cồn 90⁰ theo phương pháp ngâm kiệt. Tác dụng: tán ứ, tiêu sưng, giảm đau. Không bôi lên vết thương hở.

- Trật đả cao: Tam lăng, Nga truyệt, Hồng hoa, Quy vĩ, Điền thất (Tam thất), Sanh quân (Đại hoàng), Huyết kiệt (Máu hồng), Hương phụ, Tô mộc, mỗi vị 20g, Cương huỳnh 4g. Tán mịn, thêm dầu mè 200g, sáp ong 40g, nấu lên rồi để nguội thành cao xoa ngoài. Tác dụng: tiêu sưng, giảm đau.

- Thuốc nam bó ngoài: Biển đậu diệp (lá đậu ván trắng), Tỳ ma diệp (lá thầu dầu tía), Tang diệp (lá dâu), mỗi thứ 100g tươi, giã nhỏ với dấm ăn, bó ngoài vết thương, mỗi ngày thay một lần. Tác dụng: thanh nhiệt, hành huyết, tiêu sưng, giảm đau, mau liền xương.

*** Thuốc uống trong**

- Nếu có huyết ứ thì dùng “Phục nguyên hoạt huyết thang” (Y học phát sinh):

Sài hồ 20g	Hồng hoa 8g
Đại hoàng 4g	Qua lâu căn 12g
Cam thảo 8g	Đào nhân 12g
Đương quy 12g	Xuyên sơn giáp 8g

Chữa chấn thương gây tụ huyết.

Phân tích bài thuốc:

Vị thuốc	Tác dụng
Sài hồ	Hóa giải thoái nhiệt, sơ can chỉ thống
Hồng hoa	Hoạt huyết khứ ứ, thông kinh
Đào nhân	Khu huyết ứ, sát trùng, tiêu trung
Đại hoàng	Hoạt huyết hóa ứ, chỉ huyết
Qua lâu căn	Lợi yết hầu, tiêu ung thũng sang độc
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết
Xuyên sơn giáp	Thông kinh lạc, trừ phong, hoạt huyết, tiêu thũng
Cam thảo	Điều hòa các vị thuốc

- Đường gân bị sái đau nhức liên tục, dùng bài “Tiểu hoạt lạc đơn” (Cục phương): Bào xuyên ô, Bào thảo ô, Đờm tinh, lượng bằng nhau, Địa long sấy, Chích nhũ hương, Chích mộc dược, lượng bằng nhau và bằng nửa các vị trên. Nghiền bột làm hoàn, mỗi hoàn 10g, ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 hoàn.

Phân tích bài thuốc:

Vị thuốc	Tác dụng
Đờm tinh	Thanh nhiệt, hóa đờm
Địa long	Trừ phong thấp, đờm kết, khứ trùng tích, phá huyết kết
Chích nhũ hương	Giảm đau do ngã trật đả, chấn thương, tán huyết bài nùng, thông khí hóa trệ
Chích mộc dược	Hoạt huyết tiêu ứ, tiêu ung, bài nùng, chỉ thống, tiêu thũng, sinh cơ, hành khí

- Căn cơ chỗ trật khớp sưng đau nhiều thì uống: “Tráng cân dưỡng huyết thang” hoặc “Bổ cân thang”.

Tráng cân dưỡng huyết thang (Thương khoa bổ yếu): Thục địa, Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Hồng hoa, Xuyên tặc đoạn, Đỗ trọng, Ngưu tất, Đơn bì.

Bổ cân thang (Thương khoa bổ yếu):

Thục địa 12g
 Hồng hoa 4g
 Trần bì 6g
 Đinh hương 4g
 Mộc dược 4g

Vị thuốc	Tác dụng
Đương quy	Bổ huyết, hoạt huyết
Thục địa	Bổ thận, bổ huyết, dưỡng âm
Bạch thược	Dưỡng huyết, liễm âm, hòa can, chỉ thống
Hồng hoa	Hoạt huyết khứ ứ, thông kinh
Phục linh	Lợi thủy, thẩm thấp, bổ tỳ, định tâm
Trần bì	Hòa khí, tiêu đờm
Cốt toái bồ	Bổ thận, làm mạnh gân xương, hoạt huyết hóa ứ, cầm máu, giảm đau
Đinh hương	Ôn tỳ vị, chỉ thống
Nhũ hương	Giảm đau, tán ứ, bài nùng, thông khí, hóa trệ
Mộc dược	Hoạt huyết, tiêu ứ, tiêu ung, bài nùng, chỉ thống, tiêu thũng, sinh cơ, hành khí

Đẳng sâm 12g	Bạch linh 12g
Bạch thược 12g	Chích cam thảo 8g
Bạch truật 12g	Thục địa 12g
Xuyên khung 12g	Đương quy 12g

BÀI 9. RỐI LOẠN KINH NGUYỆT

Mục tiêu:

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa chu kỳ kinh nguyệt và cơ chế bệnh sinh theo y học cổ truyền.
- Nêu triệu chứng thể lâm sàng của rối loạn kinh nguyệt.
- Phương pháp điều trị rối loạn kinh nguyệt theo Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Định nghĩa

Chu kỳ kinh nguyệt được đánh dấu bằng sự chảy máu từ âm đạo có chu kỳ, xảy ra khi niêm mạc tử cung (nội mạc chức năng) bị bong ra và chảy máu. Thời gian của mỗi chu kỳ được tính từ khi bắt đầu kỳ kinh này đến khi bắt đầu kỳ kinh sau (ngày bắt đầu là ngày đầu tiên chảy máu).

Bình thường, phụ nữ ở lứa tuổi hoạt động sinh dục có thời gian vòng kinh nguyệt trung bình là 28 ngày (3 ngày). Thời gian hành kinh là 4 (2 ngày, lượng máu mất trung bình là 40 – 100ml. Một chu kỳ kinh nguyệt bình thường có phóng noãn chia làm 2 giai đoạn.

- Giai đoạn chịu ảnh hưởng của chất estrogen (từ ngày 1 đến ngày 12 của chu kỳ).

- Giai đoạn chịu ảnh hưởng của chất progesterone kết hợp với estrogen (từ ngày 13 đến ngày thứ 28 của chu kỳ 28 ngày).

Rối loạn kinh nguyệt là những biểu hiện bất thường của kinh nguyệt về thời gian, tần số và lượng máu mất trong ngày hành kinh, cùng với những triệu chứng khác kèm theo. Cụ thể là:

- Sự thay đổi về chu kỳ hành kinh
 - + Trước kỳ: Sớm hơn 7 ngày
 - + Sau kỳ: Chậm hơn 7 ngày.
- Thay đổi về tính chất
 - + Số lượng máu ra nhiều hoặc ít hơn bình thường
 - + Số ngày hành kinh ngắn hoặc dài.
 - + Màu sắc huyết: tím, đỏ, nhạt.
 - + Tính chất kinh: huyết đặc, loãng hoặc thành cục.

Các rối loạn kinh nguyệt bao gồm

- + Chứng chảy máu bất thường ở tử cung.
- + Chứng thống kinh.
- + Chứng vô kinh.

2. Sinh lý bệnh và cơ chế sinh bệnh

2.1. Theo yhhđ

2.1.1. Chảy máu bất thường ở tử cung

Được phân vào 2 loại: Loại có kèm những vòng kinh có phóng noãn và loại có kèm những vòng không phóng noãn.

2.1.1.1. Những chu kỳ kinh nguyệt có phóng noãn

Chảy máu tử cung kèm những chu kỳ có phóng noãn thường xảy ra tự nhiên, đều đặn, có thể biết trước về thời gian và lượng máu chảy ra, và thường là có cảm giác đau, khó chịu. Hậu quả là do hoàng thể bị thoái hóa (trong trường hợp không thai nghén), lượng hormon estrogen và progesterone không còn đủ để duy trì nội mạc tử cung, nội mạc trở nên mỏng hơn và làm các mạch máu xoắn ngoằn nghèo hơn, thành

mạch xoắn bị hư gây những điểm xuất huyết, ngày càng nhiều, sau cùng nội mạc chức năng bị bong ra và tạo thành kinh.

Khi có những rối loạn về bệnh cảnh chảy máu bất thường ở tử cung mà chu kỳ kinh vẫn đều thì nguyên nhân thông thường là do bệnh thực thể ở trên đường dẫn máu ra ngoài. Thí dụ: chứng rong kinh, huyết ra đều nhưng kéo dài và nhiều thường là do những bất thường ở tử cung như u xơ tử cung dưới niêm mạc, lạc nội mạc tử cung, polyp niêm mạc tử cung. Nếu huyết ra đều nhưng ít hay chỉ nhỏ giọt thì thường là do dính buồng tử cung hay chít cổ tử cung.

2.1.1.2. Những chu kỳ kinh nguyệt không phóng noãn

Chảy máu tử cung xảy ra không đều và không biết trước được về lượng máu, về thời gian kéo dài của chảy máu, được gọi là chảy máu tử cung do rối loạn cơ năng, đặc biệt là không kèm theo cơn đau bụng. Chảy máu tử cung do rối loạn cơ năng thường là hậu quả của trường hợp nang noãn không chín, kèm theo không phóng noãn, xảy ra bất chợt hoặc mãn tính. Tình trạng này thường xảy ra ở 12 đến 18 tháng đầu sau khi có kinh lần đầu hoặc xung quang thời kỳ mãn kinh hoặc thứ phát của những kích động khác nhau hay bệnh tật xen kẽ. Trong những chu kỳ kinh này, không có hoàng thể, do đó không có tác dụng của progesterone trên tử cung, chỉ có tác dụng của estrogen làm nội mạc tử cung bị tăng sinh cũng đầy đủ để bong ra và gây ra kinh.

Chảy máu tử cung do rối loạn cơ năng trong tuổi sinh sản có thể do nhiều bệnh thực thể tác động lên chức năng của buồng trứng hay gặp nhất là do tụt estrogen giữa kỳ. Khi nội mạc tử cung chịu tác dụng kích thích của lượng estrogen kéo dài mà không được làm gián đoạn do tụt progesterone một cách có chu kỳ (không có thời kỳ hoàng thể) và khi mức estrogen tụt xuống thì nội mạc chảy máu gặp trong bệnh buồng trứng đa nang.

Chảy máu bất thường ở tử cung thường gặp 3 hình thái chảy máu sau:

- Chảy máu giữa vòng kinh
- Rong kinh: Vòng kinh bình thường, nhưng lượng máu mất quá nhiều.
- Rong huyết: Chảy máu bất thường không có chu kỳ.

2.1.2. Chứng vô sinh

Là sự không xuất hiện trạng thái bắt đầu hành kinh, khởi phát kỳ kinh nguyệt. Vô kinh phân 2 loại: Vô kinh nguyên phát và vô kinh thứ phát.

2.1.2.1. Vô kinh nguyên phát

Là tình trạng người phụ nữ chưa hành kinh lần nào. Phần lớn nguyên nhân do khuyết tật của đường dẫn máu.

- Dậy thì muộn do thể chất hoặc do những bất thường nội tiết.
- Có bất thường về cấu trúc di truyền.
- Kinh ản (dòng máu kinh bị tắc do vách ngăn ngang âm đạo hoặc màng trinh không thủng).
- Bệnh chán ăn tâm thần xuất hiện sớm.

2.1.2.2. Vô kinh thứ phát

Là tình trạng không thấy kinh nguyệt ít nhất 6 tháng ở người phụ nữ trước đó vẫn hành kinh bình thường và không mang thai. Nguyên nhân có thể là do:

- Bệnh lý hoặc khuyết tật giải phẫu của đường dẫn máu: không có tử cung, không có cổ tử cung, không âm đạo, dính buồng tử cung, niêm mạc tử cung không tiếp nhận chất nội tiết của buồng trứng.

- Suy tổn buồng trứng gây vô kinh: có thể do buồng trứng khó phát triển, mãn kinh sớm, thiếu hụt 17 alpha-hydroxylaza hay 17,20 – desmolaza, hội chứng buồng

trứng đối kháng. Suy tổn buồng trứng gồm những rối loạn trong đó buồng trứng thiếu các tế bào mầm và những tế bào mầm đối kháng với FSH.

- Trứng không phóng noãn mạn tính: Tình trạng không có phóng noãn tự nhiên, nhưng có khả năng phóng noãn lại bình thường nếu được điều trị thích hợp. Có 2 trường hợp:

- + Sự sản sinh estrogen vẫn bình thường nhưng estrogen này không được chế tiết một cách có chu kỳ, gặp trong bệnh cảnh buồng trứng u nang, khối u sản sinh hormone của buồng trứng và tuyến vỏ thượng thận.

- + Sự sản sinh estrogen thiếu hụt hoặc không sản sinh estrogen thường là có thiếu năng tuyến sinh dục do thiếu hormon hướng sinh dục của tuyến yên, gây ra bởi những rối loạn của tuyến yên, hay hệ thống thần kinh trung ương như khối u não, u tuyến yên, suy tuyến yên nguyên phát, hội chứng Shuhan.

2.1.2.3. Chứng đau bụng kinh

Là tình trạng đau bụng hành kinh hoặc trước khi hành kinh, và đau nhiều nhất trong ngày đầu là ngày lượng máu mất nhiều nhất. Vị trí đau thường là hạ vị lan lên xương ức hoặc lan xuống đùi và lan ra 2 hông sườn.

Cơ chế gây đau: Trong giai đoạn hành kinh, sự hoạt động của cổ tử cung được tăng cường, dòng máu tử cung bị giảm đi nhiều, nhất là khi nội mạc tử cung co bóp mạnh. Hiện tượng tăng cường hoạt động này là hậu quả của lượng prostaglandin và bradykinin được tổng hợp ra quá nhiều trong quá trình phân hủy của nội mạc tiền kinh.

Đau bụng kinh phân ra 2 loại:

- Đau bụng kinh sinh lý

- + Đau giữa vòng kinh (đau kèm theo phóng noãn) và trong thời gian ngắn kéo dài từ vài phút đến nhiều giờ, đau khu trú ở một góc bụng nhưng hiếm khi nặng nề. Cơ chế có thể là do dịch nang noãn chảy vào ổ bụng gây kích thích phúc mạc.

- + Đau trước và trong khi hành kinh: Con đau này có khi không có ý nghĩa gì, nhưng cũng có thể làm cho mất khả năng lao động. Triệu chứng gồm có phù, cương vú, chướng bụng hoặc bức bối. Nguyên nhân chưa rõ nhưng có thể là có vai trò của prostaglandin. Những cơn đau co thắt ở người vòng kinh có phóng noãn được gọi là thống kinh nguyên phát.

- Đau bụng kinh trầm trọng kèm theo những bệnh ở tiểu khung được gọi là thống nhất kinh thứ phát thường cơn đau bụng đến muộn, nguyên nhân do viêm nhiễm tử cung, phần phụ, âm hộ và âm đạo, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung.

2.2. Theo yhct

2.2.1. Bệnh danh yhct

Rối loạn kinh nguyệt được gọi là bệnh nguyệt kinh, Gồm các chứng Thống kinh, Bế kinh, Băng lậu, Kinh trở, Kinh trễ, Kinh loạn...v.v

2.2.2. Cơ chế và bệnh sinh yhct

Đối với người phụ nữ thì bào cung là khí quan riêng biệt, chuyên chủ việc kinh nguyệt và hệ bào, nơi phát nguồn của mạch Xung, mạch Nhâm. Mạch Xung là bể của huyết, mạch Nhâm là chủ về bào thai, cho nên công năng của bào cung cùng với 2 mạch Xung, Nhâm có quan hệ không thể tách ra được.

Khi khí huyết của mạch Xung, mạch Nhâm bắt đầu đầy đủ thịnh vượng thì hành kinh đúng chu kỳ mỗi tháng. Đến trên dưới 49 tuổi thì khí huyết mạch Xung, mạch Nhâm suy yếu dần, rồi kinh nguyệt ngừng hẳn, thiên quý kiệt.

Chu kỳ kinh nguyệt thường dễ bị ảnh hưởng bởi

- Những kích động về tinh thần (Nội nhân).

- Ngoại cảm lục dâm.
- Hoặc nội thương do ăn uống, bệnh tật.

Các nguyên nhân trên làm cho khí huyết của mạch Xung, mạch Nhâm và Bào cung mất điều hòa, mà gây nên những rối loạn chu kỳ kinh nguyệt. Mặt khác, khi nội tạng bệnh đặc biệt là tạng Can, Tỳ, Thận cũng ảnh hưởng rất lớn về bệnh nguyệt kinh. Thật vậy, Tâm chủ huyết, Tỳ thông huyết, Can tàng huyết. mạch Can liên lạc với âm khí, quản lý phần bụng dưới. Tạng Thận khai khiếu ở tiền âm, hậu âm lại là chủ tể của cơ quan sinh dục, cho nên, khi các chức năng của các tạng trên rối loạn đều có thể tác động đến chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ.

3. Triệu chứng lâm sàng và nguyên tắc điều trị.

3.1. Theo YHHĐ

3.1.1. Các hình thái chảy máu tử cung bất thường

3.1.1.1. Rong kinh

Là hiện tượng có kinh đúng chu kỳ nhưng kinh kéo dài trên 7 ngày, lượng huyết có thể nhiều, trung bình hoặc có thể ít.

Phân thành các thể loại sau:

- Cường kinh

Vòng kinh bình thường nhưng lượng huyết ra nhiều hơn bình thường, nguyên nhân do cường estrogen. Điều trị bằng thuốc nội tiết progesterone.

- Rong kinh do thiếu estrogen

Vòng kinh bình thường nhưng lượng máu ra ít hơn bình thường và thời gian kéo dài. Loại rong kinh này thường kèm theo triệu chứng kinh ít và kinh thưa. Chẩn đoán thăm dò bằng tế bào âm đạo nội tiết hoặc định lượng estrogen để điều trị.

- Kinh thưa (Oligomenorrhea)

Chu kỳ kinh nguyệt kéo dài trên 35 ngày.

- Kinh ít (Spaniomenorrhea)

Lượng kinh của mỗi kỳ kinh rất ít cần xác định rõ nguyên nhân thực thể để điều trị vì có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và sức khỏe bệnh nhân.

- Kinh mau (Polymenorrhea)

Còn gọi là đa kinh, vòng kinh ngắn dưới 3 tuần. Thường do nang noãn sớm trưởng thành, giai đoạn phát triển rút ngắn lại. Điều trị bằng thuốc nội tiết.

3.1.1.2. Rong huyết:

Chảy máu bất thường ở tử cung không có chu kỳ, không phóng noãn. Điều trị theo nguyên nhân bằng nội khoa, ngoại khoa, hóa chất, thuốc nội tiết.

Chuẩn đoán: Cần xác định được là chảy máu từ niêm mạc tử cung ra âm đạo.

Thăm khám thực thể để loại trừ các nguồn chảy máu từ trực tràng, bàng quang, cổ tử cung âm đạo và loại trừ những rối loạn liên quan đến thai nghén.

Các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để tìm nguyên nhân.

- Sinh thiết nội mạc tử cung.
- Nạo tử cung quy ước.
- Xét nghiệm tế bào.

3.1.1.3. Đau bụng kinh

Đa số phụ nữ có biểu hiện ít nhiều đau đớn ít nhất trong ngày đầu hành kinh, là những ngày lượng máu mất nhiều nhất.

Đau bụng kinh sinh lý: Thường gặp ở một người con gái chưa sinh đẻ khoảng 16 – 26 tuổi, rất khó chịu vùng bụng dưới khi hành kinh, đau đến không thể làm việc được.

Đau bụng kinh có thể xảy ra thứ phát sau một thực thể như lạc nội mạc tử cung, nhiễm khuẩn.

Điều trị theo nguyên tắc.

- giảm đau, hạ nhiệt
- Tìm giải quyết nguyên nhân.

3.1.1.4. Vô kinh

Vô kinh nguyên phát là quá tuổi dậy thì 16 – 18 tuổi mà vẫn chưa hành kinh còn gọi là kinh muộn.

Vô kinh thứ phát là tình trạng mất kinh trên 06 tháng, ở người đã có tiền sử hành kinh 1 thời gian, thường phải xác định nguyên nhân.

Điều trị:

- Nguyên nhân vô kinh.
- Có thể điều trị bằng thuốc nội tiết hoặc phẫu thuật nếu cần.

3.2. Theo yhct

3.2.1. Kinh nguyệt trước kỳ

Là tình trạng kinh đến sớm ngày kinh bình thường, phần nhiều do huyết nhiệt hoặc do khí hư gây ra. Bệnh danh: Kinh táo, Kinh thủy tiên kỳ.

Bao gồm các thể lâm sàng.

3.2.1.1. Thể Huyết nhiệt (Thực nhiệt)

- Nguyên nhân

- + Do thức ăn cay nóng.
- + Do cảm phải nhiệt tà gây rối loạn huyết tích nhiệt.

- Triệu chứng:

- + Kinh đến sớm, lượng kinh ra nhiều, sắc kinh đỏ tía, kinh đặc, huyết cục.
- + Sắc mặt đỏ, môi khô đỏ, tính chí dễ giận, cáu gắt.
- + Đại tiện táo, tiểu đỏ, thích mát, sợ nóng.
- + Mạch hoạt sắc, hồng thực, hồng hoạt.

3.2.1.2. Thể Huyết ứ.

- Kinh đến sớm, lượng ít không lợi. Sắc kinh bầm tím, huyết cục.
- Bụng dưới trướng đầy đau. Lưỡi nhạt xanh. Mạch hư tế sắc.

3.2.1.3. Thể Huyết uất.

- Kinh nguyệt đến sớm, lượng huyết ít. Sắc kinh màu đỏ, khi hành kinh không lợi.

- Trước hành kinh sưng đau vú hoặc sốt, đỏ mồm hôi trộm.
- Sắc mặt xanh vàng, gò má hồng.
- Tinh thần uất ức, hồi hộp chóng mặt, ngực phiền, đau sườn.
- Chết lưỡi đỏ, rêu vàng mỏng. Mạch tế sắc.

3.2.1.4. Thể Đàm nhiệt.

- Kinh đến sớm, lượng nhiều. Sắc kinh màu đỏ, đôi hạ màu vàng trắng lẫn lộn.
- Bụng chướng, ngực phiền, hoa mắt chóng mặt, uể oải.
- Miệng nhớt hơi đắng, nôn ọe, nôn nhiều đàm trắng vàng.
- Rêu lưỡi trắng nhờn, vàng. Mạch hư hoạt và sắc.

3.2.1.5. Thể Khí hư

- Nguyên nhân

+ Do cơ thể suy nhược, dinh dưỡng kém, hậu quả là khí huyết kém ảnh hưởng nhiều đến mạch Xung Nhâm.

- Triệu chứng

- + Kinh đến sớm, lượng kinh nhiều. Sắc kinh nhạt loãng.
- + Sắc da trắng bóng, chất lưỡi hồng nhạt, rêu nhót.
- + Tinh thần uể oải, đàm hơi, ngại nói, đau mỗi lưng.
- + Mạch hư nhược vô lực.

3.2.1.6. Thử Hư nhiệt

- Nguyên nhân

+ Bệnh trạng âm hư hỏa vượng làm âm huyết kém, nhiệt thăng lên gây kinh nguyệt lượng ít, nhưng ra trước kỳ.

- Triệu chứng

- + Kinh đến sớm, lượng kinh ít. Sắc kinh đỏ, trong, không ứ huyết cục.
- + Sắc da không nhuận, gò má đỏ. Lưỡi đỏ, rêu vàng khô, môi lỏ.
- + Táo bón, tiểu vàng, hoa mắt, chóng mặt, tâm phiền.
- + Mạch tế sác.

3.2.2. Kinh nguyệt sau kỳ

Kinh nguyệt đến chậm hơn sau 7 ngày. Phần nhiều do hư hàn, đàm thấp hoặc huyết nhiệt, huyết hư, ứ huyết. YHCT xếp kinh nguyệt đến chậm vào bệnh chứng bệnh kinh trễ, kinh trì, kinh hành hậu kỳ, kinh sứt.

Các thể lâm sàng gồm:

3.2.2.1.1. Thử Hư hàn

- Nguyên nhân

+ Do bệnh lý nội thương với cơ địa dương hư.

- Triệu chứng

- + Kinh đến chậm, lượng kinh ít. Sắc kinh nhạt hoặc xám đen, loãng.
- + Sắc da xanh bạc hoặc úa vàng, môi nhạt, thích nóng, sợ lạnh.
- + Bụng đau liên miên, chườm nóng dễ chịu, chân tay lạnh, hồi hộp.
- + Chóng mặt, đoản hơi, tinh thần uể oải. Mạch trầm trì hoặc vi tế.

3.2.2.1.2. Thử Thực hàn

- Nguyên nhân

+ Do ngoại cảm phong hàn

- Triệu chứng

- + Chân tay lạnh, sợ rét, rêu lưỡi mỏng
- + Mạch trầm khẩn.

3.2.2.1.3. Thử Huyết ứ

+ Khi huyết ứ lưu ngưng trệ làm kinh đến quá kỳ, đau bụng kinh.

- Triệu chứng

- + Kinh đến chậm, lượng kinh ít. Sắc kinh tím đen, huyết cục.
- + Sắc da xám, bụng đầy trướng, xoa nắn đau tăng, khi ra huyết được thì giảm đau bụng.

+ Đại tiện táo, tiểu ít đỏ xèn. Mạch trầm tế sác

3.2.2.1.4. Thử Huyết hư

+ Do cơ thể gầy ốm nên kinh nguyệt không đến đúng kỳ.

- Triệu chứng

- + Kinh đến chậm, lượng kinh ít. Sắc kinh nhạt, loãng.
- + Sắc da trắng, canh bạc, da khô, nóng nhạt.
- + Đau lưng gối, táo bón, mệt mỏi, đoản hơi, ngại nói
- + Chóng mặt, hoa mắt, ít ngủ. Lưỡi nhạt, ít rêu.
- + Mạch tế sác hoặc hư tế.

3.2.2.1.5. Thử Đàm trở

- Cơ thể to béo, âm khí nhiều, chất mỡ trong người quá nhiều làm bế tắc kinh mạch dẫn đến kinh nguyệt đến muộn vài tháng một lần kinh.

- Triệu chứng

+ Kinh đến chậm, lượng kinh nhiều hoặc ít.

+ Sắc kinh nhợt, dính đặc, đới hạ nhiều mà trắng.

+ Ngực bụng căng trướng, tức, hay nôn, buồn nôn, ăn kém miệng nhạt. Rêu lưỡi trắng nhớt. Mạch huyền hoạt.

3.2.2.1.6. Thử Khí uất

- Kinh nguyệt đến trễ do khí huyết ngưng trệ. Điều này nói lên mối liên quan của phần khí uất trệ liên lụy tới phần huyết bị uất trệ.

- Triệu chứng

+ Kinh ít ra, chu kỳ đến chậm, hành kinh không thông suốt.

+ Trước khi hành kinh, bụng dưới chướng đau.

+ Tinh thần không thoải mái. Bực dọc, cáu gắt, ngực sườn đầy tức. Lưỡi trắng nhợt. Mạch huyền sắc.

3.2.2.1.7. Kinh nguyệt không định kỳ

Kinh nguyệt lúc có sớm, lúc có muộn, không theo đúng chu kỳ. YHCT xếp các trường hợp vào bệnh danh kinh nguyệt không ổn định kỳ, kinh loạn, nguyệt kinh khiên kỳ.

Nguyên nhân do nội thương hoặc tình chí bất ổn lâu ngày gây rối loạn chức năng các tạng Tỳ, Can, Thận. Trong đó Can khí không đều làm khí nghịch loạn lên là chính.

Các hội chứng lâm sàng gồm:

3.2.2.1.8. Thử Can khí uất kết

- Do tình chí uất ức làm Can khí không thông suốt, đều có ảnh hưởng tới kỳ kinh sớm hay muộn khác nhau.

- Triệu chứng

+ Kinh đến có lúc sớm, lúc muộn. Lượng kinh ít, kinh đi không thông. Sắc kinh đỏ ủa, huyết cục.

+ Đau bụng trước hoặc đầu lúc hành kinh. Đau từ vùng bụng dưới lan ra ngực sườn. Khi hành kinh vú căng, ngực sườn tức, đau lưng.

+ Đại tiện táo, tinh thần u uất căng thẳng.

+ Sắc mặt không tươi, lưỡi nhạt, rêu lưỡi mỏng. Mạch huyền tế.

3.2.2.1.9. Thử Tỳ khí hư

- Thể chất suy nhược, Tỳ khí suy thì chuyển vận bất thường làm ảnh hưởng tới kinh kỳ. Chức năng vận hóa kém nên sức ăn uống giảm làm lượng huyết ít, kinh nguyệt ra muộn. Nếu sức ăn uống còn mạnh, thì lượng huyết nhiều, kinh nguyệt đến sớm hơn.

- Triệu chứng

+ Kinh nguyệt không định kỳ, lượng kinh ít, Sắc da vàng xanh, da thịt phù thũng, mỗi mặt, chân tay lạnh thích nằm, chóng mặt, hồi hộp, đoản hơi.

+ Bụng chướng, miệng nhạt ăn không ngon, tiêu lỏng.

+ Lưỡi ướt, rêu lưỡi trắng mỏng nhớt. Mạch trì hư nhược.

3.2.2.1.10. Thử Can Thận âm hư

- Triệu chứng

+ Kinh không định kỳ, lượng kinh ít, kinh xuống nhiều về đêm. Sắc kinh nhợt, trong loãng dỏ.

+ Sắc mặt xám đen, ù tai, chóng mặt, đau lưng mỗi gối, bụng dưới trệ. Tiểu nhiều lần. Mạch trầm nhược.

3.2.2.1.11. Thể Huyết ứ

- Ứ huyết không hành được làm huyết mới sinh không về được kinh mạch cũng có thể làm kinh đến sớm, muộn bất chợt.

- Triệu chứng

+ Trước hành kinh bụng dưới căng tức, đau nổi gò cứng kinh xuống không thông, màu đen sẫm có huyết cục ra kinh thì giảm đau. Kinh có khi rỉ rả, có khi ngưng hẳn, bụng dưới khi đau khi bớt.

+ Sắc da xanh tím, da khô táo, miệng khô, không khát nước ngực căng tức, táo bón. Mặt lưỡi tím. Mạch trầm sắc.

3.2.3. Kinh nguyệt nhiều

Khi hành kinh lượng huyết tăng lên nhiều hơn bình thường, nhưng chu kỳ kinh nguyệt không thay đổi, hoặc số ngày kinh đến kéo dài làm lượng kinh tăng lên.

Bệnh danh: Nguyệt kinh qua đa, rong kinh (hành kinh kéo dài trên 5 ngày). Cường kinh (lượng huyết quá nhiều).

Nguyên nhân: Mạch Xung Nhâm thất thủ, huyết hải không cố nhiếp được nên huyết kinh chảy nhiều.

Các thể lâm sàng bao gồm:

3.2.3.1. Thể Huyết nhiệt

- Kinh lượng nhiều, sắc màu hồng thẫm, đặc, mùi tanh hoặc có huyết cục tím.

- Sắc mặt đỏ hồng, mắt có tia hồng, môi hồng khô, miệng đắng khô có nhựa, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt, ngực bụng đầy tức, khó chịu, bức rút, cáu gắt, ngủ không yên, táo bón, tiểu vàng đục, có hoàng bạch đới.

- Mạch hoạt sắc.

3.2.3.2. Thể Khí hư

- Khí hư không nhiếp huyết mà sinh kinh nguyệt nhiều lượng kinh nhiều, sắc nhạt.

- Sắc mặt trắng bóng hoặc vàng úa, lưỡi hồng rêu mỏng lóng uể oải, hồi hộp, sợ sệt, đoản hơi. Mạch hư yếu.

3.2.3.3. Thể Đàm trở

Đàm nhiều, chiếm mất vị trí huyết hải vì thế mà huyết xuống nhiều.

Triệu chứng

- Lượng kinh nhiều, sắc nhạt hơi dẻo, dính.

- Cơ thể mập, bức rút trong ngực, bụng đầy trướng, ăn ít, đàm nhiều, đới hạ, miệng lạt. mạch huyền hoạt.

3.2.4. Kinh nguyệt ít

Tình trạng kinh nguyệt không thông, lượng ít hơn mức bình thường nhưng chu kỳ kinh nguyệt vẫn đều.

Bệnh danh: Thiếu kinh, Nguyệt kinh quá thiểu, kinh ít.

Nguyên nhân: Do vĩnh âm bất túc, hoặc huyết hải trống không hoặc mạch Xung Nhâm không hành, huyết không thông.

Thể lâm sàng

3.2.4.1. Thể Huyết hư

- Kinh đi không lợi, lượng ít, sắc kinh nhạt cơ thể gầy.

- Sắc da xanh bạc hơi vàng. Da khô, đau đầu, ù tai, hoa mắt, hồi hộp ít ngủ.

- Đau mỗi lưng gối, lưỡi nhạt ít rêu. Mạch hư tế.

3.2.4.2. Thể Huyết ứ

- Kinh xuống không thông, lượng ít, màu tím có cục.
- Trước khi hành kinh bụng dưới căng tức, cự ản, ra kinh bớt đau. Có khi chảy rỉ rả, có khi tắt hẳn, táo bón, môi khô, mặt lưỡi tím sẫm. Mạch trầm sắc.

3.2.4.3. Thể Đàm trở

- Đàm thấp ngăn chặn đường đi của kinh nguyệt nên kinh ít, lượng kinh ít sắc nhạt.
- Cơ thể to béo, phì nhiêu trong ngực, bụng trên chướng, ăn ít đàm nhiều, ợ, nấc cục, bạch đới.
- Miệng lại có nhớt, rêu trắng nhờn.

3.2.5. Bế kinh

Tình trạng chưa đến thời kỳ dứt kinh nguyệt mà lại không hành hoặc có nửa chừng ngưng hẳn và có trạng thái bệnh tật xuất hiện gọi là chứng vô kinh hoặc kinh bế.

Bệnh danh: Vô kinh, Bế kinh

Nguyên nhân: Theo thể lâm sàng chia làm 2 loại:

- Thực chứng: do thực tà cách trở làm mạch đạo không thông, kinh huyết ứ trệ không đi xuống được, nên không ra kỳ kinh.
- Hư chứng: Phần nhiều là âm huyết bất túc; huyết hư do mất máu nhiều, đồ mồ hôi trộm, phòng lao, sinh đẻ nhiều hoặc Tỳ Vị hư yếu nên không sinh huyết hoặc trùng tích, tất cả đều có thể sinh chứng huyết khô kinh bế làm không có kinh nguyệt.

Trên lâm sàng phân 7 loại

3.2.5.1. Thể Huyết khô

Do khí huyết suy kiệt.

Triệu chứng

- Kinh nguyệt lúc đầu sắc nhợt, lượng ít rồi tắt hẳn.
- Sắc mặt xanh bạc hơi vàng, gầy, da khô, lưỡi nhợt, rêu tẻ.
- Tinh thần uể oải, hồi hộp, lo sợ, đoản hơi, ăn ít khó tiêu.
- Đau lưng yếu sức, táo bón. Mạch hư tế.

3.2.5.2. Thể Huyết ứ

- Ban đầu kinh đi không thông, rồi tắt dần.
- Bụng dưới căng trướng cứng đau, đè vào đau hơn, đau lan hông đùi hoặc đến vai lưng, ngực bụng sinh đầy.
- Sắc mặt xanh xám, da khô ráo, miệng khô không khát nước.
- Tiêu bón, tiểu ít, lưỡi sẫm hoặc có chấm tím đỏ.
- Mạch trầm kết mà sắc.

3.2.5.3. Thể Hàn ngưng

Hàn khí ngưng lại ở huyết thất, huyết ngừng thì kinh không thông.

Triệu chứng

- Kinh nguyệt tắt, đau bụng, mỗi lưng, cứng đau ở gáy sợ lạnh, da lạnh.
- Rêu lưỡi mỏng trắng. Mạch trầm trì hoặc khản.

3.2.5.4. Thể Nhiệt sắc

- Kinh đến trước kỳ, ít dần rồi tắt.
- Mặt vàng, gò má đỏ, tâm phiền, sốt về đêm, khó ngủ.
- Miệng đắng, họng khô, táo bón, tiểu đỏ sền.
- Lưỡi đỏ sáng, rêu lưỡi khô vàng nứt nẻ từng đường.
- Mạch huyền tế sắc.

- Nếu do uất nhiệt thì sắc da khô, tinh thần uất ức, đau lưng ù tai đau hông sườn, ngực đầy trướng, lưỡi đỏ không rêu.

- Mạch hư tế sắc.

3.2.5.5. Thể Đàm ngăn

Người béo mập, có nhiều đàm thấp và lớp mỡ chặn lấy kinh mạch dẫn đến khí huyết không thông gây kinh bế.

Triệu chứng

- Kinh kỳ thường sai lệch, sắc kinh nhợt, lượng nhiều rồi tắt.

- Bụng trên đầy tức, tâm phiền, hay ọc nấc cục, ăn ít, đàm nhiều, nhiều bạch đới.

- Sắc mặt sẫm, miệng nhạt có nhớt, rêu lưỡi trắng nhờn. Mạch huyền hoạt.

3.2.5.6. Thể Khí uất

Do thất tình thương tâm, hoặc tình chí uất ức không tiết đạt ra được thường sinh ra bế kinh.

Triệu chứng

- Kỳ kinh đi sai rồi ngưng hẳn, có đới hạ.

- Sắc mặt sẫm nhạt xanh bạc, tinh thần uất ức.

- Đau ngực sườn, ăn ít, ợ chua.

- Rêu lưỡi trắng mỏng. Mạch huyền sắc.

3.2.5.7. Thể Tỳ hư

Tỳ Vị không hòa, ăn uống giảm ít nên không sinh ra huyết được gây kinh bế.

Triệu chứng

- Kinh kỳ không đúng, lượng ít, sắc nhợt rồi tắc hẳn, thỉnh thoảng có bạch đới.

- Sắc mặt xanh vàng, da phù thũng, chân tay lạnh, mỏi.

- Tinh thần uể oải, chóng mặt hồi hộp, lo sợ.

- Có khi bụng dưới đầy trướng, rêu lưỡi trắng nhờn hoặc rêu nứt rạn. Mạch hư trì.

3.2.6. Băng lậu

Trong thời gian không phải hành kinh, mà huyết ở âm đạo ra nhiều hoặc xuống lai rai không dứt, gọi là băng lậu. Bao gồm 2 chứng chính Huyết băng và Kinh băng.

- Băng: là huyết đột nhiên xò xuống như dội nước.

- Lậu: huyết chảy rử rả mãi không dứt.

Băng lậu có cùng gốc nhưng thể hiện chứng trạng có khác nhau, nếu băng lậu lâu ngày không cầm, thể bệnh nặng dần sinh ra băng. Băng lậu có quan hệ nhân quả mật thiết với nhau nên không tách rời được.

Bệnh danh: Băng lậu, rong huyết, băng trung lậu hạ.

Nguyên nhân: Cơ chế chính là do tổn thương 2 mạch Nhâm Xung không cố nhiếp huyết được, phần nhiều là do hư hàn, hư nhiệt, thấp nhiệt, huyết ứ, khí uất.

Các thể lâm sàng.

3.2.6.1. Thể hư hàn

- **Thiên về Huyết hư**

+ Băng lậu lâu ngày không bớt, màu huyết trong nhợt.

+ Mỗi yếu đùi thắt lưng, bụng dưới đau.

- **Thiên về Khí hư**

+ Băng lậu lâu ngày không khỏi, có từng cơn bất chợt băng huyết dữ dội hoặc rỉ ra không cầm. Màu huyết hồng nhạt, trong.

+ Mỗi mệt, đoản khí, không muốn ăn, lưỡi nhạt, rêu mỏng mà nhuận. Mạch hư đại hoặc tế nhược.

- **Thiên về Khí Huyết đều hư**

+ Băng lậu lâu ngày không hết, cơ thể suy kiệt kèm chứng trạng khí huyết lưỡng hư.

- Thiên về Hàn

+ Băng lậu lâu ngày như nước đậu.

+ Bụng dưới lạnh đau, sợ lạnh, chóng mặt, mồi thất lưng, tiêu lỏng.

+ Sắc mặt xanh bạc ánh vàng, thân thể khô gầy. Mạch trầm trì mà khản.

- Thiên về Thận dương hư

+ Đới hạ liên miên không dứt, ngũ canh tả, tiểu dầm hoặc tiểu nhiều lần.

+ Sắc mặt xạm tối, chi lạnh yếu, đau lưng đùi.

+ Lưỡi sẫm nhợt, rêu mỏng bạc. Mạch vi trầm trì.

- Thể Hư quá muốn thoát

+ Băng huyết ồ ạt, chóng mặt vã mồ hôi, bất an.

+ Sắc mặt tối, miệng há mặt trợn, chi lạnh, thở yếu, thần thức tối tăm mơ hồ.

Mạch vi tế muốn tuyệt.

3.2.6.2. Thể Hư nhiệt

- Thiên về Huyết hư

+ Băng lậu lâu ngày không bớt, sắc tím lượng nhiều kèm triệu chứng hư nhiệt.

Mạch tế sắc.

- Kèm Thận âm hư

+ Băng lậu nhiều vào lúc chiều tối, sắc hồng thắm. Người gầy da khô, gò má đỏ, chóng mặt, ù tai, cổ họng khô đau, miệng lưỡi lở nứt, đau răng.

+ Sốt nhiều, mệt, lòng bàn tay nóng. Khó ngủ, mộng mị, lưng gối đau, mềm nhũn, táo bón, tiểu vàng sền. Lưỡi đỏ nứt. Mạch hư sắc, bộ xích hư đại.

3.2.6.3. Thể Thấp nhiệt

- Thiên về Thấp

+ Băng lậu huyết ra nhiều, chất nhờn tinh thần mê mệt, nặng nề, đầu căng, ngực bụng đầy tức.

+ Mắt mặt sưng, mí mắt nặng. Sắc da vàng sẫm hơi lẫn với sắc hồng. Miệng nhớt, ăn kém, tiêu lỏng, tiểu sền. Rêu lưỡi trắng nhớt hơi vàng. Mạch nhu hoạt.

- Thiên về Nhiệt

+ Băng lậu huyết ra nhiều, sắc tím sẫm hồng đặc, dính mùi hôi tanh, bụng dưới đau nóng, đè đau hơn.

+ Sắc mặt nhờn, ẩm mồ hôi, miệng đắng nhớt, bứt rứt, khó ngủ, tiêu bón, hoặc lỏng, tiểu vàng đỏ sền. Lưỡi hồng đỏ, rêu lưỡi khô vàng. Mạch hoạt sắc.

3.2.6.4. Thể Huyết hư

- Huyết lậu rỉ ít, sắc tím thành cục, bụng dưới đau, lưỡi tím sẫm. Mạch trầm sắc.

3.2.6.5. Thể Khí uất

● Do kinh nguyệt đi sai kỳ tạo thành chứng băng lậu.

● Sắc huyết màu tím, có cục. Lưỡi nhợt. Mạch huyền sắc.

4. Điều trị

4.1. Điều trị bằng thuốc

4.1.1. Kinh nguyệt trước kỳ

4.1.1.1. Thể Huyết nhiệt

● Phép trị: Thanh nhiệt, lương huyết, điều kinh.

● Bài thuốc sử dụng

+ Bài Tứ vật Cầm liên thang (Nữ khoa chuẩn thang) gồm Hoàng liên 20g, Hoàng cầm 20g, Bạch thược 10g, Thục địa 10g, Đương quy 10g, Xuyên khung 10g ± Tri mẫu 06g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết, điều kinh. Trục ứ sinh tân.	Quân
Sinh địa	Tư âm bổ huyết, thông thận kinh.	Thần
Bạch thược	Hòa doanh lý huyết, thông tỳ kinh.	Tá
Xuyên khung	Hành khí hoạt huyết, thông can kinh tâm bào.	Tá
Hoàng cầm	Thanh thấp nhiệt, lương huyết	Tá
Hoàng liên	Thanh nhiệt giải độc chỉ huyết	Tá

4.1.1.2. Thử Huyết ứ

- Phép trị: Hoạt huyết khứ ứ, điều kinh.
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Tứ vật đào hồng thang (Trích Y tôn kim giám) gồm Đương quy 12g, Xích thược 12g, Sinh địa 12g, Xuyên Khung 08g, Đào nhân 08g, Hồng hoa 06g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết, điều kinh.	Quân
Xích thược	Hòa doanh lý huyết, thông tỳ kinh	Tá
Sinh địa	Tư âm bổ huyết, thông thận kinh.	Thần
Xuyên khung	Hành khí hoạt huyết, thông can kinh tâm bào.	Tá
Đào nhân	Hành khí hoạt huyết, thông can kinh tâm bào.	Tá
Hồng hoa	Phá ứ huyết sinh huyết hoạt huyết	Tá

4.1.1.3. Thử Khí hư

- Phép trị: Bổ khí cố kinh.
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Bổ khí cố kinh hoàn gồm Đảng sâm 16g, Hoàng kỳ 12g, Bạch linh 04g, Sa nhân 04g, Bạch truật 08g. Tán nhỏ thành bột, làm viên ngày uống 20 -30 viên.

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết, điều kinh.	Quân
Xích thược	Hòa doanh lý huyết, thông tỳ kinh.	Tá
Sinh địa	Tư âm bổ huyết, thông thận kinh.	Thần
Xuyên khung	Hành khí hoạt huyết, thông can kinh tâm bào.	Tá
Đào nhân	Hành khí hoạt huyết, thông can kinh tâm bào.	Tá
Hồng hoa	Phá ứ huyết sinh huyết hoạt huyết	Tá

4.1.1.4. Thử hư nhiệt

- Pháp trị: Dưỡng âm thanh nhiệt lương huyết, điều kinh.
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Lương địa thang (trích Phó thị nữ khoa) gồm Sinh đại 40g, Mạch môn 20g, Huyền sâm 40g, Địa cốt bì 12g, Bạch thược 20g, A giao 12g. (Xem Bệnh học YHCT ★, trang 263)

4.1.1.5. Thử Đàm thấp

- Pháp trị: Tiêu đàm khứ ứ điều kinh
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Tinh khung hoàn (trích Đơn khê) gồm Nam tinh 160g, Xuyên khung 120g, Thương truật 120g, Hương phụ (chế với đồng tiền) 160g. Tất cả tán bột uống với nước sôi.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Nam tinh	Khu phong hóa đàm.	Quân
Xuyên khung	Hành khí hoạt huyết, thông tâm can kinh bào.	Thần
Thương truật	Lý khí hóa đờm.	Tá
Hương phụ (chế)	Hành khí, khai uất, điều kinh.	Tá

4.1.2. Kinh nguyệt đến sau kỳ

4.1.2.1. Thể Hư hàn

- Pháp trị: Ôn kinh, trừ hàn bổ hư.
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Ngải tiền hoàn (Bài Tứ vật thang gia giảm) gồm: Thục địa 12g, Đương qui 10g, Xuyên khung 10g, Bạch thược 8g, Ngô thù du 8g, Đảng sâm 16g, Ngải cứu 12g, Trần bì 8g, Thạch xương bồ 8g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Thục địa	Bổ huyết, dưỡng huyết	Thần
Đương quy	Bổ huyết, hoạt huyết, điều kinh.	Thần
Xuyên khung	Hành kinh hoạt huyết giảm đau.	Thần
Ngải cứu	Ôn kinh điều hòa khí huyết.	Quân
Ngô thù du	Ôn trung tán hàn giải uất.	Quân
Bạch thược	Liễm âm dưỡng huyết chỉ thống.	Tá
Đảng sâm	Bổ tỳ kiện vị ích khí.	Tá
Thạch xương bồ	Ôn kinh khai khiếu hóa đàm.	Tá

4.1.2.2. Thể Thực hàn

- Pháp trị: Ôn kinh tán hàn
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Ôn kinh thang (trích Phụ nhân lương phương) gồm Bạch truật sao 12g, Nhân sâm 08g, Đương qui 12g, Quế chi 08g, Xuyên khung 12g, Ngưu tất (sao rượi) 08g, Thược dược 12g, Đơn bì 08g, Sinh khương 08g, Cam thảo 08g, Bán hạ chế 04g, Mạch môn 04g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Quế chi	Ôn kinh thông mạch, tán hàn.	Quân
Sinh khương	Tán hàn, hồi dương, thông mạch.	Quân
Nhân sâm	Đai bổ nguyên khí, ích huyết sinh tân.	Thần
Đương quy	Dưỡng huyết hoạt huyết.	Thần
Xuyên khung	Hành khí, hoạt huyết.	Tá
Thược dược	Liễm âm, dưỡng huyết, bình can.	Tá
Ngưu tất	Hành huyết, tán ứ.	Tá
Đơn bì	Tả phục hỏa.	Tá
Cam thảo	Ôn trung, điều hòa các vị thuốc.	Sứ

4.1.2.3. Thể Huyết hư

- Pháp trị: Bổ huyết điều kinh
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Thập toàn đại bổ thang (trích Cục phương) gồm Đảng sâm 12g, Xuyên khung 08g, Phục linh 08g, Đương quy 08g, Bạch truật 12g, Thục địa 08g, Cam thảo 04g, Bạch thược 12g, Hoàng Kỳ 12g, Quế nhục 04g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đảng sâm	Bổ tỳ, kiện vị, ích khí, sinh tân dịch.	Quân
Phục linh	Thẩm thấp, thanh tả nhiệt.	Tá
Bạch truật	Bổ khí, Kiện tỳ, hòa trung.	Thần
Đương quy	Dưỡng huyết, sinh huyết.	Quân
Sinh địa	Tư âm, dưỡng huyết.	Thần
Thược dược	Bổ huyết, hòa huyết.	Tá
Xuyên khung	Hành huyết, hoạt huyết.	Tá
Hoàng kỳ	Bổ khí, thăng dương khí của tỳ.	Thần
Quế nhục	Bổ hỏa, thông huyết mạch, trừ hàn tích.	Tá
Cam thảo	Ôn trung, điều hòa các vị thuốc	Sứ

4.1.2.4. Khí uất

- Pháp trị: Hành khí, giải uất, điều kinh
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Tiêu Dao thang gia vị gồm Sài hồ 12g, Trần bì 06g, Bạch truật 12g, Đương quy 06g, Bạch linh 08g, Bạc hà 04g, Bạch thược 08g, Cam thảo 04g, Sinh khương 04g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Sài hồ	Sơ can giải uất.	Quân
Bạc hà	Phát tán phong nhiệt.	Thần
Đương quy	Dưỡng huyết, sinh huyết.	Thần
Bạch thược	Dưỡng huyết, liễm âm, lợi tiểu.	Thần
Bạch truật	Táo thấp hóa đàm lợi thủy.	Tá
Bạch linh	Lợi thủy thẩm thấp kiện tỳ.	Tá
Sinh khương	Giải biểu tán hàn.	Tá
Cam thảo	Ôn trung, hòa vị.	Sứ
Trần bì	Hành khí táo thấp hóa đàm.	Tá

4.1.2.5. Thể Đờm trở

- Pháp trị: Hóa đàm – bổ hư
- Những bài thuốc sử dụng

+ Bài Lục quân tử thang (trích Cục phương) gồm Nhân sâm 12g, Bạch truật 12g, Bạch linh 12g, Cam thảo 08g, Trần bì 08g, Bán hạ 08g, Sinh khương 3 lát, Đại táo 3 trái. Công dụng trị chứng Tỳ Vị hư + Đàm thấp. (Xem Điều trị Viêm sinh dục bạch đới thể đàm thấp).

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Xuyên khung	Hoạt huyết, thông huyết	Thần
Phục linh	Lợi thủy, thẩm thấp, tiêu đàm.	Tá
Đương quy	Sinh huyết, dưỡng huyết.	Quân
Bán hạ chế	Giáng khí nghịch, tiêu đàm thấp.	Tá

Cam thảo	Ôn trung, điều hòa các vị thuốc.	Sứ
Gừng	Ôn trung, tiêu đàm.	Tá

4.1.3. Kinh nguyệt không định kỳ

Pháp chung: Điều lý, khí huyết, bổ hư.

4.1.3.1. Thể Can khí uất

- Pháp trị: Sơ Can lý khí giải uất.

- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Đơn Chi Tiêu Dao thang (trích Nữ khoa chuẩn thang) gồm Sài hồ 12g, Trần bì 06g, Bạc hà 08g, Đương quy (sao) 06g, Bạch truật (sao) 12g, Cam thảo 04g, Bạch linh 08g, Đơn bì (sao) 08g, Bạch thược (sao rượu) 08g, Chi tử 08g, Gừng lùi 2 lát. (Xem Bệnh học YHCT ★, trang 273)

4.1.3.2. Thể Tỳ khí hư

- Pháp trị: Bổ Tỳ, ích khí, điều kinh

- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Quy Tỳ thang gồm Đảng sâm 12g, Long nhãn 06g, Hoàng kỳ 08g, Táo nhân 08g, Bạch truật 12g, Phục thần 08g, Đương quy 12g, Viễn chí 06g, Bạch linh 12g, Đại táo 3 trái (xem Bệnh học YHCT ★, trang 352).

4.1.3.3. Thận âm hư

- Pháp trị: Bổ Can Thận, cố kinh.

- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Cố âm tiền (trích Cảnh Nhạc Toàn Lưu) gồm Nhân sâm, Thỏ ly tử, Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Viễn chí, Ngũ vị tử, Chích thảo.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Thục địa	Bổ thận dưỡng âm, dưỡng huyết.	Quân
Hoài sơn	Bổ phế thận, sinh tân, chỉ khát.	Quân
Nhân sâm	Bổ nguyên khí, sinh tân dịch.	Tá
Thỏ ty tử	Bổ can thận, cố tinh.	Thần
Sơn thù	Ôn bổ can thận, sáp tinh, chỉ hãn.	Thần
Viễn chí	Thanh phế hòa vị giáng khí, hóa đàm.	Tá
Ngũ vị tử	Sáp tinh, ích thận, sinh tân dịch.	Tá
Chích thảo	Ôn trung, điều hòa các vị thuốc.	Sứ

4.1.4. Kinh nguyệt nhiều

Pháp chung ích khí, thanh nhiệt, cố xung, nhiếp huyết.

4.1.5. Thể Huyết nhiệt

- Pháp trị: Lương Huyết, bổ huyết.

- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Tam bổ hoàng (trích Nữ khoa chuẩn thang) gồm Hoàng Liên (sao) 12g, Hoàng Cầm (sao) 12g, Hoàng Bá (sao) 12g, Sơn chi 08g. tán bột trộn mật làm hoàn. (xem Bệnh học YHCT ★★, Viêm sinh dục-trang 253). Cũng bài thuốc công thức như trên còn có tên là Hoàng liên giải độc thang, có tác dụng tả hỏa giải độc, dùng cho trường hợp hỏa nhiệt quá độ làm thần minh bách loạn, ngoài ra còn dùng để chữa mụn nhọt, riêng bài Tâm bổ hoàng cả 3 vị thuốc Hoàng liên, Hoàng bá, Hoàng cầm đều sao lên có tác dụng trừ bệnh tích nhiệt ở Tam tiêu, thanh tả nhiệt ở ngũ tạng.

4.1.6. Thể Khí hư

- Pháp trị: Bổ khí nhiếp huyết.

- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Cử nguyên tiền (trích Cảnh Nhạc Toàn Thư) gồm Nhân Sâm 16g, Ngải Diệp 08g, Hoàng Kỳ 16g, Ô Tắc cốt 06g, Chích Thảo 08g, A giao 06g, Thăng ma 12g, Bạch truật 12g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Nhân sâm	Bổ nguyên khí, sinh tân dịch.	Quân
Ngải diệp	Điều hòa khí huyết, ôn kinh, chỉ huyết.	Thần
Hoàng kỳ	Bổ khí, cố biểu, tiêu độc.	Quân
Ô tặc cốt	Ôn kinh chỉ huyết.	Tá
A giao	Tư âm bổ huyết, chỉ huyết.	Quân
Thăng ma	Thanh nhiệt giải độc, thăng đề.	Tá
Bạch truật	Kiện vị, hòa trung, táo thấp.	Tá
Chích thảo	Ôn trung, hòa vị.	Sứ

4.1.7. Kinh nguyệt ít

Pháp chung: Dưỡng huyết, hòa huyết, điều khí.

- Thể Huyết hư

● Pháp trị: Bổ huyết, ích Tỳ khí.

● Bài thuốc sử dụng

+ Bài Nhân sâm tư huyết thang (trích Sản bửu bách vấn) gồm Nhân sâm, Hoài sơn, Phục linh, Đương quy, Xuyên khung, Bạch thược.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Nhân sâm	Bổ nguyên khí, sinh tân dịch.	Quân
Đương quy	Bổ huyết, dưỡng huyết.	Quân
Hoài sơn	Kiện tỳ vị, sinh tân dịch.	Tá
Phục linh	Lý khí hóa đàm.	Tá
Xuyên khung	Hoạt huyết, chỉ thống.	Tá
Bạch thược	Dưỡng huyết, chỉ thống.	Thần

4.1.8. Thống kinh

Pháp chung: Thông điều khí huyết, chỉ thống. Thực chứng

4.1.8.1. Thể Huyết ứ

● Pháp trị: Hoạt huyết tiêu ứ trệ.

● Bài thuốc sử dụng

+ Bài Huyết phủ trực ứ thang (trích Y lâm Cải Thác) gồm Xuyên Khung 10g, Hương Phụ 08g, Quy Thân 15g, Thanh Bì 08g, Sinh Địa 15g, Chỉ Xác 06g, Xích Thược 12g, Mộc Hương 06g, Đào Nhân 08g, Cam Thảo 04g, Hồng Hoa 08g, Ngưu Tất 12g. (xem Bệnh học YHCT ★, trang 326).

4.1.8.2. Thể Khí trệ

● Pháp trị: Hành khí tiêu ứ.

● Bài thuốc sử dụng

+ Bài Thanh nhiệt điều huyết thang (trích Cổ Kim Y Giám) gồm Đương Quy, Xuyên Khung, bạch Thược, Sinh Địa, Đào Nhân, Hồng Hoa, Nga Truật, Hoàng Liên, Đơn Bì.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết.	Quân

Xuyên khung	Hoạt huyết, chỉ thống.	Quân
Sinh địa	Tư âm, bổ thận, dưỡng huyết.	Thần
Bạch thược	Dưỡng huyết, chỉ thống.	Thần
Hoàng liên	Thanh nhiệt giải độc.	Quân
Đào nhân	Phá huyết, trục ứ, nhuận táo.	Tá
Hồng hoa	Phá ứ huyết, sinh huyết, hoạt huyết.	Tá
Nga truật	Phá huyết, hoạt huyết.	Tá
Đơn bì	Thanh huyết nhiệt, tán ứ huyết.	Tá

4.1.8.3. **Thể Phong hàn**

- Pháp trị: Lý khí ôn kinh
- Bài thuốc sử dụng
- + Bài Ôn kinh thang

Hư chứng

4.1.8.4. **Thể Hư hàn**

- Pháp trị: Ôn kinh Dưỡng huyết.
- Bài thuốc sử dụng
- + Bài Tiểu Ôn Kinh thang (trích Giảm dị phương) gồm Đương Quy 12g, Hắc phụ tử 12g, Sắc uống nóng.

4.1.8.5. **Thể Hư nhiệt**

- Pháp trị: Dưỡng âm lương huyết chỉ thống.
- Bài thuốc sử dụng
- + Bài Đơn chỉ tiêu dao tán

4.1.8.6. **Thể Can Thận khuy tổn**

- Pháp trị: Bổ Can Thận.
- Bài thuốc sử dụng
- + Bài Điều Can thang (trích Phó thanh chủ nữ khoa) gồm Hoài sơn, Sơn thù, Đương quy, A giao, bạch thược, Cam thảo.
- + Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	Dưỡng huyết, hoạt huyết.	Quân
Hoài sơn	Bổ tỳ cố thận.	Thần
Sơn thù	Ôn can, trừ đàm.	Tá
Bạch thược	Bổ huyết, hòa huyết.	Tá
A giao	Tư âm bổ huyết.	Tá
Cam thảo	Ôn trung, điều hòa các vị thuốc.	Sứ

4.1.9. **Bế kinh**

Pháp trị chung: Bổ huyết, kiện Tỳ Vị, dưỡng Can Thận là chính.

4.1.9.1. **Thể Huyết khô**

- Pháp trị: Bổ huyết – Dưỡng Can Thận.
- Bài thuốc sử dụng
- + Bài Bổ Thận Địa Hoàng Hoàn (trích Tổ am y yếu) gồm Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Trạch tả, Đơn bì, Tri mẫu, Hoàng Bá, Viễn chí, Phục thần, Hắc táo nhân, Huyền sâm, mạch môn, Trúc diệp, Quy Bản, tang phiêu tiêu. (xem Bệnh học YHCT ★, trang 202).

4.1.9.2. Thử Huyết ứ

- Pháp trị: Thông huyết trực ứ.
- Bài thuốc sử dụng
 - + Bài Thông ứ tiền (trích Mạc cảnh Toàn Thư) gồm Quy Vĩ, Hồng hoa, Hương Phụ, Sơn Thù, Ô Dước, Thanh Bì, mộc Hương, Đào Nhân, Đan Sâm, Trạch lan, Ngưu Tất.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Quy vĩ	Dưỡng huyết, hoạt huyết	Quân
Hồng hoa	Phá ứ huyết, sinh huyết, hoạt huyết.	Quân
Hương phụ	Hành khí, khai uất, điều kinh.	Thần
Sơn thù	Bổ can thận, sáp tinh khí, không khiêu.	Tá
Ô dước	Thuận khí, âm trung tiêu.	Tá
Thanh bì	Thông kinh lạc.	Tá
Mộc hương	Thông kinh, hành khí, chỉ thống.	Tá
Đào nhân	Phá huyết, trực ứ, nhuận táo.	Tá
Đan sâm	Bổ huyết, điều kinh.	Tá
Trạch lan	Thanh nhiệt, tán ứ, trừ đờm.	Tá
Ngưu tất	Hành huyết, tán ứ.	Tá

4.1.9.3. Thử Hàn ngưng

- Pháp trị: Ôn thông kinh mạch.
- Bài thuốc sử dụng
 - + Bài Ôn kinh thang

4.1.9.4. Thử Nhiệt xác

- Pháp trị: Bổ huyết thanh nhiệt.
- Bài thuốc sử dụng
 - + Bài Nhất quán tiền (trích Ngụy ngọc hoàng phương) gồm Sinh Địa 20g, Quy Thân 12g, Câu Kỷ Tử 20g, mạch Môn 12g, sa Sâm 12g, Xuyên luyện tử 20g.

4.1.9.5. Thử Đàm ngấn

- Pháp trị: Hóa đàm thồn kinh.
- Bài thuốc sử dụng
 - + Bài Hậu phát nhi trần thang (trích Đơn kê phương) gồm Cam thảo 02g, Trần bì 08g, Bán hạ chế 04g, Phục linh 04g, Hậu phác 04g. (xem phần Kinh nguyệt đến sau kỳ Thử đàm trở).

4.1.9.6. Thử Khí uất

- Pháp trị: Lý khí giải uất.
- Bài thuốc sử dụng
 - + Bài Khai uất nhi trần thang (trích Vạn thị phụ khoa phương) gồm Trần Bì 08g, Phục linh 08g, Trương Truật 08g, Hương phụ 08g, Xuyên khung 08g, Bán hạ 04g, Thanh Bì 04g, Nga Truật 04g, Bình lang 04g, Cam thảo 02g, Mộc hương 02g.

+ Phân tích bài thuốc

Vị thuốc	Tác dụng YHCT	Vai trò
Trần bì	Kiểm tỳ, lý khí, hóa đàm.	Quân
Phục linh	Lý khí, hóa đàm.	Quân
Thương truật	Ôn trung hóa đàm.	Tá

Hương phụ	Hành khí, khai uất, điều kinh.	Thần
Xuyên khung	Hoạt huyết chỉ thống.	Thần
Bán hạ	Giáng khí nghì, trừ thấp, hóa đàm.	Tá
Thanh bì	Hành khí, tiêu trệ.	Tá
Nga truật	Tán khí, thông kinh, chỉ thống.	Tá
Bình lang	Trợ khí liễm âm.	Tá
Mộc hương	Hành khí, kiện tỳ, khai uất, chỉ thống.	Thần
Cam thảo	Ôn trung, hòa vị.	Sứ

4.1.9.7. Thử Tỳ hư

- Pháp trị: Bổ Tỳ Vị ích khí.
- Bài thuốc sử dụng

+ Bài Bổ trung ích khí thang gia giảm gồm Chích hoàng kỳ 08g, Nhân sâm 12g, Quy thân 08g, Xuyên khung 08g, Trần bì 06g, Sài hồ 06g, Bạch thược (sao rượu) 08g, Bạch truật (sao mật) 08g, Thần khúc (sao) 08g, Chích thảo 04g, Mạch Nha (sao) 08g, Gừng 3 lát, Đại táo 3 trái

BÀI 10. THỐNG KINH

(Hành kinh phúc thống)

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày định nghĩa và triệu chứng các thể lâm sàng của bệnh thống kinh.
- Nêu phương pháp điều trị và bài thuốc sử dụng cho từng thể lâm sàng.

1. Định nghĩa

Thống kinh là cơn đau bụng kinh có liên quan đến thời gian trước, sau hoặc trong khi hành kinh.

Cơ chế bệnh sinh: Đau bụng kinh là sự ngăn trở vận hành khí và huyết. Vì kinh nguyệt do huyết hóa ra mà huyết lại tùy thuộc vào khí để vận hành, do đó khí huyết thuận hòa, sung túc thì không gây ra đau bụng khi hành kinh, nhưng khi khí huyết suy kém hoặc ứ trệ sẽ làm kinh xuống không thông gây hiện tượng đau bụng kinh.

2. Triệu chứng lâm sàng: Thống kinh phân thành 2 loại

2.1. Thực chứng:

2.1.1. Do phong hàn tà: Trong giai đoạn hành kinh mà nhiễm phải hàn tà như ăn thức ăn quá sống, lạnh hoặc cơ thể nhiễm lạnh từ phần dưới cơ thể, làm khí huyết ngưng trệ gây đau

Triệu chứng:

- Đau bụng khi hành kinh kèm đau lưng, đau cứng cổ gáy, sợ lạnh
- Sắc kinh tím đen, kinh xuống ít hoặc tắc bất chợt. Sắc mặt xanh, tiêu lỏng, rêu lưỡi trắng mỏng
- Mạch phù hoãn hoặc trầm hoãn.

2.1.2. Do khí trệ:

- Kỳ kinh thường không đều, lượng kinh ít
- Đau bụng dưới, trướng tức nhiều hoặc lan lên ngực sườn, đau lưng, trước khi hành kinh và bắt đầu kỳ kinh.
- Trước khi hành kinh thường có hiện tượng vú căng đau, đầu đau hoặc 1/2 bên đầu
- Sắc mặt xanh, nôn hoặc ợ hơi
- Lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng. mạch huyền sác.

2.1.3. Do huyết ứ:

Triệu chứng:

- Bụng dưới căng đau dữ dội trước và đầu kỳ hành kinh, đau nổi cục cứng, đè vào đau thêm, đau như phát sốt. Kinh xuống không, màu đen thẫm có cục huyết ra thì đỡ đau
- Sau khi hành kinh lượng kinh vẫn còn rỉ rả, có khi tắc ngưng.
- Sắc mặt xanh tím, da khô, táo bón, mặt lưỡi tím sẫm. mạch trầm sác.

2.2. Hư chứng

2.2.1. Thể hư hàn:

- Đau bụng suốt kỳ hành kinh, đau lâm râm, chườm nóng dễ chịu, đau lưng, mệt mỏi
- Kinh cuối kỳ màu nhợt, lượng ít, sắc da xanh, môi nhợt
- Rêu lưỡi trắng nhuận, mạch trì tế.

2.2.2. Thể hư nhiệt

- Bụng dưới đau âm ỉ sau kỳ. kinh đến sớm, lượng kinh ít
- Sắc mặt xanh, gò má hồng, lòng bàn tay nóng, bốc rức, khó ngủ, táo bón

- Lưỡi đỏ, rêu mỏng vàng, mạch tế sác hoặc đới huyền

2.2.3. Thể khí huyết hư nhược

- Đau bụng lâm râm trong khi hành kinh và sau khi hành kinh, đè vào dễ chịu
- Sắc kinh nhạt, lượng kinh ít
- Sắc mặt trắng xanh, chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi mỏng
- Tinh thần uể oải, tiếng nói yếu, mạch hư tế.
- Nếu huyết hư, khí trệ gây đau thì sau khi hành kinh huyết dư xống chưa sạch thì đau không ngưng.

2.2.4. Thể can thận khuy tôn

- Đau bụng dưới sau khi hành kinh, đau lan vùng thắt lưng
- Sắc kinh nhạt, lượng ít
- Lưỡi nhạt, rêu lưỡi mỏng. mạch trầm tế.

3. Điều trị:

3.1. Thực chứng:

3.1.1. Thể huyết ứ:

- Pháp trị: Hoạt huyết, tiêu ứ trệ
- Bài thuốc Huyết phủ trực ứ thang:

Vị thuốc	Liều lượng	Cơ chế tác dụng	Vai trò
Đương quy	15g	Hoạt huyết dưỡng huyết	Quân
Xuyên khung	10g	Hoạt huyết chỉ thống	Tá
Hương phụ	08g	Hành khí	Tá
Chỉ xác	06g	Hóa khí tiêu đàm	Tá
Thanh bì	08g	Lý khí khoan hung	Tá
Sinh địa	15g	Dưỡng âm dưỡng huyết	Quân
Xích thực	12g	Hoạt huyết	Tá
Mộc hương	06g	Hành khí	Tá
Đào nhân	08g	Hoạt huyết thông kinh	Thần
Hồng hoa	08g	Hoạt huyết hóa ứ thông kinh	Thần
Ngưu tất	12g	Hoạt huyết thông kinh	Tá
Cam thảo	04g	Điều hòa các vị thuốc	Tá

3.1.2. Thể khí trệ

- Pháp trị: Hành khí tiêu ứ
- Bài thuốc Thanh nhiệt điều huyết thang:

Vị thuốc	Liều lượng	Cơ chế tác dụng	Vai trò
Đương quy	15g	Dưỡng huyết hoạt huyết	Quân
Xuyên khung	10g	Hoạt huyết chỉ thống	Quân
Sinh địa	15g	Tư âm, bổ thận, dưỡng huyết	Thần
Bạch thực	10g	Dưỡng huyết, chỉ thống	Thần
Hoàng liên		Thanh nhiệt giải độc	Quân
Đào nhân	08g	Phá huyết trực ứ nhuận táo	Tá
Hồng hoa	08g	Phá ứ huyết, sinh huyết	Tá

Nga truat	08g	Phá huyết hoạt huyết	Tá
Đơn bì	10g	Thanh huyết nhiệt, tán huyết ứ	Tá

3.1.3. Thể phong hàn:

- Pháp trị: Lý khí ôn kinh
- Bài thuốc: Ôn kinh thang

Vị thuốc	Liều lượng	Cơ chế tác dụng	Vai trò
Quế chi	10g	ôn kinh tán hàn	Quân
Sinh khương	10g	hồi dương thông mạch	Quân
Nhân sâm	8g	đại bổ nguyên khí ích huyết sinh tân	Thần
Mạch môn	8g	Nhuận phế sinh tân	Thần
Xuyên khung	8g	hành khí hoạt huyết chỉ thống sinh tân	Tá
Đơn bì	10g	Thanh huyết nhiệt tán huyết ứ	Tá
Bạch thược	10g	dưỡng huyết	Thần
A giao	08g	dưỡng huyết bổ phế nhuận táo	Thần
Bán hạ	08g	hạ khí nghịch tiêu đờm	Tá
Ngô thù	08g	nôn mửa đau bụng tiêu chảy	Tá
Đương quy	10g	dưỡng can huyết	Thần
Cam thảo	08g	Điều hòa các vị thuốc	Sứ

3.2. Hư chứng:

3.2.1. Thể hư hàn

- Pháp trị: ôn kinh dưỡng huyết
 - bài thuốc: Tiểu ôn kinh thang
- Đương quy 12g, Hắc phụ tử 12g sắc uống nóng

3.2.2. Thể hư nhiệt:

- Pháp trị: dưỡng âm lương huyết chỉ thống
- Bài thuốc Tiêu dao tán

3.2.3. Thể khí huyết hư nhược:

- Pháp trị: Điều khí dưỡng huyết
- Bài thuốc: Bát trân gia hương phụ, mộc hương

3.2.4. Thể can thận khuy tổn

- Pháp trị: Bổ can thận
- Bài thuốc Điều can thang

Vị thuốc	Liều lượng	Tác dụng YHCT	Vai trò
Đương quy	15g	Dưỡng huyết hoạt huyết	Quân

Hoài sơn	15g	Bổ tỳ cố thận	Thần
Bạch thược	10g	Bổ huyết hòa huyết	Tá
Sơn thù	10g	ôn can trừ đàm	Tá
A giao	10g	Tư âm bổ huyết	Tá
Cam thảo	04g	ôn trung điều hòa các vị thuốc	Tá

BÀI 11. THIẾU SỮA - TẮC TIA SỮA

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày nguyên nhân gây thiếu sữa- tắc tia sữa.
- Nêu các thể lâm sàng phương pháp điều trị thiếu sữa- tắc tia sữa.

1. Nguyên nhân:

Theo YHCT sữa do huyết sinh ra, dựa vào khí để vận hành. Vì vậy sữa có nhiều hay ít có liên quan mật thiết đến khí và huyết. Khí huyết hư nhược sữa loãng và ít, khí huyết thịnh suy tùy thuộc vào tỷ lệ. Nếu sinh hóa tiên thiên tốt nhưng can khí phạm vị cũng dẫn đến ít sữa (tắc tia sữa)

1.1. Khí huyết hư nhược:

Đối với những sản phụ yếu đuối, khí huyết yếu, sau sinh mất nhiều máu làm khí huyết suy tôn, khí huyết thiếu không sinh ra sữa.

1.2. Can khí uất trệ

Do yếu tố tinh thần làm can khí uất kết, kinh mạch trở trệ, khí huyết tuần hoàn bị trở ngại không đủ để sinh ra sữa.

2. Điều trị:

2.1. Khí huyết hư nhược:

Không có hoặc ít sữa, vú không căng, da khô người mệt mỏi, chóng mặt, ù tai, tim hồi hộp, thở đoản hơi, ăn ít, mạch hư tế.

Phép chữa: Bổ huyết, ích khí, sinh sữa

Bài thuốc: Thông nhũ đơn

Đảng sâm	12	Bổ khí
Hoàng kỳ	12	Bổ khí
Đương quy	12	Dưỡng huyết
Mạch môn	10	Tư âm dưỡng huyết
Mộc thông	12	Thông lạc, lý khí
Cát cánh	12	Thông lạc, lý khí
Móng giò lợn	02 cái	Bổ ích thông nhũ

2.2. Thể can khí uất trệ: Tắc tia sữa

Không ra sữa, vú căng tức đau, phát sốt, phát rét, ngực chướng đau, ăn kém, lưỡi nhợt, mạch huyền.

Phép chữa: Sơ can, giải uất, thông lợi

Bài thuốc: Hà nhũ dũng tuyền thang

Đương quy	12	Bổ huyết, hoạt huyết
Bạch thược	12	Liễm âm dưỡng huyết
Sài đất	16	Thanh nhiệt giải độc
Xuyên khung	8	Hoạt huyết
Ngưu tất	16	Hoạt huyết
Mộc thông	12	Thông lạc
Xuyên sơn giác	12	Thông lạc hạ nhũ
Thiên hoa phấn	12	Tư âm dưỡng huyết
Cam thảo	8	Điều hòa các vị thuốc

Đơn bì	8	Thanh can nhiệt
Sài hồ	8	Thanh can giải uất

BÀI 12. BỆNH VIÊM SINH DỤC NỮ

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Trình bày cơ chế bệnh sinh theo Y học cổ truyền của bệnh viêm sinh dục nữ.
- Nêu triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán bệnh viêm sinh dục nữ theo Y học hiện đại.
- Trình bày các thể lâm sàng và phép trị theo Y học cổ truyền của bệnh bạch đới.

1. Khái niệm

1.1. Theo yhhđ

Viêm sinh dục nữ là loại bệnh phụ khoa thường gặp, thuộc nhóm bệnh xã hội, lây truyền chủ yếu qua tiếp xúc tình dục. Ở các nước đang phát triển, 3 bệnh viêm nhiễm đường sinh dục do vi khuẩn lậu, nhiễm chlamydia và giang mai nằm trong số 10 đến 20 bệnh mắc cao nhất gây ảnh hưởng đến chỉ số sức khỏe và sinh sản hàng năm do các biến chứng như viêm vòi trứng, vô sinh, thai ngoài tử cung và tử vong chu sinh.

- Các tác nhân gây bệnh phổ biến nhất là Lậu cầu, Chlamydia trachomatis, xoắn khuẩn Treponema pallidum, Trichomonas vaginalis, nấm Candida albicans, các virus...

- Nguồn lây là những người trưởng thành có tiếp xúc giao hợp, nhóm nguy cơ lây lan cao là gái mại dâm.

- Đường lây: Lây truyền qua đường sinh dục, tuy nhiên vẫn có thể lây qua khi dùng chung dụng cụ.

- Đặc điểm lâm sàng khởi đầu bằng tình trạng viêm niêm mạc cơ quan sinh dục nữ, gây viêm tại chỗ sau đó lan theo chiều dài bộ phận sinh dục, và gây bệnh toàn thân. Triệu chứng chung là có nhiều huyết trắng. Viêm sinh dục phân làm 2 hội chứng lâm sàng chính

- Viêm sinh dục dưới gồm: viêm âm hộ, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung

- Viêm sinh dục trên (viêm tiểu khung) gồm: Viêm tử cung, viêm phần phụ.

1.2. Theo yhct

Bệnh danh YHCT

Chứng trạng viêm nhiễm ở bộ phận sinh dục nữ được gọi là Đới Hạ. Đới có nghĩa dây thắt lưng quần, Hạ có nghĩa ở phần dưới. Theo nghĩa rộng (Nội kinh), Đới Hạ là bệnh phát sinh ở phần dưới lưng quần, bao gồm tất cả các bệnh thuộc kinh đới, thai, sản. Theo nghĩa hẹp, Đới Hạ dùng để chỉ một chất dẽo, nhớt, chảy từ trong âm đạo ra liên miên không dứt thường hay gọi là Bạch Đới, trong phạm vi này bao gồm tất cả các tên được phân loại theo màu sắc, tính chất, dịch tiết như sau: Bạch Đới, Hoàng Đới, Bạch Dâm, Bạch Bàng, Thanh Đới, Bạch trọc, Xích đới, Xích Bạch đới, Ngũ sắc đới.

Cơ chế bệnh sinh YHCT

Nguyên nhân sinh chứng đới hạ không ngoài 3 phương diện nội nhân, ngoại nhân, bất nội ngoại nhân.

- Nội nhân: Do tình chí bất ổn, thể chất suy nhược ảnh hưởng chủ yếu đến 2 tạng Can và Tỳ. Can kinh uất hỏa, Tỳ khí suy yếu. Sách phó thanh chủ nữ khoa viết: “Hề tỳ khí hư, Can khí uất, đều có thể sinh ra bệnh đới hạ”.

- Ngoại nhân: Phong hàn, thấp nhiệt, đàm thấp dễ xâm phạm vào cơ thể khi cơ thể đang lao thương quá độ gây khí huyết hao tổn, nhưng chỉ khi tà nhập đến phần bào lạc thì mới gây ra chứng đới hạ.

- Bất nội ngoại nhân: do ăn uống no say quá mà giao hợp, hoặc dùng nhiều chất cao lương mỹ vị hoặc uống dạng thuốc khô tảo lâu ngày tổn thương tới âm huyết làm dương khí bị nén xuống cũng tạo thành chứng đới nhiệt. Tuy rằng có nhiều nguyên nhân để sinh ra bệnh nhưng chỉ khi bệnh tà gây bệnh ở cửa bào cung làm cho mạch Xung, Nhâm bị thương tổn mới là nguyên nhân chính của các bệnh đới hạ, như khi chức năng Tỳ bị rối loạn, Tỳ dương mất khả năng vận hóa được thấp trọc đình trệ ở bên trong phải chảy xuống Bào cung, làm rối loạn mạch Xung, Nhâm mới phát sinh ra chứng Đới Hạ.

Hậu quả của bệnh lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới nguyên nhân khí làm cơ thể suy yếu có hại cho việc sinh sản, truyền giống nên cần chú ý vệ sinh bộ phận sinh dục, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

2. Những hội chứng lâm sàng

2.1. Theo yhhđ

2.1.1. Viêm sinh dục có hệ thống do vi trùng lậu

2.1.1.1. Nguyên nhân

Do vi khuẩn *Neisseria gonorrhoea* (lậu cầu), thuộc nhóm gram âm, do Neisser tìm ra năm 1879. Vi khuẩn di chuyển từng hồi bám vào niêm mạc của bộ phận sinh dục. Lậu cầu rất yếu, chết rất nhanh ở nhiệt độ thường, nó chỉ phát triển được ở môi trường có độ ẩm, nhiệt độ thích hợp, nhiều khí CO₂ và giàu chất dinh dưỡng. Đời sống khoảng 4 giờ và cứ 15 phút lại phân chia một lần.

2.1.1.2. Dịch bệnh học

99% lây truyền do giao hợp giữa nam và nữ, phụ nữ mang mầm bệnh có khả năng lây truyền bệnh qua nhiều tháng, nhiều năm.

2.1.1.3. Sinh bệnh học

- Bệnh khởi đầu bằng tình trạng viêm cấp của niệu đạo, viêm tuyến Bartholin và niêm mạc âm đạo, cổ tử cung. Vi khuẩn lậu nhập vào niêm mạc bộ phận sinh dục, gây phản ứng viêm tại chỗ, kéo theo bạch cầu đa nhân để thực bào nên làm tiết ra mủ ở niệu đạo, âm đạo.

- Sau đó vi trùng lan theo nội mạc tử cung. Gây viêm tử cung, viêm phần phụ. Nội mạc tử cung phù, sung huyết, nhưng tình trạng bệnh lý thường tự thuyên giảm vì mủ, có thể tự thoát ra ngoài qua cổ tử cung. Mủ có thể tự thoát ra khỏi vòi trứng, vào ổ bụng gây viêm phúc mạc vùng chậu, tụ mủ vòi chậu. Nhưng do vi trùng lậu là vi trùng ăn lan trong lớp niêm mạc nên về sau vòi trứng dễ bị bịt kín, ứ mủ hoặc nước. Hậu quả là vô sinh.

2.1.1.4. Triệu chứng và Chẩn Đoán

- Triệu chứng cơ năng: Sốt, đau vùng chậu, tiểu gắt, tiểu nhiều lần, tiểu ít.

- Triệu chứng thực thể: Tuyến Bartholin viêm đỏ, có mủ. Huyết trắng nhiều, dịch đục mủ. Niêm mạc âm đạo viêm đỏ.

Thăm âm đạo: Âm đạo, tử cung, hai phần phụ rất đau, đôi khi có bọc mủ làm phồng túi cùng Douglas.

- Xét nghiệm: Công thức máu: Bạch cầu tăng với tỷ lệ đa nhân trung tính tăng. Soi tươi: Nhuộm gram có vi trùng lậu (song cầu trùng). Cây trùng: Có vi trùng lậu.

2.1.1.5. Điều trị

- Nguyên tắc: Điều trị đúng sớm và đủ liều, luôn điều trị cả cho người chồng hoặc bạn tình.

- Thuốc kháng sinh: Procain Penicilline hoặc Tetracycline, Clarithromycine nếu dị ứng.

2.1.2. Viêm sinh dục do những nguyên nhân khác

2.1.2.1. Viêm âm đạo và cổ tử cung do *Trichomonas vaginalis*

2.1.2.1.1. Sinh bệnh học

bình thường pH âm đạo acid, pH=4,5 -5 (do vi trùng Doderlein biến đổi glycogen ở tế bào âm đạo thành acid lactic. Khi pH âm đạo bị kiềm, dễ bị *Trichomonas* xâm nhập. Tỷ lệ nhiễm bệnh chiếm khoảng 25% số phụ nữ có viêm sinh dục, ở phụ nữ vệ sinh kém thường lây qua giao hợp.

2.1.2.1.2. Triệu chứng

- Ít ngứa rất âm đạo, ít đau khi giao hợp
- Huyết trắng nhiều, loãng, vàng hơi xanh, có bọt, hôi.
- Niêm mạc cổ tử cung và âm đạo có nhiều nốt đỏ lấm tấm.

2.1.2.1.3. Chẩn đoán

- Soi tươi: Tìm được *Trichomonas* bơi trong giọt dung dịch sinh lý
- Nhuộm Giemsa

2.1.2.1.4. Điều trị: Metronidazol (Flagyl), hiệu quả 95%

2.1.2.2. Viêm âm đạo cổ tử cung do nấm *Candida albicans*

2.1.2.2.1. Sinh bệnh học

Nấm men *Candida* bình thường tìm thấy trong ống tiêu hóa, các hốc tự nhiên và có sự bình quân giữa các tạp khuẩn sống cộng sinh, không gây bệnh. Nếu dùng kháng sinh bừa bãi hoặc corticoide, cơ thể giảm sức đề kháng thì nấm *Candida* sẽ tăng trưởng và gây bệnh. Tỷ lệ nhiễm bệnh là 10% tổng số viêm sinh dục, thường xảy ra ở bệnh nhân tiểu đường, dùng kháng sinh nhiều.

2.1.2.2.2. Triệu chứng

- ♦ Ngứa âm hộ, âm đạo nhiều
- ♦ Huyết trắng màu trắng đục, đặc, lợn cợn
- ♦ Niêm mạc âm đạo sưng đỏ, phù nề có cặn trắng như sữa bám vào cổ tử cung hoặc thành âm đạo.

2.1.2.2.3. Chẩn đoán

- ♦ Soi tươi với KOH 10%: 40-80% các trường hợp thấy sợi tơ nấm và bào tử nấm
- ♦ Nhuộm Gram: 70-80% trường hợp thấy sợi tơ nấm và bào tử nấm.

d/ Điều trị: Mycostatin: đặt âm đạo, uống 5000.000 đơn vị x 3 ngày x 14 ngày

2.1.2.3. Viêm âm đạo, cổ tử cung do tạp trùng

2.1.2.3.1. Sinh bệnh học

loại tụ cầu chiếm ưu thế, phụ nữ mang những chủng vi khuẩn không gây bệnh nhưng khi sức đề kháng yếu do bệnh nhiễm trùng, hoặc kháng sinh bừa bãi... thì các chủng vi khuẩn tăng độc lực và gây bệnh.

2.1.2.3.2. Triệu chứng

- ♦ Ngứa âm đạo ít, ít đau do giao hợp
- ♦ Huyết trắng vàng như mù, lượng nhiều

2.1.2.3.3. Chẩn đoán: Tìm vi trùng bằng nhuộm gram, cấy trùng

2.1.2.3.4. Điều trị: Lựa chọn kháng sinh theo kháng sinh đồ. Đặt thuốc âm đạo

2.1.3. Viêm nội mạc tử cung

2.1.3.1. Viêm nội mạc tử cung cấp

Thường gặp sau sanh : do sót nhau hay nhiễm trùng ối, sau nạo thai nhiễm trùng, do vi trùng lậu

- Triệu chứng và Chẩn đoán.

Tùy thuộc vào triệu chứng của vi trùng gây bệnh, tùy sức đề kháng của bệnh nhân và tùy tình trạng dẫn lưu của buồng tử cung

+ Viêm nhẹ: sốt nhẹ, có sản dịch hôi

+ Viêm nặng: sốt cao mạch nhanh. Có mủ từ tử cung chảy ra, cổ tử cung viêm đỏ.

+ Viêm tắc tĩnh mạch: tử cung lớn, co lại kém, di động tử cung rất đau/

+ Làm xét nghiệm: Thử dịch âm đạo, cấy trùng để chẩn đoán

+ Cần chẩn đoán phân biệt

+ Viêm nội mạc tử cung cấp do vi trùng lậu.

+ Viêm ruột thừa cấp.

+ Viêm bể thận

- Điều trị

+ Kháng sinh theo kháng sinh đồ, liều cao

+ Nong cổ tử cung, nạo tử cung sau khi cho kháng sinh.

+ Phẫu thuật nguồn nhiễm trùng trong những trường hợp điều trị bảo tồn không kết quả.

2.1.3.2. Viêm nội mạc tử cung mạn

Thường là di chứng của viêm cấp, xảy ra sau viêm cấp, sau xảy thai hoặc do có u xơ tử cung dưới niêm mạc

- Triệu chứng lâm sàng

+ Đau hạ vị âm ỉ, cảm giác nặng vùng hạ vị, đau lưng, đau bụng khi có kinh.

Tiểu gắt, buốt

+ Rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ kinh bị ngắn lại, rong kinh.

+ Huyết trắng nhiều, loãng màu vàng, hôi

+ Vô sinh, dễ xảy thai hoặc nhau tiền đạo

+ Khám: Tử cung nhỏ, di động đau

- Điều trị

+ Điều trị những ổ nhiễm trùng ở âm đạo, cổ tử cung nếu có

+ Kháng sinh thích hợp

+ Nạo tử cung sau khi cho kháng sinh 3 ngày.

BÀI 13. ĐẠI CƯƠNG VỀ HIỂM MUỘN

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Nêu các nguyên nhân gây hiếm muộn theo Y học cổ truyền.
- Trình bày các thể lâm sàng và phép trị bệnh hiếm muộn theo Y học cổ truyền.

Nội dung chính

1. Thăm khám cho người vợ:

- **Hỏi bệnh:** Vấn đề liên quan đến kinh nguyệt để phỏng đoán khả năng hoạt động của buồng trứng, khả năng toàn vẹn của đường sinh dục nữ như tuổi bắt đầu hành kinh bình thường, không sớm quá, không muộn quá, chu kỳ kinh bình thường, không dài quá, không ngắn quá, tương đối đều đặn, lượng huyết kinh trung bình, không có thống kinh.. thì có thể hy vọng người phụ nữ có phóng noãn bình thường và đường sinh dục thông.

- **Thăm khám:** bộ phận sinh dục, tử cung, phần phụ xem có khối u, có viêm dính.. gọi ý tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh.

- **XN máu:** VS, khí hư, chụp vòi trứng, các chỉ số tử cung, sinh thiết niêm mạc tử cung.

2. Thăm khám cho người chồng:

- **Hỏi bệnh:** Vấn đề viêm nhiễm, tiền sử bệnh quai bị mắc sau tuổi dậy thì, tần suất giao hợp, lượng tinh dịch xuất ra có nhiều hay không, bệnh nhân có liệt dương không

- **Thăm khám:** Xem có đủ hai tinh hoàn có nằm trong bìu không, Tinh hoàn to hay nhỏ, nặng hay nhẹ, xem mũ tinh hoàn có to và rắn không, nắn có đau hay không. Cuối cùng xem thừng tinh, các mạch tinh có bị phình giãn tĩnh mạch tinh không (dễ gây ít tinh trùng hoặc tinh trùng yếu)

- Sinh thiết tinh hoàn: nếu thấy các ống sinh tinh có hoạt động, có các mào tinh và tinh trùng thì nguyên nhân không tinh trùng do tắc ống dẫn tinh, Nếu thấy ống sinh tinh không hoạt động tức là tinh hoàn không sản sinh tinh trùng

- **Theo YHCT:** Con gái sau khi lập gia đình mà chưa sinh đẻ lần nào hoặc sau khi một lần rồi sau đó không thụ thai được nữa, đều gọi là Không thụ thai (Bất dụng)

Trường hợp trước gọi là "Vô tử" trường hợp sau gọi là 'Đoạn tử' Tương đương chứng 'Vô Sinh' của YHHĐ.

3. Nguyên Nhân

3.1. Do bẩm sinh tiên thiên. Những yếu tố dị thường ở một số cơ quan sinh sản: Không có tử cung, lệch tử cung, tắc ống dẫn trứng...Ngày xưa vì bẩm sinh mà không thai nghén, cổ nhân chia ra làm 5 loại: Loa, Giảo, Cỗ, Giác, Mạch, tương tự trong y học hiện đại là Hẹp xương chậu, Dị dạng âm đạo, Dị dạng âm hộ (Màng trinh dày), Ái nam ái nữ, vô sinh nguyên phát (Nhi hóa tử cung) Đàn bà không con vì kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt không đều vì thất tình tổn thương ở trong, khí lục dâm quá nhiều ở ngoài, hoặc khí huyết không điều hòa, âm dương thiên thắng mà sinh ra. Điều này cho thấy nguyên nhân ở trong và ngoài đã tạo ra chứng không thụ thai. Cũng có thể do âm dương không hòa hợp. Sách 'Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận' nhận định "Đàn bà nhiều đàm không con, tử cung lạnh không con, chất uế trọc ngưng kết, đới hạ cũng không con".

3.2. Do thận hư: Do tiên thiên bất túc hoặc sinh hoạt tình dục quá mức làm tổn thương Thận khí, mạch Xung Nhâm bị hư suy không hoá được khí, không hành được thủy, hàn thấp ứ trệ ở mạch Xung Nhâm, thấp ngừng trệ ở bào mạch, không thể thụ thai được. Hoặc vào kỳ kinh bị cảm hàn, hàn tà xâm nhập làm tổn thương đến mạch Xung Nhâm, khiến không thể thụ thai.. hoặc do sinh hoạt tình dục quá độ làm hao tổn tinh huyết, Thận âm suy tổn, mạch Xung Nhâm có ít huyết, không thể thụ thai được.

Như vậy, âm huyết bất túc, âm hư nội nhiệt, nhiệt phục ở trong mạch Xung Nhâm, nhiệt vào huyết hải... khiến cho tinh khí không tụ lại được nên không thể thụ thai.

3.3. Do Can uất: Do tình chí không thoải mái, Can khí uất kết, mất chức năng sơ tiết, huyết khí không hoà, mạch Xung Nhâm không điều hoà, khiến cho tinh không tụ lại được, vì vậy không thể thụ thai được.

3.4. Do Đàm thấp: Cơ thể vốn mập mạp, hoặc ăn nhiều cao lương mỹ vị, đờm thấp sinh ra ở bên trong, làm ngăn trở khí cơ, khiến cho mạch Xung Nhâm không đều, mờ nhiều làm ngăn trở bào cung. Hoặc Tỳ mất chức năng kiện vận, ăn uống thất thường, hàn thấp bên trong sinh ra, thấp trọc dồn xuống hạ tiêu, làm ngăn trở mạch Xung Nhâm. Thấp tụ lại ở Bào cung khiến cho tinh khí không tụ lại được khiến cho không thể thụ thai được.

3.5. Do Huyết ứ: Sau khi hành kinh, kinh không ra hết, lại gặp lạnh hoặc sinh hoạt tình dục, tà khí và huyết tranh nhau, ứ trệ lại ở bào mạch, tinh khí không tụ lại được nên không thể thụ thai.

4. Chẩn Đoán

- Dựa vào bệnh sử: Kinh nguyệt không đều, bị bệnh đới hạ, thai sản dị thường.
- Dựa vào bệnh chứng: Lập gia đình đã hai năm mà chưa thụ thai.

5. Phép Trị

Nên tìm hiểu nguyên nhân bệnh như thế nào, phân biệt hàn nhiệt, tùy chứng để điều trị.

Nếu kinh nguyệt không đều, thì chú ý điều kinh, tùy theo chứng mà trị. Nếu thiên về hư hàn nên bổ hư ôn trung. Huyết hư có nhiệt nên tư âm thanh nhiệt. Nếu vì thấp đờm thì tảo thấp hóa đờm. Nếu do ứ huyết nên hành huyết, trục ứ. Nếu có khí uất, nên lý khí, giải uất. Chủ yếu là phải trị ở gốc bệnh thì mới có thể thụ thai. Trong thời gian điều trị, tránh lao động quá sức, ăn uống điều độ, đầy đủ, kiêng bớt sinh hoạt tình dục, giữ tinh thần thoải mái thì mới có khả năng thụ thai.

6. Triệu Chứng

6.1. Hư Hàn: Trong kỳ kinh màu kinh nhạt và ít, bụng dưới lạnh đau, tử cung lạnh, không thể thụ thai.

- Phép trị: Tán hàn, ôn cung.
- Bài thuốc: Ngải Phụ Ôn Cung Hoàn

Ngải diệp 90g, Hương phụ 180g, Đương quy 90g, Tục đoạn 150g, Ngô thù, Xuyên khung, Bạch thược, Hoàng kỳ đều 60g, Sinh địa 30g, Quan quế 15g. Tán bột, làm viên to bằng hạt ngô, mỗi lần uống 50 - 60 viên

* Hoặc bài Ôn Thận Hoàn

Thục địa, Thù du nhục đều 90g, Ba kích 60g, Đương quy, Thỏ ty tử, Lộc nhung, Ích trí nhân, Sinh địa, Đỗ trọng, Phục thần, Sơn dược, Viễn chí, Tục đoạn, Xà sàng tử đều 3g. Tán bột, trộn với mật làm thành viên, mỗi lần uống 12g. Nếu không có nhiệt được tinh nên tăng Lộc giác, thêm Long cốt, Mẫu lệ.

6.2. Chứng Nhiệt: Nóng âm i trong xương do hư lao, sốt về chiều, kỳ kinh không đều, lượng kinh ít.

- Pháp trị: Thanh nhiệt tư âm
- Bài thuốc: Thanh cốt tử âm thang

Mẫu đơn bì, Mạch môn đông, Huyền sâm, Sa sâm đều 15g, Bạch truật 9g, Thạch斛 6g, Ngũ vị tử 1,5g. Sắc uống

6.3. Đàm thấp: Kinh nguyệt không đều, màu kinh nhạt, lượng nhiều, cơ thể béo, chóng mặt, hồi hộp, đói hạ, nhạt miệng, rêu lưỡi nhờn.

- Pháp trị: Táo thấp hóa đờm
- Bài thuốc: Hậu Phác Nhị Trần Thang

Đương quy, Đại hoàng, Đào nhân đều 9g, Hậu phác, Cát cánh, Nhân sâm, Xích thực, Phục linh, Quế tâm, Cam thảo, Ngưu tất, Quất bì, phác tiêu, mẫu đơn bì đều 6g, Phụ tử 6g

6.4. Huyết ứ: nhiều năm không thụ thai, kinh nguyệt đến sau kỳ, lượng kinh ít hoặc nhiều, màu kinh đỏ tối, có máu cục, hoặc kinh ra không dứt, bụng dưới đau, ấn vào đau hơn, trước khi hành kinh thì đau, lưỡi đỏ tím, rìa lưỡi có điểm ứ huyết, mạch huyền sáp.

- Pháp trị: Hoạt huyết, hoá ứ, ôn kinh, thông lạc.
- Bài thuốc: Thiếu phúc trục ứ thang

Tiểu hồi, Can khương, Diên hồ sách, Một dược, Đương quy, Xuyên khung, Nhục quế, Xích thực, Bò hoàng, Ngũ linh chi.

Nếu huyết ứ lâu ngày hoá nhiệt, thấy bụng dưới đau, ấn vào đau, kinh nguyệt ra nhiều, màu đỏ tối, dính, có hòn cục, lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch hoạt sáp. Dùng phép thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, hoá ứ. Dùng bài Huyết phủ trục ứ thang thêm Ý dĩ nhân, Kim ngân hoa.

6.5. Khí uất: Thất tình tổn thương làm kinh không đều, tâm thần kém vui, bụng tức sườn đau, hồi hộp, tinh thần mỏi mệt.

- Pháp trị: Hành khí giải uất

- **Bài thuốc:** Thục địa, Phụ tử (sao) đều 18g, Quy thân, Ngô thù du, Xuyên khung đều 12g, Bạch thực dược, Bạch Phục linh, Trần bì, Diên hồ sách, Mẫu đơn bì, Can khương đều 9g, Quan quế, Thục địa đều 6g. sắc uống.

BÀI 14. ĐẠI CƯƠNG VỀ NAM HỌC

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng:

- Nêu các nguyên nhân dẫn đến bệnh lý về nam học.

- Nêu các triệu chứng lâm sàng và nguyên tắc điều trị bệnh nam học theo Y học cổ truyền.

1. Đại cương:

Theo YHCT thì hậu âm chỉ hậu môn còn tiền âm bao gồm bộ phận sinh dục ngoài và lỗ tiểu. Về nam giới thì tiền âm có ngọc hành, âm nang (tinh hoàn, mào tinh hoàn), tuyến tiền liệt. Bệnh của tiền âm nam thường gặp có Tử ung (Viêm mào tinh hoàn, Viêm tinh hoàn), Tử đờm (Lao tinh hoàn, Lao mào tinh hoàn), Thủy sán (Thủy tinh mạc), Viêm tuyến tiền liệt, U xơ tuyến tiền liệt, v.v...

Sự Quan hệ giữa tiền âm và kinh lạc, tạng phủ

- **Quan hệ với Kinh lạc** : theo đường vận hành và phân bố của các đường kinh thì tiền âm có liên quan với các kinh can và mạch Nhâm, mạch Đốc, cho nên bệnh ở tiền âm phần lớn có liên quan với 3 kinh mạch đó.

- **Quan hệ với tạng phủ**: theo sách ‘Ngoại Khoa Chân Thuyên’ thì dương vật (ngọc hành, âm hành) thuộc Can, lỗ tiểu (mã khẩu) thuộc Tiểu trường, âm nang, (bìu dái) thuộc Can, tinh hoàn (tinh hoàn, thận tử), ống dẫn tinh và cơ quan trực thuộc Can. Tiền âm nam có chức năng tình dục và bài tiết nước tiểu, có quan hệ mật thiết với thận và bàng quang. Thận chủ thủy và tàng tinh, tinh khiểu và niệu khiểu (để phóng tinh và bài tiết nước tiểu) thuộc thận và có quan hệ với các cơ quan ở tiền âm. Nguồn gốc của tinh là ở ngũ tạng lục phủ và tàng tại thận, việc tàng tiết của tinh có quan hệ với thận và tâm. Nước tiểu được sinh ra và bài tiết là do sự hoạt động của tỳ phế thận và tam tiêu. Vì vậy bệnh của tiền âm có quan hệ với tạng phủ và kinh mạch sau: Can, Tâm, Tỳ, Thận, Phế và Tiểu trường, Bàng quang, Tam tiêu cùng 2 mạch Nhâm và mạch Đốc.

2. Nguyên Nhân

- **Tâm Hỏa Vượng**: vì tâm là cơ quan chủ tể cho nên nếu chức năng tâm rối loạn đều có thể ảnh hưởng đến tất cả ngũ tạng lục phủ, vì thế việc phóng tinh, bài tiểu cũng bị rối loạn.

Trên lâm sàng trạng thái bệnh lý thường gặp là Tâm âm hư, Tâm hỏa vượng, Nhiệt hạ chú tiểu trường gây nhiễu loạn tinh cung, làm cho huyết bị rối loạn sinh ra chứng tinh huyết, niệu huyết.

- **Can mất sơ tiết**: Can mạch đi qua tiền âm, can chủ cân (chủ tông cân - tức ngọc hành). Can mất chức năng sơ tiết dẫn đến kinh lạc khí huyết ứ trệ, thấp nhiệt hạ chú, thấp độc xâm nhập tiền âm đều có thể phát sinh các chứng như Tử ung, Nang ung, Thủy sán, Tinh trọc, Huyết tinh, v.v...

- **Tỳ vận hóa rối loạn**: Tỳ chủ vận hóa cho nên nếu vận hóa suy giảm thì thủy thấp hạ chú hoặc tân dịch ngưng trệ thành đờm mà sinh ra chứng Tử đờm, Thủy sán, Âm cân đờm hạch... Tỳ hư trung khí hạ hãm, bàng quang không chế ước được sinh chứng tiểu nhiều lần, tiểu són. Tỳ không thông huyết sinh chứng niệu huyết, huyết tinh...

- **Phế thất tuyên giáng**: phế chủ khí, khí mất tuyên giáng, thủy đạo không được thông đều sinh chứng tiểu không thông lợi, tiểu ít, nếu phế khí hư, chức năng thận bàng quang suy giảm không chế ước được sinh ra tiểu són, đái dầm.

- **Thận khí hao tổn** : tinh hoàn thuộc thận, thận khai khiểu ở nhị âm, thận và tiền âm có liên quan mật thiết cho nên bệnh của thận trực tiếp ảnh hưởng đến tiền âm.

Thận khí suy thì chức năng sinh dục suy giảm và chuyển hóa nước trong cơ thể rối loạn mà sinh ra vô sinh nam, liệt dương hoặc rối loạn tiểu tiện.

Thận âm hư sinh hỏa vượng đốt tân dịch thành đờm gây nên chứng Tử đờm hoặc chứng Lao dương vật, hỏa nhiều tinh cung sinh ra chứng tinh trọc, huyết tinh.

Thận dương hư thì tinh thần mệt mỏi, lưng gối lạnh, tiểu nhiều lần hoặc tiểu són, tiểu không tự chủ, liệt dương, tảo tinh, tiết tinh v.v...

- Bàng quang khí hóa bất lợi: theo YHCT, chức năng khí hóa của thận và bàng quang tốt thì bài tiết nước tiểu mới bình thường, nếu bàng quang khí hóa suy giảm thì sinh ra chứng tiểu nhiều lần, tiểu gắt, tiểu buốt, bàng quang mất chức năng chế ước gây nên tiểu không tự chủ, đái dầm.

3. Triệu Chứng

- Tiểu nhiều lần: người bình thường đi tiểu mỗi ngày trung bình 4-5 lần ban ngày và 0-2 lần ban đêm. Tiểu nhiều lần hơn là trạng thái bệnh lý thường gặp trong các chứng viêm bàng quang, viêm niệu đạo, sỏi tiết niệu dưới, tiền liệt tuyến tăng sinh.

- Tiểu gấp: biểu hiện muốn đi tiểu là phải đi ngay không nín được, thường đi kèm với tiểu nhiều lần.

- Tiểu đau: cảm giác đau lúc tiểu, gặp trong các chứng viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tiền liệt tuyến, sỏi Bàng quang và sỏi niệu quản dưới.

- Tiểu khó: tiểu phải dùng lực, dòng nước tiểu nhỏ, nhỏ giọt hoặc đứt đoạn, gặp trong các bệnh tiền liệt tuyến tăng sinh, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo.

- Nước tiểu ứ đọng: Nước tiểu đọng trong bàng quang mà không đi tiểu được, gặp trong các chứng viêm tiền liệt tuyến cấp, tiền liệt tuyến tăng sinh.

- Tiểu bất tự chủ: nước tiểu tự động chảy ra không cầm được. Chứng nhẹ chỉ lúc ngủ hoặc chỉ lúc bàng quang đầy nước tiểu, nặng thì nước tiểu chảy thường xuyên.

- Huyết niệu: có thể mắt nhìn được nước tiểu đỏ hoặc chỉ phát hiện hồng cầu dưới kính hiển vi, có 4 loại :

+ Chảy máu niệu đạo không liên quan đến nước tiểu.

+ Tiểu có máu lúc bắt đầu tiểu: thường do xuất huyết ở phần trước niệu đạo.

+ Tiểu có máu vào phần cuối lúc tiểu : bệnh thường ở phần sau niệu đạo, rò bàng quang, tiền liệt tuyến và tinh nang.

+ Toàn nước tiểu có máu: bệnh tổn thương từ cổ bàng quang trở lên.

+ Chất xuất tiết niệu đạo: là máu hoặc mủ, thường gặp trong các chứng tổn thương niệu đạo, viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến ...

+ Khối u: lúc ứ đọng nước tiểu, có khối u vùng bụng dưới. Có khối u bìu dái trong các chứng Tử đờm, Tử ung, Thủy sản.

Trên lâm sàng, bệnh tiền âm nam thường biểu hiện các chứng sau :

- Thấp nhiệt hạ chú: âm nang sưng nóng đỏ, đau, tinh hoàn to đau, bao tinh ứ nước, tiểu gấp, nhiều lần, nước tiểu vàng đậm, dương vật nóng đau, nước tiểu đục...

- Khí huyết ứ trệ: thường gặp ở các bệnh kéo dài mạn tính do kinh mạch không thông, tinh hoàn, mào tinh hoàn cứng đau, bụng dưới hoặc hội âm đầy tức đau, đi tiểu khó.

- Đờm trọc ngưng kết: có triệu chứng chủ yếu là hòn cục ở tinh hoàn, dương vật nổi cục (âm hành đờm hạch), không nóng, không đỏ, không đau, thuộc âm chứng. Đờm trọc có thể hóa nhiệt mà sinh chứng âm hư đờm hỏa nên da đỏ thẫm, hơi nóng và hơi đau hoặc hóa mủ vỡ.

- Thận âm bất túc: do bệnh lâu ngày tổn thương thận, hoặc phòng dục quá độ, nội thương thất tinh, thận âm hao tổn. Triệu chứng lâm sàng thường có lưng gối đau mỏi,

tinh thần mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, mắt ngủ, mồ hôi trộm, âm hư không chế ước được dương, hư hỏa nội động sinh ra lòng bàn chân tay nóng, nước tiểu đỏ, tiểu khó, tiểu ngắn quãng, tiểu nhỏ giọt; hỏa nhiều tinh cung, dương vật dễ cương, di tinh nặng có thể sinh ra huyết tinh.

- Thận dương hư suy: phần lớn do cơ thể vốn hư hoặc bệnh lâu ngày gây nên hư, phòng dục quá độ làm tổn thương thận dương. Đặc điểm lâm sàng là tinh thần mệt mỏi, lưng gối nhức lạnh, liệt dương, di tinh, tiểu nhiều lần hoặc không tự chủ, tràn dịch bao tinh. Dương hư sinh ngoại hàn nên tiểu trong, chân tay lạnh, da bùi dãi lạnh, mạch Trầm Trì Tế.

Trên đây là những chứng thường gặp. Ngoài ra tùy loại bệnh mà có những đặc điểm về lâm sàng sẽ giới thiệu trong các bài về bệnh học.

4. Nguyên tắc điều trị nội khoa

- Thanh nhiệt lợi thấp: chủ trị chứng thấp nhiệt hạ chú. Thường dùng bài Bát chính tán, Long đởm tả can thang.

- Hoạt huyết hóa ứ: trị chứng khí huyết ứ trệ. Thường dùng : Đào hồng tứ vật thang, Huyết Phủ trục ứ thang gia giảm.

- Hóa đờm tán kết: trị đờm trọc ngưng kết. Dùng bài Nhị trần thang

- Tư bổ thận âm: trị thận âm bất túc. Dùng bài Lục vị địa hoàng thang. Nếu âm hư hỏa vượng dùng bài Tri bá địa hoàng hoàn.

- Ôn bổ thận dương: trị thận dương hư, dùng bài Kim quỹ thận khí hoàn.

ĐAU THẦN KINH LIÊN SƯỜN

Mục tiêu:

1. Trình bày được nguyên nhân, cách điều trị đau thần kinh liên sườn của YHCT
2. Nêu được nguyên nhân, triệu chứng các bệnh đau thần kinh liên sườn theo YHCT
3. Nêu được phương pháp điều trị đau thần kinh liên sườn của YHCT

Nội dung chính

1. Khái niệm:

- Đau thần kinh liên sườn là một chứng bệnh được miêu tả trong phạm vi chứng hiệp thống của YHCT.

- Hiệp thống là đau ở một hoặc hai bên mạng sườn, chỉ là một cảm giác chủ quan của người bệnh. Hai bên mạng sườn là đường tuần hoàn của kinh túc quyết âm và túc thiếu dương, cho nên đau mạng sườn phần nhiều có quan hệ mật thiết đến bệnh của Can đởm.

- Nội kinh ghi: “Bệnh của Can thì đau ở hai cạnh sườn lan xuống bụng dưới” và “Tà tại Can thì cạnh sườn đau, sườn là nơi phân giới tuần hoàn của kinh Đởm nên đau cạnh sườn cũng là bệnh của Đởm”.

2. Nguyên nhân cơ chế sinh bệnh:

2.1. Nguyên nhân:

Tuệ Tĩnh cho rằng: “Nội nhân là do giận dữ, bi ai, cảm xúc, đói no, lạnh nóng không đều, té ngã, đàm tích đọng vào sườn cùng kết hợp với huyết ứ mà thành đau,

ngoại nhân là do khí cảm vào kinh thiếu dương như tai điếc, sườn đau là do phong hàn cảm vào thành đau” (Nam dược thần hiệu).

2.2. Cơ chế sinh bệnh:

- Giận dữ, bị ai làm cho can khí rối loạn dễ gây khí trệ. Đói no cũng ảnh hưởng đến sự vận chuyển của khí cơ gây khí trệ.

- Khí trệ làm huyết vận hành kém, dần dần gây nên huyết ứ. Khi có huyết ứ thường có cả khí trệ, chấn thương cũng gây ra huyết ứ và từ đó sinh đau.

- Đàm ẩm lưu trú ở cạnh sườn cũng gây hiệp thống.

- Phong tà thương phế, khí cơ không giáng là can khí hoành nghịch, mạch lạc của can đờm mất hòa giáng gây đau.

- Thấp nhiệt ở trung tiêu ôn kết lại can đờm làm can đờm so tiết mất điều đạt gây đau.

- Can hư, huyết tảo làm cân mạch không được nuôi dưỡng tốt cũng có thể gây đau sườn.

3. Thể lâm sàng:

3.1. Đau thần kinh liên sườn do lạnh:

Do phong hàn phạm vào kinh thiếu dương và lưu ở cạnh sườn gây đau nên chứng ở kinh thiếu dương.

3.1.1. Triệu chứng:

- Đau liên sườn dọc theo đường đi của dây thần kinh, đau nhất ở vùng rãnh sau lưng, đường nách giữa, sụn ức đòn, ho thở đều đau, sợ lạnh, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù.

3.1.2. Pháp điều trị: Hòa giải thiếu dương.

3.1.3. Bài thuốc: Tiểu sài hồ thang gia giảm:

Sài hồ	12g	Bán hạ chế	06g	Quế chi	08g
Đảng sâm	12g	Cam thảo	06g	Bạch chỉ	08g
Thang ma	08g	Sinh khương	08g	Uất kim	08g
Hoàng cầm	08g	Đại táo	12g	Chỉ xác	08g

Ngày sắc uống 01 thang.

3.1.4. Châm cứu:

Ôn châm: - A thị huyết vùng rãnh thần kinh xuất phát.
- Nội quan, Dương lăng tuyền.

3.2. Can khí uất nghịch:

3.2.1. Triệu chứng:

- Đau trướng ở một hoặc hai bên sườn, có cảm giác đầy tức, đau di chuyển, khi đau phụ thuộc vào sự thay đổi tình chí mà tăng giảm, ngực tức, khó chịu, hay thở dài, bụng đầy trướng, ăn ít, người dễ cáu gắt, rêu lưỡi mỏng, mạch huyền.

3.2.2. Pháp điều trị: Sơ can lý khí.

3.2.3. Bài thuốc: Tiêu giao tán gia giảm:

Bạch truật	12g	Bạc hà	06g	Hương phụ	06g
Bạch thược	12g	Thanh bì	08g	Sinhkhương	04g
Bạch linh	12g	Uất kim	08g	Cam thảo	06g
Sài hồ	08g	Đan sâm	08g		

Ngày sắc uống 01 thang.

3.2.4. Châm cứu:

- Châm tả: - A thị huyết, Dương lăng tuyền, Hành gian.
- Châm bình: - Nội quan.

3.3. Đàm ảm lưu trú:

3.3.1. Triệu chứng:

- Đau cạnh sườn, ngực sườn trướng đau, ho khạc đờm, thở gấp, đoản hơi. Khi ho, khạc đờm, xoay chuyển người và thở mạnh thì đau tăng, rêu lưỡi trắng, mạch trầm huyền hoặc trầm hoạt.

3.3.2. Pháp điều trị: Lý khí, **hóa đàm**, thông lạc.

3.3.3. Bài thuốc: Hương phụ truyền phúc hoa thang.

Tử tô	12g	Trần bì	08g	Tuyền phúc hoa	
Bán hạ chế	20g	Phục linh	20g	(bọc trong lụa)	12g
Ý dĩ	20g	Hương phụ	12g		

Ngày sắc uống 01 thang.

Nếu đau bụng thêm: Hậu phác 08g

Đau bụng nhiều thêm: Mộc hương 06g.

3.3.4. Châm cứu:

- Châm tả + cứu: - A thị huyết, Kỳ môn
- Châm bình: - Trung quản, Nội quan, Phong long.

3.4. Huyết ú:

3.4.1. Triệu chứng:

- Sườn đau như bị dùi đâm, đau cố định, ấn vào đau chói thêm, đêm đau tăng hoặc nổi cục, chất lưỡi tía tối hoặc có điểm ứ huyết, mạch sáp.

3.4.2. Pháp điều trị: **Hoạt huyết hành ứ.**

4.4.3. Bài thuốc: Huyết phủ trục ứ thang.

Đào nhân	16g	Chỉ xác	08g	Sài hồ	04g
Xích thực	08g	Hồng hoa	12g	Cam thảo	04g
Cát cánh	06g	Ngưu tất	12g		

Ngày sắc uống 01 thang.

Nếu chảy máu dùng bột cam thảo: 4-8g.

Dùng thuốc ngoài: Nếu do chấn thương huyết ú: hạt gấc mài với dấm bôi vào chỗ ứ huyết để làm tan huyết ú.

3.4.4. Châm cứu:

- Châm tả: A thị huyết.
- Châm bình: Huyết hải, Nội quan, Cách du, Dương lăng tuyền.

3.5. Can đởm thấp nhiệt:

3.5.1. Triệu chứng:

- Đau vùng cạnh sườn, đắng miệng, tâm phiền, ngực khó chịu, kém ăn, buồn nôn, tiểu tiện vàng, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch huyền hoạt.

3.5.2. Pháp điều trị: **Thanh nhiệt lợi thấp.**

3.5.3. Bài thuốc: Long đởm tả can thang.

Long đởm thảo	06g	Đương quy	04g	Sa tiền tử	08g
(Sao rượu)		Sinh địa	08g	Sài hồ	06g
Chi tử (sao rượu)	06g	Mộc thông	08g	Cam thảo	04g
Hoàng cầm sao	08g	Trạch tả	12g		

Ngày sắc uống 01thang.

3.5.4. Châm cứu:

- Châm tả: A thị huyết
- Châm bình: Phong long, Túc tam lý, Dương lăng tuyền.

3.6. Can âm bất túc:

3.6.1. Triệu chứng:

- Sườn đau âm ỉ, đau dai dẳng không dứt, miệng khô, tâm phiền, đầu mắt choáng váng, mắt nhìn không rõ, chất lưỡi đỏ, ít rêu, mạch huyền tế sác.

3.6.2. Pháp điều trị: Tư âm dưỡng can (Bổ can huyết).

3.6.3. Bài thuốc : Nhất quán tiền.

Sa sâm	12g	Kỷ tử	12g	Sinh địa	24g
Quy thân	12g	Mạch môn	12g	Xuyên luyện tử	06g

Ngày sắc uống 01 thang.

Nếu đau nhiều gia thêm: Uất kim 08g, Trầm hương 08g, Diên hồ sách 08g.

3.6.4. Châm cứu:

- Châm tả : A thị huyết

- Châm bổ: Can du, Nội quan, Thần môn, Tam âm giao.

4. MỘT SỐ BÀI THUỐC DÂN GIAN (Tuệ Tĩnh toàn tập)

Bài 1: - Gốc họ giã nát sao với dấm bọc lụa mà chườm chỗ đau là khỏi ngay.

- Kết hợp dùng họ cả rễ và lá giã nát vắt lấy nước, hòa vào rượu lấy nửa bát rồi uống.

Bài 2: Hương nhu tươi giã lấy nước uống.

Bài 3: Địa phụ tử sao qua tán bột, mỗi lần uống 4g với rượu.

LƯỢNG GIÁ

1. Nguyên nhân gây đau thần kinh liên sườn của YHHĐ là:

A. Do viêm loét dạ dày – hành tá tràng.

B. Do di chứng Zona vùng mạng sườn.

C. Do viêm đại tràng.

D. Do sỏi thận.

2. Nguyên nhân gây đau thần kinh liên sườn theo YHCT là:

A. Do phong hàn xâm phạm vào kinh thiếu dương.

B. Do phong nhiệt xâm phạm vào kinh thiếu dương

C. Do phong thấp xâm phạm vào kinh thiếu dương.

D. Do khí tảo xâm phạm vào kinh thiếu dương.

3. Pháp điều trị đau thần kinh liên sườn do phong hàn là:

A. Thanh nhiệt giải độc.

B. Phát tán phong thấp.

C. Hòa giải thiếu dương.

D. Hoạt huyết tiêu ứ.

4. Bài thuốc cổ phương thường dùng để điều trị đau thần kinh liên sườn do phong hàn là:

A. Lục vị kỷ cúc.

B. Lục vị tử thang.

C. Tiểu sài hồ thang gia giảm.

D. Thiên ma câu đằng ẩm gia giảm.

LIỆT DÂY THẦN KINH VII NGOẠI BIÊN

Mục tiêu:

1. Chẩn đoán được liệt dây thần kinh VII ngoại biên YHHĐ.
2. Nêu được nguyên nhân liệt dây thần kinh VII ngoại biên theo YHCT.
3. Trình bày được phương pháp điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên theo YHCT.
4. Nêu được phương pháp phòng bệnh liệt dây thần kinh VII ngoại biên.

Nội dung chính

1. Đại cương:

- Liệt dây thần kinh VII ngoại biên là một bệnh khá phổ biến ở mọi lứa tuổi. Một số trường hợp khỏi, còn một số trường hợp để lại di chứng làm ảnh hưởng tới thẩm mỹ đặc biệt với nữ giới.
- Liệt dây thần kinh VII ngoại biên là hiện tượng hạn chế hay không cử động được các cơ bám da mặt.
- Cần nghiên cứu, phát hiện liệt VII ngoại biên đơn độc hay phối hợp (hội chứng giao bên) hay là một phần của hội chứng nền sọ.
- Cần chú ý các nguyên nhân của liệt VII ngoại biên như: U não (u góc cầu tiểu não), u nền sọ, do sang chấn, do viêm nhiễm (viêm màng não nhất là viêm màng não do lao, viêm rễ thần kinh, zona hạch gối, viêm tai xương chũm, viêm xương đá v.v...), liệt VII ngoại biên do lạnh.
- Liệt dây thần kinh VII ngoại biên nằm trong chứng trúng phong kinh lạc hay thực thể, nguyên nhân hay gặp là:
 - + Do lạnh (trúng phong hàn ở kinh lạc).
 - + Do viêm nhiễm (trúng phong nhiệt ở kinh lạc).
 - + Do chấn thương (ứ huyết ở kinh lạc).
- Liệt dây TK VII ngoại biên có bệnh danh là khẩu nhãn oa tà.

2. Thể lâm sàng:

2.1. Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh:

Y học cổ truyền gọi là trúng phong hàn kinh lạc.

2.1.1. Triệu chứng:

- Tại chỗ: Sau khi bị lạnh xuất hiện miệng méo, mắt nhắm không kín, khó thổi lửa, huyết sáo, ăn uống nước trào ra bên liệt, nhai cơm đọng lại ở má bên liệt, nhai khó khăn, nhân trung lệch về bên lành, rãnh mũi má mất.

- Toàn thân: **Sợ gió, sợ lạnh, gai rét**, tiểu tiện bình thường hoặc trong dài, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù hoãn.

2.1.2. Pháp điều trị: **Khu phong tán hàn, thông kinh hoạt lạc.**

2.1.3. Bài thuốc: **Đại tuyền giao thang gia giảm.**

Khương hoạt	08g	Ngưu tất	12g	Phục linh	08g
Độc hoạt	08g	Đương quy	08g	Bạch truật	12g
Tần giao	08g	Thục địa	12g	Hoàng cầm	08g
Bạch chỉ	08g	Bạch thược	08g	Cam thảo	06g
Xuyên khung	08g	Đẳng sâm	12g		

Ngày sắc uống 01 thang.

2.1.4. Châm cứu:

- Cứu, ôn châm, ôn điện châm các huyết:
 - + Tại chỗ: Toán túc, Tinh minh, Đồng tử liêu, Dương bạch, Thừa khấp, Nghinh hương, Địa thương, Giáp sa, Nhân trung, Thừa tương, Ế phong, Ty túc không.

+ Toàn thân: Hợp cốc bên đối diện.

2.2. Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do nhiễm trùng:

- Y học cổ truyền gọi là trúng **phong nhiệt kinh lạc**.

2.2.1. Triệu chứng:

- Tại chỗ: như thể trên.

- Toàn thân: **Sốt, sợ gió, tiểu tiện vàng, đại tiện táo, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch phù sắc.**

2.2.2. Pháp điều trị: Khu phong thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết (khi còn sốt). Khu phong bổ huyết, hoạt lạc (khi hết sốt).

2.2.3. Bài thuốc : Nghiệm phương.

Kim ngân hoa	06g	Ké đầu ngựa	12g	Ngưu Tất	12g
Bồ công anh	16g	Xuyên khung	12g	Trần bì	06g
Thỏ phục linh	12g	Đan sâm	12g		

2.2.4. Châm cứu:

- Châm tả các huyết:

+ Tại chỗ: như thể trên

+ Toàn thân: Hợp cốc bên đối diện, Khúc trì, Nội đình cùng bên.

2.3. Liệt dây thần kinh VII ngoại biên do sang chấn:

Y học cổ truyền gọi là ứ huyết ở kinh lạc.

2.3.1. Triệu chứng:

- Tại chỗ: Như thể trên.

- Nguyên nhân thường do chấn thương như ngã, sau phẫu thuật vùng tai, vùng xương chũm, nhổ răng...

2.3.2. Pháp điều trị: **Hoạt huyết, hành khí tiêu ứ.**

2.3.3. Bài thuốc: **Tứ vật đào hồng gia giảm.**

Xuyên khung	12g	Hồng hoa	08g	Uất kim	08g
Đương quy	12g	Đan sâm	12g	Trần bì	06g
Bạch thược	12g	Ngưu tất	12g	Chỉ xác	06g
Đào nhân	10g	Tô mộc	08g	Hương phụ	06g

Ngày sắc uống 01 thang.

2.3.4. Châm cứu:

- Châm tả các huyết:

+ Tại chỗ: Như thể trên.

+ Toàn thân: Hợp cốc bên đối diện, Huyết hải, Túc tam lý hai bên.

3. Kết luận:

- Liệt dây thần kinh VII ngoại biên là bệnh phổ biến ở mọi lứa tuổi, chẩn đoán xác định không khó. Nhưng chúng ta phải khám tỉ mỉ để phân biệt là liệt dây TK VII ngoại biên đơn độc hay phối hợp (Hội chứng giao bên) và tìm ra nguyên nhân tổn thương để điều trị.

- Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị kết hợp YHHĐ với YHCT nên đem lại kết quả điều trị tốt.

- choạc ứ huyết điều trị bằng châm cứu có kết quả tốt.

- Trường hợp liệt dây TK VII ngoại biên do nhiễm trùng phục hồi chậm hơn.

- Đối với các trường hợp phục hồi chậm (> 2 tháng) thầy thuốc và người bệnh phải kiên trì về thời gian và phối hợp nhiều phương pháp điều trị thường kết quả thu được tốt hơn.

- Không được cứu bông để lại sẹo trên mặt.

- Khi bị bệnh nên đeo kính ra ngoài khi ra ngoài đường, nhỏ thuốc đau mắt nhiều lần trong ngày để bảo vệ mắt. Hướng dẫn người bệnh tự xoa bóp bên mắt bị liệt.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu cho câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân hay gặp nhất trong hệ liệt dây TK VII ngoại biên là:
 - A. Do phong thấp.
 - B. Do phong hàn.**
 - C. Do phong nhiệt.
 - D. Do ứ huyết.
2. Phương pháp điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên do lạnh YHCT thương dùng là:
 - A. Uống thuốc thang.
 - B. Uống thuốc hoàn tán.
 - C. Ôn điện châm.**
 - D. Thủy châm các loại Vitamin.
3. Triệu chứng thường gặp trong liệt dây thần kinh VII ngoại biên là:
 - A. Mắt lác trong.
 - B. Mắt lác ngoài.
 - C. Mắt nhắm không kín.**
 - D. Sụp mí.
4. Phương pháp phòng bệnh liệt dây thần kinh VII ngoại biên trong khi đang điều trị là:
 - A. Uống thuốc đều đặn.
 - B. Nhỏ thuốc mắt, đeo kính khi đi ra ngoài.**
 - C. Ăn uống đầy đủ chất.
 - D. Nằm nghỉ tuyệt đối không vận động.

ĐAU DÂY THẦN KINH HÔNG TO

Mục tiêu

1. Nêu được các nguyên nhân gây bệnh đau dây thần kinh hông to theo YHHĐ.
2. Trình bày được triệu chứng về các thể bệnh đau dây thần kinh hông to theo YHCT.
3. Trình bày được phương pháp điều trị đau dây thần kinh hông to của YHCT.
4. Nêu được phương pháp phòng bệnh đau dây thần kinh hông to

Nội dung chính

1. Đại cương: LASEGUE 20 - 60

- Đau dây thần kinh hông to là một hội chứng đau rễ thắt lưng **L5** và rễ cùng **S1** lan theo hướng đi của dây thần kinh hông.

- **Nguyên nhân** đau dây thần kinh hông to rất phong phú: Cơ năng, thực thể, nhiễm trùng, nhiễm độc, do lạnh, do thoái hóa cột sống, do thoát vị đĩa đệm, do khối u, v.v... Trong đó nguyên nhân đau dây thần kinh hông to do **thoát vị đĩa đệm hay gặp nhất chiếm trên 75%** các trường hợp. Do đó đã mở rộng phạm vi phẫu thuật và thu hẹp phạm vi chẩn đoán đau dây thần kinh hông to do thấp.

- Đau dây thần kinh hông to được miêu tả trong phạm vi chứng thấp tý của YHCT và có bệnh danh: Yêu cước thống, **Tọa cốt phong**, Tọa diên phong.

- **Tý** là bế tắc, chứng tý là chứng kinh mạch bị ngoại tà xâm phạm làm bế tắc dẫn đến khí huyết vận hành bị trở trệ gây nên bì phu, cân cốt, cơ nhục, khớp xương tê bì, nếu nặng thì co duỗi khó khăn. Hai nguyên nhân sau phối hợp với nhau gây nên bệnh:

+ Do nguyên khí hư yếu.

+ Phong hàn thấp ba loại tà khí thừa cơ cùng xâm nhập vào kinh lạc làm bế tắc kinh lạc hoặc phong hàn thấp tà uất lâu hóa nhiệt hoặc kinh lạc có tích nhiệt nay lại có phong hàn tà xâm nhập mà phát ra bệnh.

2. Thể lâm sàng:

2.1. Đau dây thần kinh hông to do lạnh:

Y học cổ truyền gọi là trúng **phong hàn ở kinh lạc**.

2.1.1. Triệu chứng:

- Tại chỗ: Đau sau khi nhiễm **lạnh**, đau từ thắt lưng hoặc từ mông lan xuống chân, đi lại khó khăn, **đau tăng khi lạnh, chườm ấm dễ chịu**, thường có điểm đau khu trú, chưa có teo cơ.

- Toàn thân: **Sợ gió, sợ lạnh**, tay chân lạnh, chân bên bị lạnh hơn chân lành, tiểu tiện trong, đại tiện bình thường, rêu **lưỡi trắng mỏng**, mạch **phủ** hoặc phủ khăn.

2.1.2. **Pháp điều trị:** Khu phong tán hàn, trừ thấp thông kinh hoạt lạc.

2.1.3 Bài thuốc cổ phương: Can khương thương truật linh phụ thang

Can khương	04g	Cam thảo	06g	Bạch chỉ	06g
Thương truật	12g	Tế tân	04g	Quế chi	04g
Bạch linh	12g	Phụ tử chế	04g	Xuyên khung	10g

Ngày sắc uống 01 thang.

Hoặc bài **Đại tân giao thang gia giảm:**

Tân giao	12g	Bạch thược	08g	Thục địa	04g
Cam thảo	08g	Khương hoạt	04g	Bạch linh	04g
Xuyên khung	08g	Phòng phong	04g	Tế tân	04g
Đương quy	08g	Bạch truật	04g	Trần bì	06g

Độc hoạt 08g Sinh địa 04g
Tán nhỏ hoàn viên ngày uống 12g hoặc sắc uống ngày 01 thang.

2.1.4. Châm cứu:

- Ôn điện châm các huyết:

+ Nếu đau theo **kinh bàng quang (đau kiểu rẽ S1)**:

Giáp tích L4-5, L5-S1, Thận du, Đại trường du, Yêu dương quan, Thượng liêu, Trật biên, Thừa phù, Ân môn, Ủy trung, Thừa sơn, Côn lôn.

+ Nếu đau theo **kinh đờm (đau kiểu rẽ L5)**:

Giáp tích L4-5, L5-S1, Đại trường du, Thận du, Thượng liêu, **Hoàn khiêu**, Phong thị, Dương lăng tuyền, Huyền chung, Giải khê. Nếu đau ngón chân cái nhiều thì châm thêm: Thừa phù, Ân môn.

+ Nếu đau cả 2 kinh bàng quang và kinh đờm: châm các huyết ở cả 2 kinh.

- Thủy châm vitamin B12 vào các huyết trên.

- Nhĩ châm: vùng dây thần kinh hông to.

2.2. Đau dây thần kinh to do thoái hóa cột sống gây chèn ép:

Y học cổ truyền gọi là **phong hàn thấp tý kết hợp với can thận hư**.

2.2.1 Triệu chứng:

- Đau vùng thắt lưng lan xuống chân theo đường đi của dây thần kinh hông, đau có cảm giác tê bì, nặng nề, teo cơ, bệnh kéo dài dễ tái phát. Thường kèm theo triệu chứng toàn thân: ăn kém, ngủ ít, tiểu tiện trong, chất lưỡi nhợt bệu, rêu lưỡi trắng dày và nhớt, mạch nhu hoãn hoặc **trầm .nhược**

2.2.2. Pháp điều trị:

Khu phong tán hàn, trừ thấp hoạt huyết, **bổ can thận**. Nếu teo cơ thêm các vị bổ khí huyết.

2.2.3. Bài thuốc cổ phương: **Độc hoạt tang ký sinh thang gia giảm**.

Độc hoạt	12g	Ngưu tất	12g	Đương quy	12g
Phòng	08g	Đỗ trọng	08g	Thục địa	12g
phong					
Tang ký	12g	Đảng sâm	12g	Cam thảo	08g
sinh					
Tế tân	06g	Phục linh	12g	Đại táo	12g
Quế chi	06g	Bạch thược	12g	Trần bì	06g

Ngày sắc uống 01 thang. Khi hết đau ngâm thang thuốc này với 02 lít rượu, ngày uống 40ml chia 2 lần, thời gian uống từ 03-06 tháng.

2.2.4 Châm cứu:

- Điện châm các huyết: như thể trên.

2.3. Đau dây thần kinh do viêm nhiễm:

Y học cổ truyền gọi là thể thấp nhiệt (ít gặp).

2.3.1. Triệu chứng:

- Đau có cảm giác nóng rất đau nhức như kim châm, chân đau nóng hơn so với bên lành, chất lưỡi hồng hoặc đỏ, rêu lưỡi vàng mỏng hoặc dày, mạch sắc.

2.3.2. Pháp điều trị: Thanh nhiệt trừ thấp, hành khí, hoạt huyết.

2.3.3. Bài thuốc cổ phương: Ý dĩ nhân thang + Nhị diệu thang gia giảm:

Ý dĩ	12g	Ngưu tất	16g	Kim ngân hoa	16g
Thương truật	10g	Cam thảo	06g	Ké đầu ngựa	16g
Khương hoạt	12g	Đương quy	12g	Thỏ phục linh	10g
Phòng phong	12g	Hoàng bá	10g	Trần bì	06g

Sắc ngày uống 01 thang.

2.3.4. Châm cứu: Châm tả các huyết: như thể trên.

2.4. Đau dây thần kinh to do sang chấn:

Y học cổ truyền gọi là thể **huyết ú**.

2.4.1. Triệu chứng:

- Đau dữ dội tại một điểm, đột ngột lan xuống chân, chất lưỡi đỏ tím, có điểm huyết ú, rêu lưỡi trắng hoặc vàng, mạch sáp.

2.4.2. Pháp điều trị: Hành khí hoạt huyết khứ ú, thông kinh hoạt lạc

2.4.3. Bài thuốc cổ phương: **Tứ vật đào hồng** gia vị:

Sinh địa	12g	Đào nhân	08g	Kê huyết đằng	10g
Xích thược	10g	Hồng hoa	08g	Uất kim	10g
Xuyên khung	12g	Đan sâm	12g	Trần bì	06g
Quy vĩ	12g	Ngưu tất	12g	Cam thảo	06g

Sắc uống ngày 01 thang.

2.4.4. Châm cứu:

Châm tả các huyết: như thể trên + Huyết hải.

3. Kết luận:

- Đau dây thần kinh hông to là một chứng bệnh hay gặp do nhiều nguyên nhân: Cơ năng, thực thể gây ra. Cần chẩn đoán nguyên nhân bằng các **phương tiện của YHHĐ** để có phương pháp điều trị thích hợp.

- Khả năng điều trị bằng các phương pháp của YHCT có kết quả tốt với các **trường hợp đau dây thần kinh hông to cơ năng**. Các trường hợp đau TK hông to do thực thể kết quả hạn chế cần kết hợp điều trị tại các chuyên khoa sâu của YHHĐ.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân đau dây thần kinh hông to theo YHHĐ là:
 - A. Viêm cơ đáy chậu.
 - B. Lao khớp háng.
 - C. Thoái vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống thắt lưng.
 - D. Sỏi đường tiết niệu.
2. Nguyên nhân đau dây TK hông to theo YHCT là:
 - A. Tâm tỳ hư.
 - B. Phong, hàn, thấp kết hợp với can thận hư.
 - C. Phong nhiệt xâm phạm.
 - D. Khí huyết hư.
3. Pháp điều trị đau dây thần kinh hông to thể phong hàn là:
 - A. Khu phong, thanh nhiệt giải độc.
 - B. Hành khí hoạt huyết, tiêu ú.
 - C. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, hành khí hoạt huyết.
 - D. Khu phong, tán hàn, trừ thấp, bổ khí huyết.
4. Các động tác XBBH thường dùng trong điều trị đau TK hông to là:
 - A. Phân, hợp, vòn, rung, vỗ.
 - B. Vê, miết, chặt, điểm, phân.
 - C. Xát, lăn, day, ấn huyết, vận động.
 - D. Hợp, xoa, miết, rung, vận động.

ĐAU VAI GÁY CẤP HỘI CHỨNG VAI – CÁNH TAY= HC VAI – CỔ

MỤC TIÊU:

1. Trình bày được triệu chứng đau vai gáy cấp theo YHHĐ và YHCT.
2. Nêu được phương pháp điều trị đau vai gáy cấp của YHCT.

Nội dung chính

1. Đại cương: Đau rối tk vai

Nguyên nhân sau đây gây nên:

- Do **phong hàn** xâm phạm vào kinh lạc, cân cơ gây đau và hạn chế vận động cổ.
- Do gánh, **vác nặng, sai tư thế** (gối đầu quá cao một bên) gây khí trệ huyết ứ gây đau và hạn chế vận động cổ.
- Do **thấp nhiệt**: viêm nhiễm, cột sống cổ và cân cơ quanh vùng cột sống cổ gây đau hạn chế vận động cổ.

2. Thể lâm sàng:

2.1. Đau vai gáy do lạnh:

2.1.1 Triệu chứng:

Đột nhiên vai gáy cứng đau, vận động cổ khó, ấn vào cơ thang, cơ ức đòn chũm đau, cơ **cứng hơn bên lành, sợ lạnh, râu lưỡi trắng, mạch phù**.

2.1.2 Pháp điều trị: Khu phong, tán hàn, ôn thông kinh lạc (thông kinh hoạt lạc).

2.1.3 Bài thuốc:

Bài 1: Nghiệm phương

Thiên niên kiện	8g	Kê huyết đằng	12g	Tang chi	12g
Uất kim	8g	Gừng tươi	4g	Cỏ xước	12g
Bạch chỉ	8g	Trần bì	6g	Quế chi	8g

Ngày sắc uống 01 thang.

Bài 2: Bài thuốc cổ phương: Ma hoàng **quế chi** thang gia giảm:

Ma hoàng	8g	Phòng phong	8g	Quế chi	8g
Cam thảo	6g	Sinh khương	4g	Đại táo	6g
Bạch chỉ	8g				

Sắc ngày uống 01 thang.

Bài 3: Quyên tý thang:

Khương hoạt	8g	Đương quy	12g	Độc hoạt	8g
Trích thảo	6g	Xích thược	12g	Sinh khương	4g
Hoàng kỳ	16g	Đại táo	12g		

Sắc uống ngày 01 thang.

2.1.4 Châm cứu: Ôn điện châm các huyết Phong trì, Kiên tinh, Thiên trụ, Thiên tông, **Dương lăng tuyền**, Dương trì cùng bên.

2.1.5 Xoa bóp bấm huyết: Dùng các thủ thuật xát, lăn, day, bóp, bấm, vận động, bấm huyết Lạc châm, bảo bệnh nhân tự vận động cổ.

2.1.6 Châm loa tai: Châm huyết vùng vai gáy.

2.1.7 Thủy châm: Vitamin B1, B6, B12 và huyết hai bên vai gáy bị đau, mỗi huyết 0,5-1ml.

2.2 Đau vai gáy do mang vắc nặng, do sai tư thế:

Y học cổ truyền cho là **khí trệ huyết ứ**.

2.2.1 Triệu chứng: Tại chỗ đau giống như thể do lạnh, thường xảy ra sau khi mang vắc nặng hoặc sau khi nằm nghiêng gối đầu quá cao, mạch phù khản.

2.2.2 Pháp điều trị: **Hoạt huyết tiêu ứ, thư cân hoạt lạc.**

2.2.3 Bài thuốc:

Bài 1: Nghiệm phương:

Tô mộc	10g	Cát căn	12g	Nga truật	10g
Bạch thược	10g	Uất kim	10g	Quế chi	6g
Đào nhân	10g	Trần bì	8g	Hồng hoa	8g
Cam thảo	6g				

Sắc uống ngày 01 thang.

Bài 2: Dùng ngải cứu sao với muối hoặc rượu chườm tại chỗ đau.

Bài 3: Dùng cồn xoa bóp tại chỗ (chú ý tránh uống nhầm gây ngộ độc).

2.2.4 Châm cứu: Châm tả các huyết như thể do lạnh.

2.2.5 Xoa bóp, bấm huyết, thủy châm: giống như thể do lạnh.

2.3 Đau vai gáy do thấp nhiệt (viêm nhiễm):

2.3.1 Triệu chứng: Đau, hạn chế vận động vùng vai gáy, nhìn cột sống **cổ và phần mềm xung quanh sưng, sờ nóng, có thể sốt**, mạch phù tác.

2.3.2 Pháp điều trị: Khu phong, thanh nhiệt, giải độc, hành khí, hoạt huyết.

Bài thuốc, châm cứu giống như điều trị đợt tiến triển của VKDT (thể nhiệt tý).

Không nên xoa bóp bấm huyết.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1 Chẩn đoán đau vai gáy dựa vào các triệu chứng sau:

- A. Ấn vào cơ thang đau.
- B. Ấn vào cơ thang và cơ ức đòn chũm đau, quay cổ dễ.
- C. Co cứng cơ, quay cổ bình thường.
- D. Ấn vào cơ thang, cơ ức đòn chũm đau, quay cổ khó.**

2 Pháp điều trị đau vai gáy cấp thể phong hàn là:

- A. Khu phong thanh nhiệt giải độc.
- B. Khu phong bổ khí, bổ huyết.
- C. Khu phong bổ huyết tiêu ứ.
- D. Khu phong tán hàn, hành khí hoạt huyết.**

3 Pháp điều trị đau vai gáy cấp thể huyết ứ là:

- A. Hành khí hoạt huyết.
- B. Thanh nhiệt, hành khí hoạt huyết.
- C. Hoạt huyết tiêu ứ, thư cân hoạt lạc.**
- D. Khu phong thanh nhiệt trừ thấp.

4 Pháp điều trị đau vai gáy cấp thể nhiệt là:

- A. Thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết.**
- B. Khu phong trừ thấp hàn khí.
- C. Thanh nhiệt trừ thấp, hành khí hoạt huyết.
- D. Trừ thấp nhiệt, giải độc.

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CHO BỆNH NHÂN LIỆT NỬA NGƯỜI DO TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Mục tiêu:

1. Trình bày được các nguyên nhân, triệu chứng bệnh liệt nửa người do TBMMN theo YHCT.
2. Trình bày được phương pháp phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN của YHCT.

Nội dung chính

1. Đại cương: trúng phong kinh lạc và trúng phong tạng phủ

Y học cổ truyền gọi là **bán thân bất toại.**, ma mịch, chứng nuy

Nguyên tắc cơ bản trong điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não là: cần tiến hành sớm, ngay sau khi tình trạng tổn thương ở não đã ổn định, **các chỉ số sinh tồn (mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở) của người bệnh đã trở lại bình thường**, ổn định, chỉ còn hội chứng liệt nửa người kèm theo nói ngọng hoặc không. Quá trình điều trị phục hồi phải phù hợp với tình hình sức khỏe của từng người bệnh, phục hồi từ các động tác đơn giản đến phức tạp. **Kết hợp nhiều phương pháp như:** châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, thủy châm, uống thuốc, tự luyện tập của người bệnh. Ngoài ra cần chú ý chế độ nuôi dưỡng, phòng chống loét và các nhiễm trùng thứ phát khác (viêm phổi, viêm đường tiết niệu).

2. Y học cổ truyền:

2.1 Can thận âm hư:

Thường gặp ở những bệnh **nhân tăng huyết áp, xơ vữa mạch, người trẻ tuổi.**

2.1.1. Triệu chứng: Liệt nửa người, liệt nửa mặt dưới cùng bên, tay **chân bên liệt tê dại, hay hoa mắt chóng mặt**, mạch huyền tế sắc.

2.1.2. Pháp điều trị: Tư âm tiềm dương, trấn hỏa tức phong.

2.1.3. Bài thuốc cổ phương: Bài 1: Đại định phong châu:

Mạch môn	10g	Ngũ vị tử	08g	Sinh mẫu lệ	10g
Sinh bạch thực	10g	Sinh miết giáp	10g	A giao	08g
Sinh quy bản	10g	Trích cam thảo	08g	Thục địa	12g
Kê tử hoàng 1 lòng đỏ trứng gà				Sa nhân	10g

Bài 2: Chân châu mẫu hoàn

(Chân châu mẫu, sinh địa hoàng, Đảng sâm, Dương quy, Bá tử nhân, Toan táo nhân, Phục thần, Long sĩ, Trầm hương).

Bài 3: **Lục vị gia giảm.**

Bài 4: Kê đơn theo đối pháp lập phương.

2.1.4. Châm cứu:

Châm bổ các huyệt Kiên ngưng, Khúc trì, Thủ tam lý, ngoại quan, Dương trì, Hợp cốc, Bát tà, **Hoàn khiêu, Dương lăng tuyền**, Huyền trung, Côn lân, **Giải khô**, Giáp tích C7 – D1, TL4 – TL5. Châm thêm Thái khô, Tam âm giao, Thái xung, Nội quan hai bên.

Miếng méo châm: Địa thương, Giáp xa, Thừa tương bên liệt.

Nói ngọng châm: Liêm tuyền, Thượng liêm tuyền, Giản sử, Thống lý.

2.1.5. Thủy châm:

Vitamin B1, B6, B12, Cerebrolysin vào một số huyệt.

2.1.6. Xoa bóp bấm huyệt: Bóp, day ấn huyệt, vận động bên tay chân liệt, hướng dẫn, động viên bệnh nhân luyện tập, vận động.

2.1.7. Chôn chỉ: vào một số huyết.

2.2. Do phong đàm: ĐÀM THẤP

Thường gặp ở những bệnh nhân tăng huyết áp, **béo bệu, Cholesterol máu cao.**

2.2.1. Triệu chứng: Liệt nửa người kèm theo liệt nửa mặt dưới cùng bên, tay chân tê dại, nặng nề, lưỡi cử động khó, có nói ngọng hoặc không, rêu lưỡi trắng **dày, nhớt**, mạch phù hoạt hoặc huyền hoạt.

2.2.2. Pháp điều trị: Trừ đàm thông lạc, thanh can giáng hỏa.

2.2.3. Bài thuốc cổ phương:

Bài 1: Đạo đàm thang gia vị:

Trần bì	8g	Đờm nam tinh	8g	Bán hạ chế	8g
Chỉ thực	8g	Toàn yết	4g	Cam thảo	6g
Bạch Cương Tằm	8g	Phục linh	8g	Bạch phụ tử	6g

Sắc uống ngày 01 thang.

Nếu đờm nhiều gia: Trúc lịch, nước gừng.

Nếu nói ngọng lâu không đỡ dùng bài: Tứ thọ giải ngũ thang (Linh dương giác, Quế chi, Khương hoạt, Phòng phong, Bạch phụ tử, Táo nhân, Thiên ma, Cam thảo).

Bài 2: Thiên ma câu đằng ẩm.

2.2.4. Châm cứu:

Châm các huyết nửa người bên liệt, các huyết chữa miệng méo, chữa nói ngọng giống như thể can thận âm hư. Châm thêm: Túc tam lý, Phong long hai bên để trừ đàm.

2.2.5. Thủy châm, xoa bóp bấm huyết, chôn chỉ: Thuốc và các động tác giống như thể can thận âm hư.

2.3. Khí trệ huyết ứ: **khí suy huyết ứ**

Thường gặp ở những bệnh nhân liệt nửa người do nhồi máu não (do tắc mạch, do lấp mạch), những bệnh nhân này có tiền sử bệnh van tim, xơ vữa mạch.

2.3.1. Triệu chứng:

Liệt nửa người, **liệt mặt cùng bên**, có nói ngọng hoặc không, song trước khi xảy ra hôn mê thường có dấu hiệu báo động như rối loạn cảm giác, nói khó, triệu chứng liệt khởi đầu từ từ, giai đoạn toàn phát có thể hôn mê vừa và nhẹ, hoặc không hôn mê.

2.3.2. Pháp điều trị: Ích khí hoạt huyết, khứ phong hóa đàm.

2.3.3. Bài thuốc cổ phương: **Bổ dương hoàn ngũ thang.**

Quy vĩ	12g	Địa long	12g	Xuyên khung	10g
Xích thực	12g	Hoàng kỳ	40g	Hồng hoa	8g
Đào nhân	8g	(Bắc Huỳnh Kỳ)			

Sắc uống ngày 01 thang.

Nếu liệt lâu ngày, đã dùng Đào nhân, Hồng hoa, Quy vĩ để hoạt huyết mà không đỡ thì thay bằng Thủy diệt, Mạnh trùng nướng cháy để phá ứ thông kinh lạc.

2.3.4. Châm cứu:

Chọn các huyết chữa liệt nửa người, nói ngọng, miệng méo giống như can thận âm hư. Châm thêm: Huyết hải, Thái uyên hai bên để hoạt huyết tiêu ứ.

2.3.5. Thủy châm, xoa bóp bấm huyết, chôn chỉ: thuốc và các động tác xoa bóp giống như thể can thận âm hư.

2.4. Một số điểm cần lưu ý khi điều trị bệnh nhân liệt nửa người:

Nên dùng điện châm, mỗi lần châm 20-25 phút, dùng xung chậm, cường độ mạnh (ở ngưỡng bệnh nhân có thể chịu đựng được), châm thường xuyên, kết hợp

châm với xoa bóp vận động cho bệnh nhân. Hướng dẫn, động viên người bệnh tích cực kiên trì luyện tập từ động tác đơn giản đến phức tạp.

Thời gian phục hồi các di chứng thường đạt kết quả tối đa trong **năm đầu, sau một năm khả năng phục hồi các di chứng hạn chế và rất chậm.**

Dù bệnh nặng hay nhẹ, không bao giờ phục hồi lại hoàn toàn như bình thường, ít nhiều vẫn để lại di chứng như: giảm cơ lực, tư thế đi không đồng bộ, suy giảm trí tuệ...

Cần xây dựng chế độ ăn giàu đạm, sinh tố, tránh dùng các chất kích thích như: nước chè, cà phê, rượu, bia, thuốc lá, phòng chống lạnh đột ngột, tránh các stress tâm lý để phòng bệnh tái phát.

Có thể uống: Hoa đà tái tạo hoàn hoặc **An cung ngưu hoàng hoàn.**

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân gây liệt nửa người theo YHCT là:
A. Do ngoại phong
B. Do nội phong
C. Do thấp tà
D. Do nhiệt độc
2. Triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh liệt nửa người do TBMMN là
A. Kèm theo liệt TK VII trung ương
B. Kèm theo liệt TK VII ngoại biên
C. Liệt nửa người đơn thuần
D. Kèm theo liệt dây TK IX.
3. Thời điểm thích hợp nhất để tiến hành điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN là:
A. Đang còn hôn mê
B. Đã tỉnh xong huyết áp còn dao động
C. Khi nào bệnh nhân tự đi lại được
D. Khi các chỉ số sinh tồn trở lại bình thường, ổn định.
4. Công thức huyết thường dùng để châm cho bệnh nhân liệt nửa người do TBMMN là:
A. Các huyết ở mặt trong tay và chân bên liệt
B. Các huyết ở mặt sau ngoài tay và chân bên liệt
C. Các huyết ở gốc chi bên liệt
D. Các huyết ở ngọn chi bên liệt.

BỆNH GÚT(Goutte)

MỤC TIÊU

1. Trình bày được các nguyên nhân, các thể bệnh gút theo YHHĐ.
2. Nêu được các thể bệnh, phương pháp chữa bệnh gút ở YHCT.

Nội dung chính

1. Đại cương:

1.1. Y học hiện đại:

Trong phân loại bệnh khớp, Y học hiện đại xếp bệnh gút trong nhóm bệnh khớp do rối loạn chuyển hóa. Bệnh đã được biết từ thời Hipocrat, nhưng đến cuối thế kỷ 19 mới xác định được vai trò gây bệnh là **acid uric**. Bệnh thường gặp ở các nước Châu Âu, chủ yếu là nam giới (95%), tuổi trung niên (30 -50), một số trường hợp có tính chất gia đình, ở Việt Nam trong một nghiên cứu 59 bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai và Quân y viện 108 cho thấy nam 30% và bệnh gút chiếm 1,5% các bệnh về khớp. Theo Y học hiện đại có **3 nguyên nhân** gây bệnh sau đây:

- **Tăng acid uric bẩm sinh**: do thiếu men H.G.P.T nên lượng acid tăng cao ngay từ nhỏ, bệnh có các biểu hiện toàn thân, thần kinh, thận và khớp, bệnh rất hiếm và rất nặng (bệnh lesch-Nyhan).

- Bệnh gút nguyên phát: gắn liền với yếu tố di truyền và cơ địa, quá trình tổng hợp **Purin** nội sinh tăng nhiều gây tăng acid uric, đây là nguyên nhân chủ yếu gây bệnh gút.

- Bệnh gút thứ phát: Do ăn nhiều gan, lòng, thịt, cá, nấm, tôm, cua, uống nhiều rượu. Do tăng cường thoái giáng Purin nội sinh. Do giảm thải acid uric qua thận.

Trong bệnh gút các tinh thể **uric acid** lắng đọng ở màng hoạt dịch gây sưng đau các khớp, ngoài ra uric có thể lắng đọng ở một số cơ quan ngoài khớp như gân, túi thanh dịch, ngoài da, móng tay móng chân, màng ngoài tim, cơ tim, van tim. Bệnh gút tiến triển từ 10 – 20 năm, trong quá trình diễn biến mạn tính xen kẽ có những đợt cấp làm bệnh nặng thêm. Bệnh nhân tử vong do các biến chứng thận, nhiễm khuẩn phụ, suy mòn.

Y học hiện đại chia gút thành hai thể: gút cấp tính và gút mạn tính.

- Gút cấp tính: Biểu hiện bằng những đợt viêm cấp và đau dữ dội của khớp bàn ngón chân cái, nên còn gọi là bệnh “gút do viêm”

- Gút mạn tính: Biểu hiện bằng dấu hiệu nổi các u cục (**hạt tôphi**) và viêm đa khớp mạn tính, do đó còn được gọi là “gút do lắng đọng”.

1.2. Y học cổ truyền:

Y học cổ truyền gọi là **thống phong**, nguyên nhân do ngoại tà xâm phạm vào cơ thể làm bế tắc kinh lạc, khí huyết ứ trệ tại các khớp gây sưng, đau, có duỗi vận động khó. Lúc đầu bệnh còn ở bì phu kinh lạc, lâu ngày tà khí vào gân xương, tạng phủ. Khí huyết, tân dịch ứ trệ lâu ngày hóa đàm, đàm uất kết thành u cục quanh khớp, dưới da. Bệnh tiến triển nhiều năm, đôi khi xuất hiện đợt cấp làm tổn thương can thận, làm biến dạng các khớp. Y học cổ truyền cho **rằng thống phong có thể quy thuộc phạm trù chứng tý** và chia là hai thể bệnh sau:

1.2.1. Thể phong thấp nhiệt (đợt cấp):

1.2.1.1. Triệu chứng: Đợt ngộ khớp bàn ngón chân cái sưng, nóng đỏ, đau, không dám sờ đụng vào, đau đầu, sốt, khát nước, miệng khô, sợ lạnh, tiểu tiện vàng, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng, mạch phù sác.

1.2.1.2. Pháp điều trị: Khu phong, thanh nhiệt trừ thấp hoạt huyết, chỉ thống.

1.2.1.3. Bài thuốc cổ phương:

Bài 1: Gia vị tam diệu thang:

Thương truật	15g	Hoạt thạch	15g	Hoàng bá	12g
Tri mẫu	9g	Ý dĩ nhân	30g	Kê huyết đằng	30g
Ngưu tất	12g	Đương quy	15g	Mộc qua	12g
Xích thược	15g	Thanh đại	6g	Tỳ giải	12g

Sắc uống ngày 01 thang.

Bài 2: Bạch hồ gia quế chi thang gia giảm:

Thạch cao sống	40g	Kim ngân cuộn	20g	Tri mẫu	12g
(Sắc trước)					
Phòng kỷ	10g	Quế chi	6g	Mộc thông	10g
Bạch thược	12g	Hải đồng bì	10g	Xích thược	12g
		(Vỏ cây vông nem)			

Cam thảo 8g

Sắc uống ngày 01 thang.

- Nếu khớp sưng đau nhiều: Tăng kim ngân cuộn lên 50g và gia Thổ phục linh 16g, Ý dĩ nhân 16g để tăng khả năng trừ thấp và gia Toàn đương quy, Đan sâm, Trạch lan, Đào nhân, Hồng hoa, Tầm sa để hoạt huyết hóa ứ chỉ thống.

- Nếu có biểu chứng kèm theo gia thêm Độc hoạt, Tế tân để giải tán hàn chỉ thống.

1.2.1.4. Châm cứu:

Châm tả: Thận du, Khí hải du, Bàng quang du, Quan nguyên, Tam âm giao và các A thị huyết tại các khớp đau và vùng lân cận.

1.2.2. Thễ đàm thấp uất trệ (mạn tính)

Gút (thống phong) mạn tính có thể tiếp theo gút cấp tính, nhưng phần lớn là bắt đầu từ từ tăng dần không qua các đợt cấp.

1.2.2.1. Triệu chứng:

Nhiều khớp sưng to, đau kéo dài, co duỗi khó, tại khớp không nóng đỏ nhưng đau nhiều, biến dạng kèm theo da tím sạm đen, chườm nóng dễ chịu, chất lưỡi nhợt, rêu trắng, xuất hiện nốt u cục quanh khớp, dưới da vành tai sờ mềm, không đau, mạch trầm huyền hoặc khẩn là biểu hiện của hàn thấp ứ trệ.

1.2.2.2. Pháp điều trị:

Khu phong tán hàn, thông lạc, trừ thấp, chỉ thống.

1.2.2.3. Bài thuốc:

Bài thuốc nghiệm phương:

Chế ô đầu(phụ tử chế)	4g	Tế tân	4g	Hai vị này sắc trước	
Toàn đương quy	12g	Tỳ giải	12g	Ý dĩ nhân	20g
Xích thược	12g	Uy linh liên	10g	Mộc thông	10g
Thổ phục linh	16g	Quế chi	6g		

Sắc uống ngày 01 thang.

Nếu nhiều khớp sưng đau, cứng khớp, rêu lưỡi trắng dày bản, mạch hoạt là biểu hiện đàm trọc ứ trệ. Vẫn dùng bài thuốc trên gia: **Trích cương tàm, Xuyên sơn giáp, Tạo giác thích, Hy thiêm thảo, Hải đồng bì** để hoạt lạc, trừ đàm.

Nếu các khớp đau như dao đâm, dùi chọc,, mạch sấp, lưỡi tím bầm là biểu hiện của huyết ứ, gia thêm: **Ngô công, Toàn yết sao, Diên hồ sách** để hoạt huyết chỉ thống.

Nếu xuất hiện đau mỏi lưng gối, chân tay lạnh, sợ lạnh, chất lưỡi bệu, mạch trầm hoãn vô lực, liệt dương là biểu hiện của thận dương hư dùng bài thuốc trên gia: Cốt toái bổ, Nhục thung dung để bổ thận kiện cốt. Nếu kèm theo dấu hiệu khí huyết gia thêm: Hoàng kỳ, Bạch truật, Nhân sâm, Đương quy.

1.2.2.4. Châm cứu:

Châm bổ các huyết như thể phong thấp nhiệt.

1.3. Dự phòng bệnh tái phát:

1.3.1. Chế độ ăn uống, sinh hoạt:

- Kiêng uống rượu và các chất kích thích: ớt, cà phê, thuốc lá...
- Hạn chế các thức ăn có chứa nhiều purin: phủ tạng động vật (lòng, gan, tim, tiết) thịt, cá, cua, nấm, rau dền, đậu Hà lan, đậu hạt các loại. Có thể ăn trứng, sữa, uống bia, hoa quả, thịt chỉ nên ăn dưới 100g/ngày.

Uống nhiều nước (tối thiểu 2 lít/ngày), nên uống các loại nước khoáng có nhiều Bicarbonat, nếu không thì uống dung dịch Bicarbonat Na 3 %.

- Tránh làm việc quá sức, tránh lạnh, không nên ăn uống quá mức.
- Không nên dùng thuốc lợi tiểu Cholorothiazid, Sterroid.

1.3.2. Phẫu thuật: Khi các u cục (tophi) quá to cản trở vận động (ở ngón chân cái không đi giày được, ở khuỷu tay khó mặc áo) cần phẫu thuật cắt bỏ.

1.3.3 Nếu có tổn thương thận: cần chú ý tình trạng nhiễm khuẩn (viêm thận kẽ). Tình trạng suy thận tiềm tàng, sỏi thận, tăng huyết áp..., để xử lý kịp thời.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân gây bệnh thứ phát là:
 - A. Do ăn nhiều phủ tạng, thịt, cá và uống nhiều rượu.
 - B. Do tăng cường thoái giáng purin nội sinh.
 - C. Do giảm thải acid Uric qua thận.
 - D. Do cả 3 yếu tố trên**
2. Pháp điều trị đợt gút cấp của YHCT là:
 - A. Khu phong, tán hàn, hành khí hoạt huyết chỉ thống.
 - B. Khu phong, thanh nhiệt lương huyết, hoạt huyết, chỉ thống
 - C. Khu phong, thanh nhiệt giải thử, hoạt huyết chỉ thống
 - D. Khu phong, thanh nhiệt trừ thấp, hoạt huyết chỉ thống.**
3. Phương pháp châm cứu thường dùng giai đoạn bệnh gút mạn tính có biểu hiện thần dương hư là:
 - A. Châm tả
 - B. Châm bình bổ bình tả
 - C. Ôn điện châm
 - D. Châm bổ.**
4. Phương pháp dự phòng bệnh gút tái phát là:
 - A. Kiêng ăn uống các chất kích thích.
 - B. Hạn chế ăn các thức ăn chứa nhiều Purin
 - C. Tránh làm việc quá sức, không dùng thuốc chứa Steroit
 - D. Cả 3 điều kiện trên.**

CẢM CÚM

MỤC TIÊU:

1. Trình bày được các triệu chứng lâm sàng và phương pháp điều trị các thể cảm cúm theo YHCT.
2. Trình bày được các phương pháp dự phòng cảm cúm.

Nội dung chính

1. Bệnh danh:

Có hai loại :

- Cảm mạo **phong hàn**: Cảm mạo (còn gọi là “thương phong”)
- Cảm mạo **phong nhiệt**: Cúm (còn có tên gọi là “thời hành cảm mạo”)

2. Nguyên nhân và cơ chế sinh:

Nguyên nhân cảm mạo chủ yếu là do cảm thụ phong tà dẫn đến, điều kiện thuận lợi cho phát bệnh thường là do gặp khí hậu thay đổi đột ngột, nóng lạnh thất thường, hay do người bệnh dầm mưa, dãi nắng, lao động mệt mỏi..., **làm cho vệ khí bất cố** nên phong tà nhân chính khí của cơ thể giảm sút mà xâm nhập gây bệnh.

Phong tà xâm nhập vào **đường hô hấp**, mà tạng đầu tiên chịu ảnh hưởng là phế. Phế hợp với bì mao, khai khiếu ở mũi, phía trên thông với hầu họng. Phong tà phạm phế khiến cho phế khí mất tuyên thông, cho nên xuất hiện một loạt các triệu chứng của phế. Phế khí không thể hiện tuyên đạt được có thể thấy xuất hiện những triệu chứng của biểu: sợ lạnh, phát sốt... Nếu sau khi cảm thụ thời tà bệnh tình chuyển biến nặng mà lại kết hợp **với truyền nhiễm tức là “thời hành cảm mạo”**. Nếu người bệnh vốn thể chất khỏe thì tà khí chỉ xâm phạm và phế vệ, triệu chứng lâm sàng chủ yếu là biểu chứng. Nếu thể chất vốn đã yếu hay ở người già, trẻ em sức đề kháng cơ thể kém thì ngoại trừ **biểu nhập lý** thì bệnh tình trên lâm sàng sẽ nặng hoặc có biến chứng.

Khởi đầu của cảm mạo thường đa số thấy: ngạt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi, tiếng nói nặng hoặc đau đầu sợ lạnh, tiếp tục sẽ dẫn đến phát sốt, ho, ngứa họng, đau họng... tiến triển nặng nữa thì người bệnh sợ lạnh (thậm chí rét run), sốt cao, đau đầu, toàn thân đau mỏi, phát ban... thuộc về “thời hành cảm mạo”.

3. Các thể lâm sàng:

3.1. Cảm mạo phong hàn:

3.1.1 Triệu chứng: Mũi ngạt, nói khan, hắt hơi, chảy nước mũi trong hoặc ngứa họng, ho, đờm nhiều trắng loãng thậm chí đau đầu, đau mình mẩy, sợ gió, sợ lạnh, phát sốt, **không ra mồ hôi**, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch phù.

- Chuẩn đoán bát cương: Biểu thực hàn
- Chuẩn đoán nguyên nhân: Phong hàn

3.1.2 Pháp điều trị: Phát tán phong hàn (Tân ôn giải biểu).

3.1.3 Bài thuốc:

+ Thuốc xông: Nấu nồi xông với ba loại lá:

- Lá có tác dụng kháng sinh: lá hành, lá tỏi
- Lá có tác dụng hạ sốt: lá tre,.
- Lá có tinh dầu, có tác dụng sát trùng đường hô hấp: là chanh, lá bưởi,

tía tô, lá kinh giới, lá bạc hà, lá sả, lá hương nhu...

Mỗi thứ một nắm, tổng cộng khoảng 200-300g, rửa sạch lá, cho vào một nồi khoảng 2-3 lít nước đun sôi. Đặc biệt những lá có tinh dầu cho vào sau khi nước đã sôi, đây kín vung đun sôi lại bắc ra. Khi xông chum chắn kín cả người bệnh và nồi xông, mở nồi nước xông từ từ cho hơi nóng mùi tinh dầu bốc lên bệnh nhân. Xông từ 10-20 phút. Xông xong, lau sạch mồ hôi, thay quần áo tránh gió.

+ Bát cháo giải cảm:

Gạo tẻ 30g

Lá tía tô thái nhỏ 8g

Muối 1g

Gừng sống 3 lát

Hành sông giã nhỏ 3 củ

Gạo nấu thật nhừ rồi cho hành, gừng, lá tía tô và muối vào. Nếu có trứng gà, đánh vào cháo 1 quả, khuấy đều, đem ra ăn khi còn nóng. Ăn xong đắp chăn độ 30 phút cho ra mồ hôi, sau đó lau khô và thay quần áo.

+ Phương pháp đánh gió: Đánh gió là một phương pháp chữa bệnh của dân gian để điều trị bệnh cảm mạo. Phương pháp này đơn giản, an toàn, phục vụ tại nhà và tuyến y tế cơ sở.

Thuốc để đánh gió bao gồm: gừng tươi 8g, ngải cứu 40g, hành củ 5 củ, rượu hay giấm cừa đủ cho thuốc sền sệt.

Cách làm: các vị giã nhỏ, sao nóng, chế rượu vào, trộn đều rồi bọc trong miếng vào sạch, đánh gió trà sát lên cả người, nhiều nhất là hai bên thái dương, sát dọc hai bên thân thịt ở hai bên cột sống, làm cho người ấm lên. Có nơi dùng quả trứng gà luộc, bóc vỏ cắm đồng tiền bạc vào giữa lấy vải bọc sạch bên ngoài quả trứng còn nóng, sát lên lưng người bệnh từ trên xuống dưới, làm liên tục 10-15 phút. Phương pháp này hay được áp dụng ở trẻ em.

+ Thuốc uống:

Kinh giới	12g	Tía tô	12g	Sinh khương	3 lát
Bạch chỉ	12g	Trần bì	6g	Quế chỉ	6g
Bạc hà	10g				

Sắc uống ngày 01 thang, uống 1-3 thang mỗi đợt.

3.1.4 Châm cứu: châm tả các huyệt: Phong trì, Phong môn, Hợp cốc.

Nếu bệnh nhân hắt hơi sổ mũi châm: Nghinh hương.

Nếu nhức đầu châm: Bách hội, Thái dương

Nếu sốt thêm: Đại chùy, Khúc trì, Ngoại quan

Có thể dùng phương pháp cứu.

3.2 Cảm mạo phong nhiệt

3.2.1 Triệu chứng: Phát sốt, **hơi sợ gió, sợ nóng, ra mồ hôi**, đau đầu, ngạt mũi hoặc chảy nước mũi nặng, hầu họng sưng đỏ đau, **ho ra đờm đặc, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch phù sắc**.

- Chẩn đoán bát cương: Biểu thực nhiệt

- Chẩn đoán nguyên nhân: phong nhiệt

3.2.2 Pháp điều trị: Phát tán phong nhiệt (tân lương giải biểu)

Phương pháp đánh gió

3.2.3 Bài thuốc:

Bạc hà	10g	Ké đầu ngựa	12g	Cát căn	10g
Cam thảo	10g	Địa liên	10g	Lá dâu	10g
đất					
Lá tre	10g	Bạch chỉ	10g	Cúc tần	10g
Lá cối xay	10g				

Sắc ngày uống 01 thang, uống 3 thang mỗi đợt.

3.2.4 Châm cứu: châm tả các huyệt: Kiên tỉnh, Phong trì, Phong môn.

Nếu bệnh nhân nhức đầu thêm: Bách hội, Thái dương

Nếu sốt cao thêm: Đại chùy, Khúc trì, Hợp cốc hoặc thêm Thập tuyên nặn một tí máu

Nếu chảy máu cam châm Nội đình, Nghinh hương
Nếu ho nhiều thêm: Trung phủ, Thái uyên, Xích trạch
Sau khi khỏi, còn mệt mỗi châm bổ: Túc tam lý, Tam âm giao.

3. Phòng bệnh:

Cảm cúm là một bệnh phổ biến, **cúm thành dịch**, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Các phương pháp dự phòng cảm cúm theo Y học cổ truyền rẻ tiền, dễ kiếm, sẵn có ở địa phương khiến cộng đồng dễ chấp nhận gồm các biện pháp sau:

- Trong mùa dịch: Nâng cao sức đề kháng, giữ cơ thể không bị lạnh khi thời tiết thay đổi.

- Hạn chế tiếp xúc, hạn chế tập trung đông người khi có dịch.

- Thời gian có cúm hướng dẫn mọi người dùng:

+ Tỏi: Mỗi bữa ăn kèm vài tép tỏi sống. Người lớn ăn 3 tép, trẻ em ăn 1 tép.

+ Rượu tỏi: Giã nát 200g tỏi ngâm trong 1 lít rượu trong 2 ngày, lọc lấy rượu, mỗi tuần uống 3 ngày, mỗi ngày từ 30-50 giọt.

+ Khi có dịch cúm dùng bông tẩm dầu tỏi bôi và hít vào lỗ mũi vào buổi sáng, chiều (hoặc giờ mũi). Công thức tỏi giã nát 20g + dầu vừng hoặc dầu lạc 200ml.

+ Châm hoặc day huyệt Tam túc lý hàng ngày.

Khi đã mắc bệnh: áp dụng các phương pháp điều trị tiện lợi, đơn giản như đánh gió, nấu nồi nước xông, châm cứu hoặc dùng các vị thuốc sẵn có ở địa phương.

Đối với thể nặng, có biến chứng phải phát hiện và điều trị kịp thời.

Tóm lại: Cảm mạo là bệnh thường gặp, đặc biệt ở nơi mật độ dân cư đông vì bệnh dễ lây truyền, do đó công tác dự phòng đóng vai trò quan trọng nên cần phải tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh, rèn luyện thân thể, tăng cường thể lực. Trong thời gian bệnh lưu hành phải tiêm phòng dịch, vệ sinh môi trường.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân gây cảm cúm theo YHCT là:

- A. Do phong tà xâm phạm
- B. Do ăn uống không điều độ
- C. Do mất ngủ kéo dài
- D. Do căng thẳng thần kinh kéo dài

2. Triệu chứng điển hình của cảm mạo phong hàn là:

- A. Ngạt mũi, chảy nước mũi trong, hắt hơi, sợ lạnh
- B. Sốt cao, sợ nóng
- C. Ra mồ hôi nhiều, khát nước
- D. Ỉa chảy, đau bụng, buồn nôn.

3. Triệu chứng điển hình của cảm mạo phong nhiệt là:

- A. Không sốt, sợ lạnh - không ra mồ hôi
- B. Phát sốt, sợ nóng, ra nhiều mồ hôi
- C. Đại tiện táo - thích uống nước ấm
- D. Đau đầu dữ dội, buồn nôn

4. Phòng bệnh cảm cúm:

- A. Ăn nhiều hoa quả tươi
- B. Đi ngủ sớm, sáng dậy muộn
- C. Nâng cao sức đề kháng, hạn chế tiếp xúc nơi đông người
- D. Ăn nhiều thịt, cá, tôm, cua

HEN PHẾ QUẢN

Mục tiêu:

1. Trình bày được nguyên nhân gây bệnh hen phế quản theo Y học hiện đại và YHCT.
2. Trình bày được phương pháp điều trị hen phế quản bằng YHCT.

Nội dung chính

1. Y học hiện đại:

1.1 Đại cương:

Hen là một bệnh đường hô hấp có đặc điểm tăng sự đáp ứng của cuống phế quản với nhiều loại kích thích. Về lâm sàng đó là những đợt **khó thở kịch phát, ho và cò cữ**. Đây là một bệnh có tính chu kỳ, bùng phát cấp tính, xen kẽ với những giai đoạn không có triệu chứng. Những đợt kéo dài, bệnh có khi nhẹ, có khi nặng lên, có lúc gây tắc nghẽn đường hô hấp kéo dài hàng ngày đến hàng tuần được gọi là cơn ác tính.

Về tần suất: ở Mỹ có từ 4-5% dân số bị hen, các nước khác cũng tương tự. Thường gặp ở những người trẻ tuổi, khoảng 50% số người bị hen ở lứa tuổi <10 tuổi, 1/3 số còn lại ở độ tuổi <40, ở trẻ nhỏ tỷ lệ giữa nam/nữ là 2/1, nhưng đến tuổi ≥30 tỷ lệ nam nữ mắc bệnh như nhau.

1.2 Nguyên nhân gây hen:

1.2.1 Dị nguyên:

Có nhiều loại, nó lưu hành trong không khí, nhưng những người bị hen phải tiếp xúc một thời gian dài và liều lượng phải đủ mới mắc bệnh.

1.2.2 Ô nhiễm môi trường sống:

Liên quan đến điều kiện khí hậu và nồng độ các chất gây ô nhiễm.

1.2.3 Yếu tố nghề nghiệp:

Xuất hiện sau một thời gian tiếp xúc với nhiều phức hợp trong quy trình công nghiệp, hiện tượng co thắt phế quản có thể gặp khi tiếp xúc các muối kim loại (bạc kim, crom, kền) hoặc bụi gỗ, bông, đất hoặc một số chất dẻo tổng hợp.

1.2.4 Kích thích được học:

Thường gây cơn hen cấp tính ngay khi tiếp xúc với Aspirin, Paracetamol, Salicylat, kháng sinh các loại.

1.2.5 Nhiễm khuẩn:

Các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp là những kích thích phổ biến nhất gây cơn hen cấp tính bộc phát.

1.2.6. Gắng sức:

Là một yếu tố phổ biến thúc đẩy các cơn hen kịch phát.

1.2.7. Sang chấn tình cảm:

Các yếu tố tâm lý có thể tương tác với địa tạng hen, có thể làm tăng hoặc giảm nhẹ quá trình bệnh.

1.3 Chẩn đoán hen:

Việc chuẩn đoán hen dựa vào sự khẳng định **hiện tượng tắc nghẽn đường dẫn khí có khả năng hồi phục**. Tính hồi phục được xác định bằng việc tăng từ 15% trở lên thể tích thở ra gắng sức trong giây đầu sau khi dùng 2 lần thuốc xịt dẫn phế quản loại kích thích β – Adrenergic.

1.4 Phương pháp điều trị:

- Loại bỏ các yếu tố gây bệnh ra khỏi môi trường sống của bệnh nhân hen phế quản do dị ứng là cách điều trị thành công nhất.

- Giải mẫn cảm hoặc miễn dịch liệu pháp kết hợp với loại bỏ các dị nguyên nghi ngờ cũng là một biện pháp được nhiều người tán thưởng.

- Dùng thuốc:

Các thuốc tác dụng β – giao cảm, các thuốc có Corticoid, các thuốc ổn định màng tế bào, các thuốc kháng Cholin, các thuốc ức chế tổng hợp các chất hóa học trung gian.

1.5 Tiên lượng:

Tỷ lệ tử vong do hen hiếm, diễn biến bệnh hen tốt từ 50-80% các trường hợp nhất là các bệnh nhân nhẹ. Không giống viêm phế quản mạn, hen phế quản không tiến triển nặng thêm. Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ lây bệnh là 20%, đặc biệt những người khởi bệnh lúc tuổi trưởng thành tỷ lệ lây bệnh là 40%, con hen thừa hơn và nhẹ hơn lúc về tuổi già.

2. Y học cổ truyền:

2.1 Đại cương:

Hen phế quản YHCT gọi là chứng **háo suyễn**, đàm ảm, một bệnh hay gặp ở những người hay bị dị ứng, nguyên nhân gây bệnh do cảm phải ngoại tà, do ăn uống các thức ăn dễ ăn dị ứng, do tình chí thất thường, do làm việc quá sức. Về tạng phủ có liên quan đến tạng Phế, Thận, Tỳ. Bệnh xảy ra mạn tính hay tái phát. Lúc lên cơn là **thực chứng**, ngoài cơn là **hư chứng**. Vì vậy khi chữa bệnh phải phân ta tiêu bản, hoãn cấp mà xử lý (Cấp tắc trị tiêu, hoãn tắc trị bản). Cụ thể khi lên cơn hen, dùng châm cứu, XBBH, thuốc YHCT, thuốc YHHĐ để cắt cơn hen, khi hết cơn chữa vào gốc (bản) bệnh là Tỳ, Phế, Thận để phòng tái phát.

2.2. Cách chữa bệnh hen của YHCT:

2.2.1 Chữa hen phế quản khi đang có cơn hen:

2.2.1.1 Hen hàn:

2.2.1.1.1 Triệu chứng:

Người lạnh, sắc mặt trắng bạch, đờm loãng nhiều bọt, dễ khạc, không khát, thích uống nước nóng, đại tiện phân nát, chất lưỡi nhợt, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền tế.

2.2.1.1.2 Pháp điều trị: **Ôn phế tế hàn, trừ đàm, hạ suyễn** (trừ đàm lợi khiếu, hoạt đàm lợi khí).

2.2.1.1.3 Bài thuốc:

- + Bài 1: Xạ can ma hoàng thang gia giảm
- + Bài 2: Tô tử giáng khí thang
- + Bài 3: Tiểu thanh long thang gia giảm
- + Bài 4: Lãnh hóa hoàn thang

2.2.1.1.4 Châm cứu:

Châm tả các huyệt: Thiên đột, Chiên trung, Phong môn, Định suyễn, Tam âm giao, Phong long, Túc tam lý, cứu các huyệt Phế du, Cao hoàng, Thận du.

2.2.1.2 **Hen nhiệt:**

2.2.1.2.1 Triệu chứng: Người bứt rứt, sợ nóng, mặt môi đỏ, đờm vàng, dính, khát, thích uống nước lạnh, đại tiện táo, lưỡi đỏ, rêu lưỡi trắng dày, mạch hoạt sắc.

2.2.1.2.2 Pháp điều trị: Thanh nhiệt tuyên phế, hóa đàm, bình suyễn.

2.2.1.2.3 Bài thuốc:

Bài 1: Việt tỳ gia bán hạ thang gia giảm:

Ma hoàng	8g	Đại táo	12g	Hạnh nhân	10g
Thạch cao sống	20g	Bán hạ chế	8g	Tô tử	8g

Gừng tươi	4g	Xạ can	10g	Đình lịch tử	8g
-----------	----	--------	-----	--------------	----

Bài 2: Định suyễn thang gia giảm:

Ma hoàng	6g	Hoàng cầm	12g	Trúc lịch	20g
Hạnh nhân	12g	Tang bạch bì	20g	Bán hạ chế	8g
Cam thảo	4g				

- Nếu đờm nhiều thêm Xạ can 8g, Đình lịch tử 8-12g
- Nếu đờm vàng thêm Ngưu tinh thảo (rấp cá) 40g
- Nếu sốt cao thêm Thạch cao sống 20g.

Chú ý: cả thể hen hàn, hen nhiệt có thể kết hợp châm loa tai để cắt cơn hen.

2.2.1.2.4 Châm cứu:

Châm tả các huyệt: trung phủ, Thiên đột, Chiên trung, Định suyễn, Phế du, Xích trạch, Thái Uyên, Phong long, Hợp cốc.

2.2.2 Chữa hen phế quản khi hết cơn hen:

Mục đích để tránh tái phát cơn hen hoặc có tái phát thì cơn hen nhẹ hơn, chu kỳ tái phát chậm hơn. Giai đoạn này người ta chữa vào gốc (bản) bệnh cụ thể là Tỳ vì Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, nếu Tỳ hư đàm trọc nhiều, Phế hư gây khó thở, Thận hư không nạp được khí làm khí nghịch lên gây khó thở.

2.2.2.1 Tỳ hư:

2.2.2.1.1 Triệu chứng: Đờm nhiều, sắc mặt vàng, mệt mỏi, ăn kém, bụng đầy chướng, đại tiện lỏng, phù thũng, lưỡi bản, nhớt, mạch tế vô lực.

2.2.2.1.2 Pháp điều trị: Kiện tỳ ích khí hay ôn trung kiện tỳ.

2.2.2.1.3 Bài thuốc:

- + Bài 1: Lục quân tử thang (kiện tỳ ích khí)
- + Bài 2: Phụ quý lý trung thang (ôn trung kiện tỳ)

Đảng sâm	12g	Bạch truật	12g	Phụ tử chế	12g
Can khương	8g	Cam thảo	8g	Quế nhục	4g

2.2.2.1.4 Châm cứu: Cứu các huyệt: Tỳ, Vị, Phế du, Thận du, Túc tam lý.

2.2.2.2 Phế hư:

Gặp ở những bệnh nhân hen phế quản lâu ngày kèm theo giãn phế nang, giảm chức năng hô hấp, thời kỳ đầu của bệnh Tâm phế mạn.

2.2.2.2.1 Triệu chứng: Sợ lạnh, tự hãn, thở ngắn gấp, đờm nhiều loãng, tiếng nói nhỏ yếu, sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi, dễ bị cảm lạnh, hay chảy nước mũi, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch hoãn vô lực (biểu hiện phế khí hư). Nếu phế âm hư: ho thở gấp, đờm ít hoặc không, họng miệng khô, sốt về chiều, chất lưỡi đỏ, ít rêu lưỡi, mạch tế sắc.

2.2.2.2.2 Pháp điều trị: Bổ phế cố biểu, ích khí định suyễn

2.2.2.2.3 Bài thuốc:

- + Bài 1: Ngọc bình phong thang gia giảm:

Hoàng kỳ	12g	Tô tử	12g
Phòng phong	8g	Bạch truật	12g

- + Bài 2: Quế chi gia hoàng kỳ thang (nếu phế âm hư dùng bài **Sinh mạch tán gia giảm**)

Đảng sâm	16g	Ngũ vị tử	6g	Ngọc trúc	8g
Mạch môn	12g	Sa sâm	12g	Bối mẫu	12g

2.2.2.2.4 Châm cứu:

Châm bổ các huyệt: Phế du, Cao hoang, Chiên trung, Thận du, Tỳ du, Quan nguyên.

2.2.2.3 Thận hư:

Có thể gặp Thận hư hoặc Thận dương hư không nạp được khí gây khó thở.

2.2.2.3.1 Triệu chứng:

Nếu thận dương hư: Thở ngắn gấp, vận động khó thở tăng lên, hay hồi hộp, đờm nhiều bọt, **lưng gối mỗi đau**, sợ lạnh, sắc mặt trắng bệch, **nước tiểu trong số lượng nhiều**, lưỡi nhợt, rêu lưỡi trắng, mạch trầm tế vô lực.

Nếu thận âm hư: Thở ngắn gấp, lưng gối mỗi, hay hoa mắt, chóng mặt, tai ù, miệng họng khô, lòng bàn tay, bàn chân nóng, nước tiểu vàng, đại tiện táo, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi ít hay không có rêu, mạch tế sác.

2.2.2.3.2 Pháp điều trị: Ôn thận nạp khí (nếu thận dương hư) hoặc tư âm bổ thận (nếu thận âm hư).

2.2.2.3.3 Bài thuốc:

+ Thận dương hư: Bát vị quế phụ hoặc bài Hữu quy ẩm

Thục địa	16g	Hoài sơn	8g	Phụ tử chế	12g???
Sơn thù	8g	Phục linh	8g	Nhục quế	6g
Kỷ tử	12g	Cam thảo	6g		

Gia thêm Ngũ vị tử 8g, Mạch môn 8g

Cả hai bài trên đều có thể sắc uống hoặc làm viên hoàn mỗi ngày uống 20g chia 2 lần.

+ Thận âm hư: Dùng bài tả quy ẩm hoặc bài Hà sa đại táo hoàn.

2.2.2.3.4 Châm cứu:

+ Thận dương hư: Cứu các huyết Quan nguyên, Khí hải, Thận du, Mệnh môn, Phế du, Cao hoang.

+ Thận âm hư: Châm bổ các huyết trên thêm Huyết hải, Tam âm giao, Thái khê.

3. Phòng bệnh:

Tùy theo thể bệnh mà phòng tránh lạnh, ẩm, tránh ăn các loại thức ăn dễ gây dị ứng, phát hiện và điều trị các bệnh đường hô hấp, giữ gìn môi trường sạch sẽ, luyện tập thường xuyên để nâng cao sức khỏe có tác dụng phòng chống bệnh hen.

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân gây hen phế quản theo YHCT là:

- A. Do ăn nhiều thịt cá, tôm cua
- B. Do cảm phải ngoại tà, tình chí thất thường, làm việc quá sức**
- C. Do mất ngủ kéo dài
- D. Do hút thuốc lá nhiều

2 Triệu chứng điển hình của hen phế quản thể hen nhiệt là:

- A. Sợ lạnh, uống nước lạnh cơn hen càng tăng
- B. Sốt cao, đau đầu - ra mồ hôi nhiều**
- C. Đại tiện táo, tiểu tiện vàng
- D. Người bứt rứt, sợ nóng, mặt môi đỏ

3 Triệu chứng điển hình của hen phế quản thể phế hư là:

- A Sợ lạnh, tự hãn, thở ngắn gấp, nói nhỏ**
- B. Sợ nóng, đạo hãn, thở to, nói thô to
- C. Người khỏe mạnh, linh hoạt
- D. Ăn lâu tiêu, rêu lưỡi vàng dày, khô

4 Phòng bệnh hen phế quản là:

- A. Tránh lao động quá sức

- B. Chỉ nên ăn thịt gia súc nấu kỹ
- C. Tránh lạnh ẩm, không ăn thức ăn gây dị ứng, giữ môi trường sạch
- D. Nghỉ ngơi nhiều, không nên luyện tập thể dục thể thao

VIÊM ĐẠI TRÀNG MẠN TÍNH

Mục tiêu:

1. Trình bày được nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng mạn tính theo YHHD và YHCT.
2. Trình bày được phương pháp điều trị viêm đại tràng mạn tính bằng YHCT

Nội dung chính

1. Đại cương.

Viêm đại tràng mạn tính, còn gọi là viêm loét đại tràng (kết trường) không đặc hiệu.

Đặc điểm chủ yếu của bệnh là tiêu chảy mức độ nặng nhẹ khác nhau có thể kèm theo đau lưng hoặc mót rặn, đau bụng có thể là âm ỉ hoặc đau quặn từng cơn, thường ở vùng bên trái bụng dưới, phân thường có máu mũi cũng có khi chỉ có máu.

Những triệu chứng khác có thể là chán ăn, bụng đầy, buồn nôn hoặc nôn, người gầy, mệt mỏi có khi sốt nhẹ, thiếu máu. Có ít trường hợp trong quá trình bệnh lý có thể có cơn bệnh nặng lên đột ngột, tiêu chảy 10-30 lần, sốt cao nôn nhiều, mất nước, rối loạn điện giải hoặc thủng ruột, điều trị không kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân bệnh cho đến nay vẫn chưa rõ. Có thể có liên quan đến nhiễm vi khuẩn hoặc vi rút đường ruột, yếu tố tinh thần bị kích thích, nhạy cảm thức ăn hoặc phản ứng tự miễn của cơ thể.

Về chuẩn đoán, chủ yếu dựa vào triệu chứng lâm sàng và kết quả soi chụp đại tràng, trực tràng (niêm mạc xung huyết, loét, chất máu mũi, niêm mạc biến dạng).

2. Nguyên nhân.

Theo YHCT, viêm đại tràng thuộc phạm trù các chứng Tiết tả, Kiệt lý, Hưu tức lý

Nguyên nhân bệnh có thể do ngoại cảm lục dâm phong, hàn, thử, thấp, nhiệt gây tổn thương Tỳ Vị hoặc do ăn uống nhiều chất béo mỡ, chất sống lạnh hoặc cay nóng nhiều, uống nhiều rượu gây thấp nhiệt nội sinh ứ trệ ở đại tràng, hoặc do tình chí tổn thương, can khí uất hại đến tỳ (can tỳ bất hòa) đều làm cho chức năng vận hóa của tỳ bị rối loạn sinh thấp nhiệt uất kết, khí trệ, huyết ứ nên sinh đau bụng, đi tiêu phân có máu mũi, tiêu chảy. Nếu bệnh lâu ngày, tái phát nhiều lần, tỳ dương hư, ảnh hưởng đến thận dương hư, có các triệu chứng đau lưng, mỏi gối chân tay lạnh, tiêu chảy thường vào lúc sáng sớm, gọi là chứng **Ngũ Canh tiết Tả**.

3. Biện chứng:

Trên lâm sàng thường gặp các thể bệnh sau:

3.1 Thấp nhiệt:

3.1.1. Triệu chứng:

Thường gặp lúc bệnh mới bắt đầu hoặc lúc tái phát: Sốt, đau bụng, tiêu chảy hoặc mót rặn, phân có máu mũi, rêu dày nhớt, mạch hoạt sác.

3.1.2. Pháp điều trị: Thanh lợi thấp nhiệt

3.1.3. Bài thuốc: Dừng Cát Căn Cầm Liên thang (thương hàn luận): Cát căn, Hoàng cầm, Hoàng liên, Chích thảo

Hoặc Bạch Đầu Ông Thang gia giảm:

Bạch đầu ông	16g	Trần bì	12g	Hoàng liên	4g
Hoàng bá	12g	Mộc hương	4g	Mộc hương	4g
Sa tiền tử	20g	Cát căn	16g		

Nhiệt thịnh thêm Hoàng cầm, Kim ngân hoa, Thấp nhiều thêm Hậu phác, Thương truật.

3.2 Can tỳ bất hòa:

3.2.1. Triệu chứng:

Tiêu chảy thường xảy ra sau khi bị kích động tinh thần. đau bụng, đi tiêu xong hết đau kèm theo ngực bụng đau tức, chán ăn, có thể ợ chua, bụng sôi hoặc phân xanh, rêu lưỡi trắng mỏng, mạch huyền tế.

3.2.2 Pháp điều trị: Sơ can, hòa vị

3.2.3 Bài thuốc: Dùng Thông tả Yếu Phương gia giảm:

Phòng phong	12g	Bạch truật	12g	Bạch thược	12g
Sài hồ	12g	Ý dĩ	16g	Tiểu sơn tra	12g
Trần bì	8g				

Bụng dưới đau nhiều do khí trệ thêm Hương phụ (chế), Tiểu hồi hương, bụng đau quặn thêm Đan sâm, Ngũ linh chi để hoạt huyết, chỉ thống.

3.3. Tỳ hư:

3.3.1 Triệu chứng:

Thường đau bụng, xoa ấn thì dễ chịu, người mệt mỏi, chán ăn, tiêu chảy dễ tái phát, phân sống, lưỡi bệu, rêu lưỡi dày, mạch trầm, nhược.

3.3.2 Pháp điều trị: Bổ tỳ, tiêu thực

3.3.3. Bài thuốc: Dùng Sâm linh Bạch Truật tán gia giảm

Nhân sâm	8g	Bạch truật	12g	Mộc hương	4g
Hoài sơn	12g	Bạch linh	12g	Bạch biển đậu	12g
Liên nhục	12g	Cốc nha	12g	Sa nhân	8g

Tiêu chảy lâu ngày làm sa trực tràng (lòi dom): dùng Bổ trung ích khí thang (Tỳ Vị luận)

: Nhân sâm, Hoàng kỳ, Bạch truật, Cam thảo, Đương quy, Trần bì, Thăng ma, Sài hồ để bổ khí, thăng đề.

3.4 Thận hư:

3.4.1 Triệu chứng:

Tiêu chảy kéo dài lâu ngày, bệnh nhân sợ lạnh, sắc mặt tái nhợt, lưng đau, gối mỏi, tai ù hoặc thính lực giảm, tiêu chảy thường vào lúc sáng sớm (ngũ canh tả), lưỡi bệu, rêu trắng, mạch trầm tế, nhược.

3.4.2 Pháp điều trị: Ôn thận, sáp trường.

3.4.4 Bài thuốc: Dùng tứ thần hoàn gia vị

Chế phụ tử	12g	Nhục đậu khấu	12g	Bổ cốt chỉ	12g
(sắc trước)					
Xích trạch chi	12g	Ngô thù du	5g	Hậu phác	10g
Gừng lùi	6g				

Phối hợp:

Thuốc thụt.

Dùng đơn thuần hoặc kết hợp với thuốc uống. Có thể dùng các bài sau:

Bài 1: Hương liên hoàn: Mộc hương, Hoàng liên đều 10g, sắc với 300ml nước còn 100ml, dùng thụt vào đại tràng trước khi đi ngủ, làm liên tục 7-10 ngày (10 ngày là một liệu trình).

Bài 2: Bạch đầu ông: Bách hoa xà thiệt thảo, Hoàng liên, Xích thược, Bạch thược đều 15g. Sắc với 600ml nước còn 200ml, thụt lưu trước lúc đi ngủ 7-10 ngày (10 ngày là một liệu trình).

Bài 3: Minh phàn Hợp tễ (của Lưu Tư Mão): Minh phàn, Thương truật, Khổ sâm, Hòe hoa đều 15g, Đại hoàng 10g sắc với 300ml nước còn 100ml, dùng thụt lưu vào đại trường mỗi tối trước khi đi ngủ, 7-10 ngày.

Bài 4: Thổ khổ tang (của Lý chúc trợ): Thổ đại hoàng 30g, Khổ sâm 30g, Bạch cập, Địa du (than), Đỗ trọng (than) đều 10g, sắc với 600ml nước còn 100ml. Lúc thuốc còn nóng khoảng 37⁰ – 39⁰, dùng ống thụt hậu môn, đưa vào sâu 20cm, bơm thuốc vào từ từ, giữ thuốc trong 12 giờ. Một liệu trình 20 ngày, nghỉ 5 ngày lại tiếp tục.

+ Lưu Ký Nô Tiền (Khuong Hán Dân, bệnh viện nhân dân huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô, TQ) Lưu ký nô, Phá cố chỉ, Nữ trinh tử, Ngô thù du, Xa tiền tử, Trạch tả, sắc nước uống.

Thấp nhiệt đêm: Kha tử, Hoàng liên, Cát cánh, Hư hàn thêm Đảng sâm, Nhục đậu khấu.

+ Bồ tỳ thông dụng phương (Trương tường đức): Hoàng kỳ, Đảng sâm, Bạch truật, Bạch linh, Sơn dược, Bạch thược, Sơn tra, Mộc hương, Sa nhân, Cam thảo sắc uống.

Gia giảm: Tỳ hư thấp nhiệt thêm Bạch đầu ông, Hoàng liên, sinh Hoa hòe, Tỳ thận hư thêm Phá cố chỉ, Ngũ vị tử, Nhục đậu khấu, Ngô thù du, Tỳ hư Can uất thêm Bình lang, Mộc qua, Phòng phong, Hàn nạnh thêm Phụ tử, Can tương, đi tiêu phân có máu thêm Đại du (sinh), Đại hoàng (sinh), Tiêu chảy lâu ngày không khỏi thêm Anh túc xác, Xích trạch chi, Táo bón thêm La bạc tử, Hỏa ma nhân. Huyết hư thêm Đương quy, A giao. Mất ngủ thêm sao Táo nhân, sinh Mậu lệ, Khớp đau thêm Quế chi, Uy linh tiên. Gan to thêm Sai hồ, Đan sâm, Miết giáp.

+ Cúc Du Phương (Lưu Đình Thanh, bệnh viện 183 giải phóng quân, TQ): Cúc hoa, Địa du, Thập đại công lao đều 15g, Khổ sâm, Hoàng cầm đều 9g. Mỗi tối sắc nước thụt lưu đại tràng, 1 liệu trình 15 lần.

+ Hoàng Ngân ý tra thang (bệnh viện Trung Y huyện Hoàng Cương, Hồ Bắc):

Hoàng kỳ	30g	Ngân hoa thán	10g (hòa uống)	Đảng sâm	10g
Ý dĩ	15g	Sơn tra	15g	Bạch thược	10g
Sơn dược	10g	Bạch linh	10g	Cam thảo	6g
Mộc hương	6g	Cát cánh	6g		
Sa nhân	3g (cho vào sau)				

Sắc uống ngày 01 thang

Gia vị tứ thần thang (thiên gia diệu phương, Q.Thượng):

Bổ cốt	12g	Ngô thù du	6g	Nhục đậu khấu	6g
Ngũ vị tử	6g	Bạch truật	10g	Phục linh	10g
Hoàng kỳ	12g	Đảng sâm	12g	Trần bì	6g
Ô mai	3 quả	Thạch lựu bì	6g	Trần bì	6g
Phụ tử chế	6g	Quế chi	6g		

Sắc uống ngày 01 thang

TD: Ôn bổ mệnh môn, kiêm ôn tỳ vị, sấp tràng, trị ruột viêm mạn tính thể tỳ thận dương hư.

Hiệu quả lâm sàng: Lấy “Gia vị tứ thần thang” làm chủ, khi dùng có phần gai giảm. Đã từng chữa nhiều ca viêm ruột mạn, thông thường dùng 3-6 thang là khỏi

Khổ sâm thang (thiên gia diệu phương, Q.Thượng):

Khổ sâm	6-9g	Đương quy	10g	Xích thược	12g
Đại hoàng(chế)	6-9g	Hải táo	15g	Đào nhân	9g
Xuyên phác	5g	Bạch truật(sống)	10g		

Sắc uống ngày 01 thang
Đại tiện lỏng thêm Sơn tra nhục 10g
Đại tiện bí thêm Đại ma nhân 12g.
Tác dụng: Hành khí hóa ứ, thêm thâm thấp nhuần kiên, Trị ruộ viêm mạn tính thể khí trệ thấp trở.

Những bài thuốc kinh nghiệm đơn giản:

- Xa tiền thảo 40g, Rau sam 80g sắc nước uống.
- Vỏ quả thạch lựu 1 quả, đường đỏ 40g sắc uống.

4. Châm cứu:

+ Chọn huyệt: Quan nguyên, Thận du, Thiên khu, Thượng cự hư, Đại trường du, Tỳ du, Trung quản, Túc tam lý.

Nhĩ châm: Vùng đại tràng, tiểu trường, giao cảm, Nội tiết, Thần môn, Trực tràng hạ đoạn, Tam tiêu, mỗi lần chọn 3-5 huyệt.

Thủ pháp: Đối với thể thấp nhiệt dùng tả, thể Can Tỳ bất hòa dùng bình, đối với các thể Tỳ hư và Thận hư dùng phép bổ có thể thêm cứu (Hiệp Đại Nội khoa học).

LƯỢNG GIÁ

Khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:

1. Nguyên nhân gây bệnh viêm đại tràng mạn tính theo YHCT là:
 - A. Do nhiễm phải lục dâm, ăn uống không điều độ
 - B. Do lao động nặng nhọc kéo dài
 - C. Do mất ngủ kéo dài
 - D. Do tư thế làm việc ngồi lâu không đứng dậy
2. Triệu chứng điển hình của viêm đại tràng thể thấp nhiệt là:
 - A. Đại tiện táo kéo dài
 - B. Đại tiện phân toàn nước
 - C. Đại tiện thấy thức ăn chưa tiêu hết
 - D. Đau bụng đại tiện lỏng, phân lẫn máu mũi
3. Triệu chứng điển hình của viêm đại tràng thể tỳ hư là:
 - A. Bụng không đau, không chán ăn
 - B. Bụng sôi liên tục, không thích xoa ấn bụng
 - C. Bụng thường đau, xoa ấn thấy dễ chịu, chán ăn
 - D. Bụng đau dữ dội, đại tiện táo
4. Pháp điều trị viêm đại tràng thể can tỳ bất hòa là:
 - A. Bình can giáng hỏa
 - B. Tả can minh mục
 - C. Bổ can tỳ vị
 - D. Sơ can hòa vị